



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

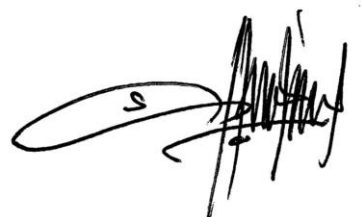
PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1001.1/I-PDM/DIR/XI/2025

Tentang
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Penanggung Jawab :



(Susan Rahmawati, S. Sos)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 03 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengarah:

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes., AFP
2. dr. Ari Putriani, Sp. PK
3. dr. Resti Lestantini, M. Kes

Penyusunan:

1. Susan Rahmawati, S. Sos
2. drg. Endy Wira Pradana, MMRS
3. Puput Sekar Nariratih, Amd. Keb
4. Dwi Novianti, Amd, AK., S. Kes
5. Nur Rizkiah Amalia

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
PERATURAN DIREKTUR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Sasaran	2
1.4 Ruang Lingkup	2
BAB II PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN STAF	3
2.1 Perencanaan Staf	3
2.1.1 Standar Ketenagaan	3
2.1.2 Distribusi Ketenagaan	18
2.1.3 Pengembangan Perencanaan Kebutuhan	26
2.1.4 Prinsip – Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia	27
2.1.5 Proses Pengajuan Ketenagaan	28
2.2 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Staf	28
2.2.1 Penugasan dan Rotasi	28
2.2.2 Proses Pengembangan Karir Staf	29
2.2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	29
2.3 Rekrutmen, Evaluasi dan Pengangkatan Staf	63
2.3.1 Ketentuan Umum	63
2.3.2 Proses Seleksi Staf	63
2.3.3 Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen	64
2.3.4 Proses Pengangkatan Staf	65
2.4 Orientasi Staf	66
2.5 Pengelolaan Staf	68
2.5.1 Sistem Kepegawaian	68
2.5.2 Kontrak Kerja	70
2.5.3 Jabatan Struktural dan Non Struktural	72
2.5.4 Tata Tertib	74
2.5.5 Tunjangan dan Kesejahteraan	94
BAB III KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF	104
3.1 Kompetensi dan Kewenangan Staf Klinis	104
3.1.1 Kompetensi Staf Klinis	104
3.1.2 Kewenangan Staf Klinis	104
3.2 Kompetensi dan Kewenangan Staf Non Klinis	104
BAB IV FILE KEPEGAWAIAN	106
4.1 Ketentuan Umum	106
4.2 Penempatan File Kepegawaian	106
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	107
5.1 Pendidikan dan Pelatihan	107
5.1.1 Ketentuan Umum	107
5.1.2 Ketentuan Khusus	108
5.1.3 Prosedur Pengajuan Pendidikan	108
5.1.4 Pendidikan Formal Staf	108
5.1.5 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	109
5.1.6 Identifikasi Pendidikan dan Pelatihan Staf	109
5.2 Pelatihan Resusitasi Jantung Paru	112

5.2.1 Sasaran	112
5.2.2 Tim Code Blue	112
5.3 Biaya Pendidikan dan Pelatihan	114
5.3.1 Diklat Eksternal Talangan Perusahaan	114
5.3.2 Diklat Eksternal Beasiswa Perusahaan	115
5.3.3 Diklat Internal	116
5.4 Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	117
BAB VI KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF	118
6.1 Ketentuan Umum	118
6.2 Skrinning Kesehatan Awal	118
6.3 Pengendalian Paparan	119
6.4 Tata Laksana Kejadian Staf Cedera	120
6.5 Pelayanan Kesehatan Kerja	121
6.6 Pengelolaan Kesehatan Mental Staf	122
6.7 Kesehatan dan Keamanan Kerja	122
6.8 Pelayanan dan Pengendalian K3 Staf	123
BAB VII TENAGA MEDIS	124
7.1 Kredensial Staf Medis	124
7.2 Pengangkatan Staf Medis	126
7.3 Kewenangan Klinis Staf Medis	126
7.3.1 Penetapan Ulang	126
7.3.2 Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis	126
7.3.3 Proses Pemberian Rincian Kewenangan Klinis	127
7.4 OPPE Staf Medis	127
7.4.1 Ketentuan Umum	127
7.4.2 Ketentuan Khusus	127
7.4.3 Pengertian Penilaian Kinerja	130
7.4.4 Tujuan Penilaian Kinerja	130
7.4.5 Manfaat Penilaian Kinerja	130
7.4.6 Prosedur Penilaian Kinerja	130
BAB VIII TENAGA KEPERAWATAN	131
8.1 Kredensial Staf Keperawatan	131
8.1.1 Mekanisme Kerja Sub Kredensial	131
8.1.2 Tahapan Proses Kredensial Staf Baru	131
8.1.3 Tahapan Proses Rekredensial	132
8.2 Rincian Kewenangan Klinis dan Surat Penugasan Klinis	133
8.2.1 Rincian Kewenangan Klinis (RKK)	133
8.2.2 Surat Penugasan Klinis (SPK)	133
8.3 Penilaian Kinerja Staf Keperawatan	133
8.3.1 Kriteria Penilaian Kinerja	133
8.3.2 Prosedur Penilaian Kinerja	134
BAB IX TENAGA KESEHATAN LAIN	135
9.1 Kredensial Tenaga Kesehatan Lain	135
9.1.1 Proses Kredensial	135
9.1.2 Kajian Mitra Bestari	135
9.1.3 Rekredensial	136
9.2 RKK dan SPK Profesional Tenaga Kesehatan Lain	136
9.2.1 Rincian Kewenangan Klinis (RKK)	136
9.2.1 Surat Penugasan Klinis (SPK)	137
9.3 Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain	137
9.3.1 Kriteria Penilaian Kinerja	137
9.3.2 Prosedur Penilaian Kinerja	137
BAB X PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.1	Kualifikasi Sumber Daya Manusia	3
Tabel 2.2.2.2	Kualifikasi Staf Medis	15
Tabel 2.1.2.1	Waktu Kerja Staf.....	18
Tabel 2.1.4.1	Prinsip – Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia	27
Tabel 2.2.3.1	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Staf.....	29
Tabel 2.3.3.1	Kriteria Penetapan Staf.....	65
Tabel 2.4.1	Orientasi Umum dan Orientasi Khusus	66
Tabel 2.5.1.1	Sistem Penggajian	68
Tabel 2.5.1.2	Golongan Pendidikan	69
Tabel 2.5.3.1	Masa Jabatan Struktural.....	73
Tabel 2.5.3.2	Masa Jabatan Non Struktural	73
Tabel 2.5.4.1	Jenis Cuti	74
Tabel 2.5.4.2	Biaya Penggantian Uang Makan	82
Tabel 2.5.4.3	Tingkatan Sanksi	86
Tabel 2.5.5.1	Besaran Sumbangan Kelahiran.....	96
Tabel 2.5.5.2	Besaran Sumbangan Uang Pernikahan.....	97
Tabel 2.5.5.3	Nominal Hadiah Parcel	97
Tabel 2.5.5.4	Besaran Sumbangan Bencana Alam	97
Tabel 2.5.5.5	Besaran Sumbangan Uang Duka Cita	98
Tabel 2.5.5.6	Nominal Santunan Kematian.....	99
Tabel 2.5.5.7	Jenis Konsumsi Staf	100
Tabel 2.5.5.8	Fasilitas Kamar Rawat Staf	101
Tabel 5.1.6.1	Pendidikan dan Pelatihan Internal.....	110
Tabel 5.1.6.2	Pendidikan dan Pelatihan Eksternal.....	112
Tabel 5.2.2.1	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Code Blue	114
Tabel 5.3.1.1	Ketentuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan	115
Tabel 5.3.2.1	Ketentuan Biaya Diklat Eksternal Beasiswa	116
Tabel 5.3.3.1	Honorarium Pemateri.....	117
Tabel 5.3.3.2	Jasa Pendidikan dan Pelatihan	118
Tabel 6.5.1	Pemberian Makanan Untuk Pejabat Struktural Maupun Fungsional.....	122



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1001.1/I-PDM/DIR/XI/2025

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Prima Husada diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 059.2/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Manajemen SDM sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
- (3) Kegiatan standar adalah satu satuan waktu (atau angka) yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan sesuai dengan standar profesinya.
- (4) Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang tenaga Kesehatan profesional dalam satu tahun kerja sesuai dengan standar profesional dan telah memperhitungkan waktu libur, sakit, dll.
- (5) Daftar susunan pegawai adalah jumlah pegawai yang tersusun dalam jabatan dan pangkat dalam kurun waktu tertentu yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan fungsinya.
- (6) Analisa beban kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu.
- (7) Beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga Kesehatan profesional dalam satu tahun dalam satu sarana pelayanan Kesehatan.
- (8) Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
- (9) Pola Ketenagaan adalah perencanaan kebutuhan staf dalam menghitung jumlah staf yang dibutuhkan rumah sakit dengan mempertimbangkan misi rumah sakit, keragaman pasien, layanan diagnostic dan klinis yang disediakan rumah sakit, volume pasien rawat inap dan rawat jalan, teknologi medis yang digunakan untuk pasien, serta ketentuan perundang – undangan terkait syarat pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman untuk setiap anggota staf, serta ketentuan yang mengatur jumlah staf yang dibutuhkan di setiap unit layanan.
- (10) Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.
- (11) Seleksi adalah serangkaian Langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah diterima atau tidak. Langkah – Langkah ini mencakup pemaduan kebutuhan - kebutuhan kerja

pelamar dan organisasi. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut Employment Function.

- (12) Orientasi adalah suatu program atau kegiatan untuk memperkenalkan staf baru tentang segala sesuatu mengenai institusi dan memahami tanggung jawab pekerjaan dan peran masing – masing untuk mencapai misi institus.
- (13) Penempatan adalah kegiatan mengalokasikan staf pada posisi tertentu sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahlian guna mencapai tujuan. Penempatan juga dapat diatuikan sebagai penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan Kembali staf pada tugas atau jabatan yang berbeda.
- (14) Rotasi adalah perubahan periodik karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya dengan tujuan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi melalui pengakenaragaman kegiatan karyawan.
- (15) Mutasi adalah proses pemindahan karyawan dari satu unit usaha ke unit usaha lainnya.
- (16) Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya dengan tanggung jawab, gaji dan atau fasilitas serta status lebih yang tinggi.
- (17) Demosi adalah pemindahan dari suatu jabatan atau pekerjaan ke jabatan yang lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan.
- (18) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
- (19) Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
- (20) Kredensial adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seorang staf klinis untuk menentukan apakah yang b ersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/ tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit dalm periode tertentu.
- (21) Rekredensial adalah proses re – evaluasi terhadap staf klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
- (22) Kewenangan klinis adalah uraian intervensi staf klinis yang dilakukan berdasarkan kompetensi di area praktiknya.
- (23) Monitoring dan evaluasi adalah proses dengan kegiatan terus menerus mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi tentang sikap, perkembangan professional, hasil dari layanan klinis anggota staf klinis.
- (24) Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.
- (25) Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang beraitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh staf.
- (26) Analisa kebutuahn pendidikan dan pelatihan adalah proses yang berkelanjutan dalam pengumpulan data untuk

menentukan kebutuhan pelatihan, sehingga pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu rumah sakit dalam mencapai tujuannya.

- (27) Resusitasi jantung paru adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab – sebab tertentu yang bertujuan untuk membuka jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali.
- (28) Kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat Kesehatan yang setinggi – tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan Kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat factor yang merugikan Kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.
- (29) Keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat bekerja dan lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung.
- (30) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.
- (31) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SMK3 Rumah Sakit adalah bagian dari manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktifitas proses kerja di Rumah Sakit guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN STAF

Pasal 2

Perencanaan Staf

- (1) Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi terkait perencanaan staf.
- (2) Kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan Pendidikan, kompetensi dan pengalaman staf di unitnya sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan.
- (3) Kebutuhan staf telah direncanakan sesuai dengan :
 - a. Misi rumah sakit
 - b. Populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien
 - c. Layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit
 - d. Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan
 - e. Peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien.

-
- (4) Perencanaan staf meliputi penghitungan jumlah, jenis dan kualifikasi staf menggunakan metode yang diakui sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - (5) Perencanaan staf membahas penugasan dan rotasi/ alih fungsi staf.
 - (6) Efektifitas perencanaan staf dipantau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Staf

- (1) Setiap staf memiliki uraian tugas sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang diidentifikasi memiliki uraian tugas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain :
 - a. Tenaga Kesehatan ditugaskan dibidang manajerial
 - b. Tenaga Kesehatan melakukan dua tugas yaitu di bidang manajerial dan di bidang klinis
 - c. Tenaga Kesehatan yang sedang mengikuti pendidikan dan bekerja dibawah supervisi, maka program pendidikan.
 - d. Tenaga Kesehatan yang diijinkan untuk memberikan pelayanan sementara di rumah sakit.

Pasal 4

Rekrutmen, Evaluasi dan Pengangkatan Staf

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi terkait proses rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidat calon staf dan mekanisme pengangkatan staf di rumah sakit.
- (2) Rumah sakit menetapkan proses yang terpusat, efisien dan terkoordinasi agar terlaksananya proses yang seragam mencakup :
 - a. Rekrutmen staf sesuai kebutuhan rumah sakit
 - b. Evaluasi kompetensi kandidat calon staf
 - c. Pengangkatan staf baru.

Pasal 4

Orientasi Staf

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang orientasi bagi staf baru di rumah sakit.
- (2) Tenaga kesehatan baru diberikan orientasi umum dan orientasi khusus.
- (3) Staf non klinis baru diberikan orientasi umum dan orientasi khusus.
- (4) Tenaga kontrak, mahasiswa diberikan orientasi umum dan orientasi khusus.
- (5) Orientasi diadakan dengan tujuan agar seluruh karyawan mengetahui dengan benar tentang rumah sakit dan memahami tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai misi rumah sakit
- (6) Rumah sakit menetapkan materi orientasi umum tentang :
 - a. Pengenalan Visi, Misi, Falsafah serta Nilai-Nilai Rumah Sakit
 - b. Pengenalan Struktur Organisasi Rumah Sakit

- c. Peraturan Perusahaan
 - d. Tata Tertib Rumah Sakit
 - e. Pengenalan Ruang dan Gedung Rumah Sakit
 - f. Pengenalan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - g. Bantuan Hidup dasar
 - h. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 - i. Kesehatan dan Keselamatan kerja
 - j. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - k. Sasaran Keselamatan Pasien
 - l. Komunikasi Efektif
- (7) Rumah Sakit menetapkan materi orientasi khusus yang meliputi pedoman pengorganisasian unit, pedoman pelayanan unit yang meliputi Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) serta pengenalan unit.

Pasal 5 Pengelolaan Staf

- (1) Direktur menetapkan regulasi terkait pengelolaan staf rumah sakit.
- (2) Pengelolaan staf rumah sakit meliputi :
- a. Sistem kepegawaian
 - b. Jabatan Struktural dan Non Struktural
 - c. Peraturan dan tata tertib
 - d. Tunjangan dan kesejahteraan staf

BAB III KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF

Pasal 6 Kompetensi dan Kewenangan Staf Klinis

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien.
- (2) Para PPA baru dievaluasi pada saat mulai bekerja oleh kepala unit dimana PPA tersebut ditugaskan.
- (3) Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap PPA sesuai uraian tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.

Pasal 7 Kompetensi dan Kewenangan Staf Non Klinis

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi staf non klinis dengan persyaratan jabatan/ posisi.
- (2) Staf non klinis yang baru dinilai kinerjanya pada saat akan memulai pekerjaannya oleh kepala unit dimana staf tersebut ditugaskan.
- (3) Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap staf non klinis sesuai uraian tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit.

BAB IV
FILE KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) File kepegawaian staf distandarisasi dan dipelihara serta dijaga kerahasiannya sesuai dengan kebijakan rumah sakit
- (2) File kepegawaian mencakup:
 - a. Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, kompetensi staf
 - b. Bukti orientasi
 - c. Uraian tugas staf
 - d. Riwayat pekerjaan staf
 - e. Penilaian kinerja staf
 - f. Salinan sertifikat pelatihan didalam maupun diluar rumah sakit yang telah diikuti
 - g. Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi/ imunisasi, hasil medical check up, dan lain-lain.

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9
Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Rumah Sakit menetapkan program pendidikan dan pelatihan staf meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
- (2) Rumah sakit mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dapat memahami pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan
- (3) Rumah Sakit mengidentifikasi kebutuhan pendidikan staf berdasarkan sumber berbagai informasi, mencakup :
 - a. Hasil kegiatan pengukuran data mutu dan keselamatan pasien.
 - b. Hasil analisa laporan insiden keselamatan pasien.
 - c. Hasil survey budaya keselamatan pasien.
 - d. Hasil pemantauan program manajemen fasilitas dan keselamatan.
 - e. Pengenalan teknologi termasuk penambahan peralatan medis baru, keterampilan dan pengetahuan baru yang diperoleh dari penilaian kinerja.
 - f. Prosedur klinis baru.
 - g. Rencana untuk menyediakan layanan baru dimasa yang akan datang.
 - h. Kebutuhan dan usulan dari setiap unit.
- (4) Program pendidikan dan pelatihan telah disusun berdasarkan hasil idetifikasi sumber informasi yang disusun dalam *Training Need Analysis* (TNA) setiap tahunnya.
- (5) Setiap karyawan berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk menjaga dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan
- (6) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diberikan kepada staf rumah sakit baik internal maupun eksternal.
- (7) Rumah sakit telah menyediakan waktu, anggaran dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi semua staf untuk mendapat

kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

- (8) Setiap karyawan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar rumah sakit minimal 20 (dua puluh) jam per tahun
- (9) Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelatihan Resusitasi Jantung Paru

- (1) Rumah sakit menetapkan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar (BHD) pada seluruh staf dan bantuan hidup lanjut bagi staf yang ditentukan oleh rumah sakit.
- (2) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa staf yang mengikuti pelatihan BHD atau bantuan hidup tingkat lanjut telah lulus pelatihan tersebut.
- (3) Materi tentang pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar dan lanjut disesuaikan dengan standard
- (4) Tingkat pelatihan yang ditentukan untuk tiap staf harus diulang berdasarkan persyaratan dan/ atau jangka waktu yang ditetapkan oleh program pelatihan yang diakui atau setiap 2 (dua) tahun jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.

BAB VI

KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

Pasal 11

- (1) Rumah sakit menetapkan program kesehatan dan keselamatan staf.
- (2) Program kesehatan dan keselamatan staf mencakup :
 - a. Skrinning kesehatan awal
 - b. Tindakan – tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya, seperti pajanan terhadap obat – obatan beracun dan tingkat kebisingan yang berbahaya.
 - c. Pendidikan, pelatihan dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman.
 - d. Pendidikan, pelatihan dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja.
 - e. Pendidikan, pelatihan dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel.
 - f. Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.
 - g. Vaksinasi / imunisasi pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
 - h. Pengelolaan kesehatan mental staf, seperti pada saat kondisi kedaruratan penyakit infeksi/ pandemi.
- (3) Rumah sakit mengidentifikasi penularan penyakit infeksi atau paparan yang dapat terjadi pada staf serta melakukan upaya

-
- pengecahan dengan vaksinasi.
- (4) Berdasar atas epidemiologi penyakit infeksi maka rumah sakit mengidentifikasi risiko staf terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi.
 - (5) Rumah sakit melaksanakan evaluasi, konseling dan taat laksana lebih lanjut untuk staf yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi.
 - (6) Rumah sakit mengidentifikasi area yang berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja (*workplace violence*) dan menerapkan upaya untuk mengurangi risiko tersebut.
 - (7) Rumah sakit melaksanakan evaluasi, konseling dan tata laksana lebih lanjut untuk staf yang mengalami cedera akibat tindakan kekerasan di tempat kerja.
 - (8) Rumah sakit berkewajiban mengikutsertakan seluruh karyawan pada program jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII TENAGA MEDIS

Pasal 12 Kredensial Staf Medis

- (1) Rumah sakit menetapkan peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*) yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja dan rekredensial staf medis.
- (2) *Medical Staf Bylaws* akan diatur dalam kebijakan tersendiri.
- (3) Rumah sakit melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk pelayanan diagnostik, konsultasi dan atat laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri di rumah sakit secara seragam.
- (4) Rumah sakit melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti konsultasi kedokteran jarak jauh (*telemedicine*), interpretasi untuk pemeriksaan diagnostic lain : elektrokardiogram (EKG), serta pemeriksaan lain yang serupa.
- (5) Setiap staf medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.
- (6) Rumah sakit melaksanakan verifikasi ke Lembaga/ Badan/ Instansi pendidikan atau organisasi professional yang diakui yang mengeluarkan izin/ sertifikat dan kredensial lain dalam proses kredensial sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
- (7) Rumah sakit memberikan kredensial tambahan kewenangan setelah melakukan verifikasi ijasah atau sertifikat pendidikan dan atau pelatihan ke sumber yang mengeluarkan apabila staf medis yang meminta kewenangan klinis tambahan yang canggih atau subspesialisasi.
- (8) Pelaksanaan kredensial dilakukan oleh komite atau tim yang telah dibentuk Rumah Sakit.

Pasal 13
Pengangkatan Staf Medis

- (1) Pengangkatan staf medis dibuat berdasar atas kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien.
- (2) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/ surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan surat tersebut dan staf medis dapat memberikan pelayanan kepada pasien dibawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang – undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumbernya.
- (3) Untuk staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan supervisi dengan mengatur frekuensi dan supervisor yang ditunjuk serta didokumentasikan di file kredensial staf tersebut.

Pasal 14
Kewenangan Klinis Staf Medis

- (1) Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk kewenangan tambahan
- (2) Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik
- (3) Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan ijazah/ sertifikat.
- (4) Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk cetak atau elektronik (softcopy) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan.
- (5) Setiap staf medis hanya memberikan pelayanan klinis sesuai kewenangan klinis yang diberikan kepadanya.

Pasal 15
OPPE Staf Medis

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses penilaian kinerja untuk penilaian mutu praktik pprofesional berkelanjutan, etik dan disiplin (OPPE) staf medis.
- (2) Penilaian OPPE staf medis memuat 3 (tiga) area, antara lain :
 - a. Perilaku
 - b. Pengembangan professional
 - c. Kinerja klinis (terkait mutu)
- (3) Penilaian OPPE juga meliputi perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempat staf bekerja.
- (4) Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari staf medis dikaji secara objektif dan berdasar atas bukti, jika memungkinkan dilakukan benchmarking dengan pihak eksternal rumah sakit.
- (5) Data dan informasi hasil pemantauan kinerja staf medis sekurang – kurangnya setiap 6 (enam) bulan dilakukan oleh kepala unit, ketua kelompok staf medis, sub komite peningkatan mutu komite medik dan pimpinan pelayanan medis.
- (6) Hasil pengkajian data dan informasi pelayanan klinis, simpulan dan tindakan yang diberikan oleh rumah sakit didokumentasikan

didalam file kredensial staf medis tersebut.

- (7) Jika terjadi kejadian insiden keselamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik maka dilakukan tindakan secara adil (just culture) terhadap staf medis tersebut berdasarkan hasil analisa terkait kejadian tersebut.
- (8) Bila ada temuan yang berdampak pada pemberian kewenangan staf medis, temuan tersebut didokumentasikan ke dalam file staf medis dan diinformasikan serta disimpan di unit tempat staf medis memberikan pelayanan.

Pasal 16 Rekredensial Staf Medis

- (1) Berdasarkan penilaian praktik professional berkelanjutan staf medis, rumah sakit menentukan sedikitnya setiap 3 (tiga) tahun, apakah kewenangan klinis staf medis dapat dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi (berkurang atau bertambah).
- (2) Rumah sakit melaksanakan secara rutin kredensial kepada setiap staf medis dan selalu diperbarui secara periodik
- (3) Pemberian kewenangan klinis tambahan berdasarkan verifikasi dari sumber Badan/ Lembaga/ Institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII TENAGA KEPERAWATAN

Pasal 17 Kredensial Staf Keperawatan

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga keperawatan meliputi :
 - a. Sesuai peraturan dan perundang – undangan.
 - b. Melakukan kredensial terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman, informasi yang ada pada setiap perawat
 - c. Memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber utama
- (2) Rumah Sakit mendokumentasikan pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan dan pengalaman yang diperbaharui di file tenaga keperawatan.
- (3) Rumah Sakit melaksanakan verifikasi ke sumber Badan/ Lembaga/ Institusi penyelenggara pendidikan/ pelatihan yang seragam
- (4) Rumah Sakit melaksanakan dan mendokumentasikan kredensial yang dipelihara pada setiap tenaga keperawatan.
- (5) Rumah sakit menerapkan proses untuk memastikan bahwa kredensial perawat kontrak lengkap sebelum penugasan.

Pasal 18 Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) Staf Keperawatan

- (1) Rumah sakit menetapkan rincian kewenangan klinis perawat berdasar hasil kredensial terhadap perawat.

-
- (2) Rumah sakit menetapkan surat penugasan klinis tenaga perawat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 19
Penilaian Kinerja Staf Keperawatan

- (1) Rumah sakit melakukan penilaian kinerja perawat secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan di rumah sakit.
- (2) Penilaian kinerja tenaga keperawatan meliputi pemenuhan uraian tugas dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempat kerjanya.
- (3) Pimpinan rumah sakit dan kepala unit telah berlaku adil (*just culture*) Ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko.
- (4) Rumah sakit mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan perawat dalam file kredensial perawat.

BAB IX
TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 20
Kredensial Tenaga Kesehatan Lain

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga Kesehatan lainnya meliputi :
 - a. Sesuai peraturan dan perundang – undangan.
 - b. Melakukan kredensial terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman, informasi yang ada pada setiap perawat
 - c. Memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber utama
- (2) Rumah sakit memiliki bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan dan pengalaman yang terbaharui di file tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Rumah Sakit melaksanakan verifikasi ke sumber Badan/ Lembaga/ Institusi penyelenggara Pendidikan/ pelatihan yang seragam.
- (4) Rumah Sakit mempunyai dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap tenaga Kesehatan lainnya

Pasal 21
Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK)
Profesional Pemberi Asuhan Lain.

- (1) Rumah sakit menetapkan rincian kewenangan klinis Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis lainnya berdasar atas hasil kredensial tenaga Kesehatan lainnya.
- (2) Rumah sakit menetapkan surat penugasan klinis kepada tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 22
Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Lain

- (1) Rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit.
- (2) Penilaian kinerja tenaga Kesehatan lainnya meliputi pemenuhan uraian tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempat bekerja.
- (3) Pimpinan rumah sakit dan kepala unit berlaku adil (*just culture*) ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko.
- (4) Rumah sakit mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan tenaga Kesehatan dalam file kepegawaian.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 059.2/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Manajemen SDM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 November 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1001.1/I-PDM/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM)

PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut dengan Personalia adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya manusia khususnya Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang sesuai dengan standar profesi dan mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut harus dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari setiap Satuan Kerja yang ada di rumah sakit.

Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sebuah pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang baik dan bermutu. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit akan membantu setiap staf untuk dapat berkarya sesuai dengan profesi, pendidikan, serta kemampuan yang dimiliki, membantu proses pelayanan pada pasien di rumah sakit sehingga pasien yang datang berobat ke rumah sakit merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berarti pula customer tersebut nantinya akan sebagai sarana dalam mempromosikan rumah sakit. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera Kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarga.

Pendidikan atau pelatihan adalah alat untuk mengubah, maka untuk perubahan yang dapat dilakukan oleh perorangan, group dan organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas. Pelatihan sangat penting dalam rangka mengubah dari yang terlatih menjadi lebih mahir dan dari yang belum terlatih menjadi terlatih.

Dalam manajemen sumber daya manusia juga dibahas tentang pelatihan dan pengembangan sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu penunjang untuk mencapai mutu pelayanan suatu perusahaan menjadi lebih optimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Manajemen SDM adalah digunakan sebagai acuan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia di rumah sakit.

2. Tujuan

Pedoman Manajemen SDM bertujuan untuk :

- a. Membantu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk memberikan pelayanan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rumah sakit.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
- c. Mengoptimalkan efisiensi staf rumah sakit.
- d. Meningkatkan kualitas staf rumah sakit.

1.3 SASARAN

- a. Tercapainya pemenuhan kebutuhan staf Rumah Sakit Prima Husada yang sesuai dengan persyaratan perundang – undangan dan pertimbangan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada
- b. Terwujudnya pelayanan pasien yang professional.

1.4 RUANG LINGKUP

1. Perencanaan dan pengelolaan staf
 - a. Perencanaan staf
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang staf
 - c. Rekrutmen, evaluasi dan pengangkatan staf
 - d. Orientasi staf
 - e. Pengelolaan staf
2. Kompetensi dan kewenangan staf
 - a. Kompetensi dan kewenangan staf klinis
 - b. Kompetensi dan kewenangan staf non klinis
3. File kepegawaian
4. Pendidikan dan pelatihan
 - a. Diklat internal dan eksternal
 - b. Pelatihan resusitasi jantung paru
5. Kesehatan dan keselamatan staf
6. Tenaga medis
 - a. Kredensial staf medis
 - b. Pengangkatan staf medis
 - c. OPPE staf medis
 - d. Rekredensial staf medis
7. Tenaga keperawatan
 - a. Kredensial staf keperawatan
 - b. Rincian kewenangan klinis (RKK) dan surat penugasan klinis (SPK)
 - c. Penilaian kinerja staf keperawatan
8. Tenaga kesehatan lain
 - a. Kredensial tenaga kesehatan lain
 - b. Rincian kewenangan klinis (RKK) dan surat penugasan klinis (SPK) tenaga kesehatan lain

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN STAF

2.1.PERENCANAAN STAF

2.1.1 Standar Ketenagaan

Pimpinan unit layanan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi, kewenangan, keterampilan, penegthuan dan pengalaman staf untuk memenuhi kebutuhan memberikan asuhan kepada pasien.

Kepala unit mempertimbangkan faktor berikut ini untuk menghitung kebutuhan staf.

- a. Misi rumah sakit.
- b. Populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien.
- c. Layanan diagnostic dan klinis yang disediakan rumah sakit.
- d. Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.
- e. Peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien.

Tabel 2.1.1.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi adalah **serangkaian persyaratan, kemampuan, dan karakteristik** yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan pekerjaan atau jabatan tertentu secara efektif.

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Direktur Rumah Sakit		1. Kualifikasi & Pendidikan • Tenaga Kesehatan • S2 Kesehatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun sebagai kepala bidang pelayanan/ penunjang medis • Memiliki kompetensi manajemen rumah sakit	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Pelayanan			
Kepala Bidang Pelayanan Medik		1. Kualifikasi & Pendidikan • Tenaga Kesehatan • S1 Kesehatan 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
IGD	Kepala Instalasi	• Pendidikan • Dokter Umum / Spesialis • STR dan SIP aktif • Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun • STR dan SIP aktif	Depkes 2005
	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS / BTCLS/ PPGD • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Bidan • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • DIII/ DIV/ S1 Kebidanan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi BLS/ BTLS • Sertifikasi PPGD/ PPGDON	
Instalasi Rawat Jalan	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter • Dokter Spesialis • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Depkes 2005

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • ACLS / BTCLS/ PPGD • Sertifikasi Manajemen Bangsal • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Bidan • Fisioterapis • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • DIII/ DIV/ S1 Kebidanan • DIII / DIV Fisioterapis • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • ACLS / BTCLS/ PPGD • Sertifikasi PPGD/PPGDON • Sertifikasi CWCCA • Mempunyai pengalaman di bidang fisioterapy	
Instalasi Rawat Inap	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter • Dokter Spesialis • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Depkes 2005

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • ACLS / BTCLS/ PPGD • Sertifikasi Manajemen Bangsal • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	
	Perawat Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS/ BTLS • Sertifikasi PPGD	
Maternitas	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Bidan • Pegawai tetap • Kebidanan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi APN, CTU • Sertifikasi Midwefiry Update • Sertifikasi PPGDON • Mempunyai pengalaman di bidang kebidanan minimal 2 tahun	Depkes 2005
	Bidan Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Bidan • DIII/DIV Kebidanan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi APN, CTU • Sertifikasi Midwefiry Update • Sertifikasi PPGDON	

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Neonatologi & NICU	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi pelatihan NICU • Sertifikasi BLS/ BHD/ BTLS/ PPGD • Sertifikasi Manajemen Bangsal • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	Depkes 2005
	Perawat Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Bidan • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • DIII/ DIV/ S1 Kebidanan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi NICU/ PICU • Sertifikasi BLS/ BTLS • Sertifikasi PPGD/ PPGDON	
ICU	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter • Dokter Spesialis Anestesi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Depkes 2005

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ICU Dasar 3 bulan • Sertifikasi BLS/ BHD/ BTLS/ PPGD • Sertifikasi Manajemen Bangsal • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi Pelatihan ICU Dasar • Sertifikasi BLS/ BTLS • Sertifikasi PPGD	
IKO	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter • Dokter Spesialis Anestesi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Depkes 2005

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
	Kepala Ruang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • Profesi Ners • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi pelatihan bedah perioperatif • Sertifikasi BLS/ BHD/ BTLS/ PPGD • Sertifikasi Manajemen Bangsal • Mempunyai pengalaman di bidang keperawatan minimal 2 tahun	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi BLS/ BTLS/ PPGD • Sertifikasi Instrumen • Sertifikasi Bedah Perioperatif	
	Perawat Anestesi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • DIII/ DIV/ S1 Keperawatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi BLS/ BTLS • Sertifikasi pelatihan Anestesi	
Kepala Bidang Medik	Penunjang	1. Kualifikasi & Pendidikan • Tenaga Kesehatan • S1 Kesehatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi ACLS • Mempunyai pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Instalasi Farmasi Rumah Sakit	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Apoteker • S1 Apoteker 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang kefarmasian minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Apoteker	1. Kualifikasi & Pendidikan • Apoteker • S1 Apoteker • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 1 tahun	
	Tenaga Tekhnis Kefarmasian	1. Kualifikasi & Pendidikan • Teknik Vokasi Kefarmasian • DIII/ S1 Farmasi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Penyiapan obat • Tidak ada kompetensi khusus	
Laboratorium	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter Spesialis Patologi Klinik • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Analis Kesehatan • Pegawai tetap • DIII Analis Kesehatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi Plebhotomi • Pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Analis Kesehatan • DIII Analis Kesehatan • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi Plebhotomi	

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Radiologi	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Dokter Spesialis Radiologi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Radiografer • DIII Radiologi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang radiologi minimal 2 tahun	
	Pelaksana	• Kualifikasi & Pendidikan • Radiografer • DIII Radiologi • STR dan SIP aktif • Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang radiologi minimal 2 tahun	
Gizi	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Ahli Gizi • Pegawai tetap • DIII/S1 Gizi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi Hazard • Mempunyai pengalaman di bidang gizi minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Ahli Gizi • DIII/S1 Gizi • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Sertifikasi Hazzard	
	Petugas dapur dan Penyaji	1. Kualifikasi & Pendidikan • Boga • SMA / Sederajat 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Rekam Medik	Kepala Instalasi	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perekam Medik • Pegawai tetap • DIII Rekam Medik • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Menguasai ICD 9 dan ICD 10 • Mempunyai pengalaman di bidang Rekam Medik minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perekam Medik • DIII Rekam Medik • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang Rekam Medik minimal 2 tahun	
CSSD & Laundry	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • Pegawai tetap • DIII/S1 Perawat • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana CSSD	1. Kualifikasi & Pendidikan • Perawat • SMA • DIII/S1 Keperawatan • SMA/Sederajat 2. Kompetensi • Sertifikasi pengelolaan alat medis	
	Pelaksana Laundry	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA/Sederajat 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	
Kabid Umum & Keuangan		1. Kualifikasi & Pendidikan • Tenaga Profesional • Pendidikan Minimal S1 berpengalaman 2. Kompetensi • Mempunyai	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
		pengalaman di Rumah Sakit minimal 2 tahun	
Ketatausahaan Dan Humas	Sekretaris	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • S1 Administrasi Bisnis/ S1 Lainnya 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Humas	1. Kualifikasi & Pendidikan • DIII / S1 • SKM / S1 Semua Jurusan 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	
SDM & Diklat	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • Pegawai tetap • S1 Semua Jurusan 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • S1 Semua Jurusan 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun	
Keuangan & Akuntansi	Kasir	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • SMA/ Sederajat 2. Kompetensi • Berpengalaman sebagai staf keuangan	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
SIMRS & IT	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • DIII/S1 Informatika • Sarjana Bidang Informatika 2. Kompetensi • Menguasai teknologi computer dan jaringan	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • Sarjana • DIII/S1 Informatika 2. Kompetensi • Menguasai teknologi computer dan jaringan	
IPSRs	Koordinator	1. Kualifikasi & Pendidikan • ATEM • DIII Teknik Elektromedik • STR dan SIP aktif 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang elektromedik minimal 2 tahun	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA Teknik 2. Kompetensi • Mempunyai pengalaman di bidang elektromedik minimal 2 tahun	
Security	Koordinator	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA / Sederajat 2. Kompetensi • Sertifikasi Gada Pratama • Berpengalaman dibidangnya minimal 2 Tahun • Memiliki kemampuan manajerial	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA / Sederajat 2. Kompetensi • Sertifikasi Gada Pratama	
Cleaning Service	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA / Sederajat 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan • SMA / Sederajat 2. Kompetensi • Tidak memiliki kompetensi khusus	

Unit	Jabatan	Kualifikasi	Dasar Perhitungan Ketenagaan
Driver	Koordinator	1. Kualifikasi & Pendidikan - SMA / Sederajat 2. Kompetensi - Memiliki SIM B1 Umum - Memiliki kemampuan manajerial	
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan - SMA / Sederajat 2. Kompetensi - Memiliki SIM B1 Umum	
Asuransi Centre	Kepala Unit	1. Kualifikasi & Pendidikan - Sarjana - Minimal S1 Berpengalaman 2. Kompetensi - Menguasai ICD 9 & ICD 10 - Mempunyai pengalaman di rumah sakit minimal 2 tahun di bidang asuransi	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
	Pelaksana	1. Kualifikasi & Pendidikan - Perekam Medis - DIII RMIK - STR dan SIP aktif - SMA/Sederajat 2. Kompetensi - Menguasai ICD 9 & ICD 10	

Tabel 2.1.1.2 Kualifikasi Staf Medis

Jabatan	Kualifikasi	Ketersediaan
Dokter Jaga IGD	a. Pendidikan - Dokter Umum b. Kompetensi - ACLS	8
Dokter Gigi Umum	a. Pendidikan - Dokter Gigi b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	1
Dokter Gigi Spesialis	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Gigi Orthodontist b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	4
Dokter Spesialis Anestesi	a. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi	3

	b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 tahun	
Dokter Spesialis Patologi Klinik	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	1
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Patologi Anatomi b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	1
Dokter Spesialis Radiologi	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Radiologi b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	2
Dokter Spesialis Rehab Medik	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Rehab Medik b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	2
Dokter Spesialis Saraf	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Saraf b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	4
Dokter Spesialis Bedah Umum	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Bedah Umum b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Bedah Plastik	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Bedah Plastik b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	1
Dokter Spesialis Orthopedi	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Orthopedi b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Urologi	a. Pendidikan Dokter Spesialis Urologi	2

	b. Kompetensi Pengalaman pekerjaan 2 tahun	
Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Anak	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Anak b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Penyakit Dalam b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	5
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Paru	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Paru b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis Mata	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Mata b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	3
Dokter Spesialis THT	a. Pendidikan - Dokter Spesialis THT b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	2
Dokter Spesialis Jiwa	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Jiwa b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	2
Dokter Spesialis Kulit Kelamin	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Kulit Kelamin b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	2

Dokter Spesialis Bedah Saraf	a. Pendidikan - Dokter Spesialis Bedah Saraf b. Kompetensi - Pengalaman pekerjaan 2 tahun	1
------------------------------	---	---

2.1.2 Distribusi Ketenagaan

1. Waktu Kerja
- Hari dan Jam Kerja
- 1) Hari Kerja adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu atau 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

2) Jam kerja adalah 7 (tujuh) jam dan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

3) Oleh karena kebutuhan, maka pengaturan hari dan jam kerja dapat dilakukan menurut keperluan pelayanan.

4) Dalam jam kerja, pegawai berhak untuk istirahat makan dan sholat selama 1 (satu) jam. Sedangkan khusus untuk dinas jam 21.00 s/d 07.00 WIB istirahat 1,5 (satu setengah) jam.

5) Tempat kerja tidak diperkenankan dalam keadaan kosong, harus ada yang standby.
2. Shift Kerja
- Pada unit kerja tertentu yang memerlukan adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terus berlangsung. Untuk itu diberlakukan pembagian kerja shift dan dalam pelaksanaannya menggunakan kebijakan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tiap satuan waktu kerja shift tidak boleh melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari atau secara akumulasi 40 (empat puluh) jam seminggu, kecuali untuk shift malam.

Tabel 2.1.2.1 Waktu Kerja Staf

N o	Unit	Shift Kerja	Jam Kerja		Jumlah Jam Kerja	Hari Kerja
			Masuk	Pulang		
1	Direktur	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
Pelayanan						
2	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
3	Kepala Bidang Keperawatan	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
4	Instalasi Rawat Inap					
	Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
5	IRNA					
	• Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	• Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	
11	Maternitas					
	• Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	• Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	
12	Perinatologi					
	• Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	
13	Instalasi Gawat Darurat					
	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	
	14	Instalasi Rawat Jalan				
● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur	
	Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur	
	● Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Middle	10.00	18.00	8	
Siang		14.00	22.00	8		
15	Intensive Care Unit					

	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	
17	Instalasi Kamar Operasi					
	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Kepala Ruang	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
		Middle	11.00	19.00	8	
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	07.00	9	
	● Perawat Anestesi	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
		Siang	14.00	22.00	8	
Penunjang						
18	Kepala Bidang Penunjang Medik	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
19	Instalasi Farmasi					
	• Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	• Apoteker	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
		Siang	14.00	22.00	8	
	• Tenaga Tekhnis Kefarmasian	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Middle	10.00	18.00	8	
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	07.00	9	
20	Instalasi Rekam Medik					
	• Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	• Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
	• Pendaftaran	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	07.00	9	
	21	Instalasi Laboratorium				
• Kepala Instalasi		Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
• Kepala Unit		Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur	
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit	
		Middle	10.00	18.00	8		
		Siang	14.00	22.00	8		
		Malam	22.00	07.00	9		
22	Instalasi Radiologi						
	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur	
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur	
	● Kepala Unit	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur	
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur	
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit	
		Middle	10.00	18.00	8		
		Siang	14.00	22.00	8		
		Malam	22.00	07.00	9		
	23	Instalasi CSSD dan Laundry					
	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur	
Non Shift		08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur		
	● Pelaksana CSSD	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit	
		Middle	10.00	18.00	8		
		Siang	14.00	22.00	8		
	● Pelaksana Laundry	Pagi	06.00	14.00	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit	
		Middle	10.00	18.00	8		
		Siang	14.00	22.00	8		
		Malam	22.00	07.00			
24	Instalasi Gizi						
● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur		

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Kepala Unit	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Ahli Gizi	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Middle	10.00	18.00	8	
		Siang	14.00	22.00	8	
	● Quality Control	Pagi	05.30	13.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
	● Dapur dan Penyaji	Pagi	03.00	12.00	9	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	10.00	19.00	9	
	Umum					
25	Kepala Bidang Umum	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
26	Ketatausahaan & Humas	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Sekretaris	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Humas	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur

		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
27	SDM & Diklat					
	● Kepala Unit	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
28	Keuangan dan Akuntansi					
	● Kasir	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	07.00	9	
29	SIMRS & IT					
	● Kepala Unit	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
30	IPSRS					
	● Kepala Instalasi	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.30	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Middle	10.00	18.00	8	
		Siang	14.00	22.00	8	
31	Security					

	Koordinator	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	Pelaksana	Pagi	06.00	14.00	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	06.00	8	
	32	Cleaning Service				
Kepala Unit		Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
Pelaksana		Pagi	06.00	14.00	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	06.00	8	
Cleaning Service area IKO		Pagi	06.00	14.00	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	22.00	8	
		Malam	22.00	06.00	8	
Driver		Pagi	06.00	14.00	8	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
33		Asuransi Centre				
	● Kepala Unit	Non Shift	08.00	16.00	8	Senin – Jum’at Hari besar dan keagamaan libur
		Non Shift	08.00	14.00	6	Sabtu Hari besar dan keagamaan libur
	● Pelaksana	Pagi	06.30	14.00	7.5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Siang	14.00	21.00	7	
34	PIPP	Pagi	06.30	14.00	7,5	Senin – Minggu Libur menyesuaikan unit
		Middle	10.00	18.00	8	
		Siang	14.00	21.00	7	
		Malam	21.00	07.00	10	

2.1.3 Pengembangan Perencanaan Kebutuhan

1. Analisa SDM

a. Analisa Jumlah Sumber Daya Manusia

- 1) Jumlah staf yang masih aktif
- 2) Jumlah staf yang akan pensiun
- 3) Jumlah staf yang akan resign
- 4) Jumlah staf yang harus menjalani pendidikan dan pelatihan
- 5) Jumlah staf yang memiliki pencapaian
- 6) Jumlah staf yang perlu melakukan peningkatan kinerja

b. Analisa Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Kebutuhan Diklat Internal
- 2) Kebutuhan Diklat Eksternal

2. Kualifikasi Umum

- a. Analisa staf didapat dari analisa kebutuhan unit
- b. Hasil analisa diajukan kepada Direktur melalui rapat
- c. Tindak lanjut dari keputusan Direntur RS untuk selanjutnya diajukan kepada Direktur PT

2.1.4 Prinsip – Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1.4.1 Prinsip – Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prinsip	Keterangan
1	Motivasi	1. Dukungan dari atasan dan Direktur dalam mempelajari perilaku, pengetahuan, keterampilan maupun beradaptasi dengan rekan kerja 2. Dukungan dari atasan dan Direktur terhadap program kerja
2	Laporan Kemajuan Program	1. Hasil diperoleh dari pengembangan SDM, dijadikan sebagai bahan informasi untuk membandingkan staf pada saat sebelum mendapatkan
3	Latihan	1. Dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian staf sesuai dengan kebutuhan unit dan kompetensi yang dibutuhkan. 2. Pelatihan yang dilakukan: • Pelatihan internal • Pelatihan eksternal 3. Bukti pelatihan berupa : • <i>Term Of Reference</i> (TOR) • Undangan Pelatihan • Materi pelatihan • Notulensi peatihan • Dokumentasi pelatihan • Sertifikat pelatihan • Evaluasi setelah dilakukannya pelatihan
4	Perbedaan Individu	1. Dilihat dari kemampuan individu terhadap pelatihan yang akan diikuti 2. Dibutuhkan Training Need Analysys untuk menentukan kebutuhan pelatihan

2.1.5 Proses Pengajuan Ketenagaan Sesuai dengan Rencana

1. Rumah sakit menentukan pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan unit
2. Pola ketenagaan didasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur kebutuhan ketenagaan.
3. Kepala unit mengajukan form kebutuhan staf kepada SDM berdasarkan penghitungan yang telah ditentukan dan standar kualifikasi yang ditetapkan.
4. SDM mengelola pengajuan kebutuhan staf untuk selanjutnya diajukan kepada Direktur RS Prima Husada.
5. Pengajuan kebutuhan staf disetujui bila telah mendapat persetujuan dari Direktur Rumah Sakit.
6. Hasil pengajuan kebutuhan staf yang sudah disetujui Direktur Rumah Sakit kemudian diajukan kepada Direktur PT Disa Prima Medika.

2.2 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG STAF

2.2.1 Penugasan dan Rotasi

a. Ketentuan Umum

1. Penugasan/ penempatan bisa meliputi rotasi, mutasi, promosi, demosi.
2. Penugasan/ penempatan staf dilakukan kepada :
 - Staf baru yang telah melaksanakan orientasi khusus
 - Staf yang telah melaksanakan pendidikan/ pelatihan khusus/ berkelanjutan
 - Staf dengan kompetensi sesuai dengan unit yang dibutuhkan.
3. Penugasan/ penempatan di internal rumah sakit menjadi wewenang Direktur Rumah Sakit.
4. Penugasan/ penempatan dilakukan efektif mulai tanggal periode pengajian atau tanggal 26 setiap bulannya.
5. Penugasan/ penempatan bisa dilakukan langsung oleh PT Disa Prima Medika terhadap staf dalam satu holding company.
6. Staf yang dilakukan penugasan/ penempatan di tempat yang baru akan dilakukan evaluasi pada 14 hari masa transisi.
 - Bila staf dinilai tidak mampu melakukan tugasnya maka dapat dikembalikan kepada posisi sebelumnya atau dipindahkan ke unit lain berdasarkan pertimbangan rapat dengan kepala unit dan kepala bidang terkait.
 - Bila staf dinilai mampu melakukan tugasnya maka evaluasi dilanjutkan sampai dengan 3 bulan masa transisi.

b. Proses Penugasan/ Penempatan staf dalam satu Rumah Sakit

1. Staf yang akan dilakukan penugasan/ penempatan diidentifikasi berdasarkan :
 - Kompetensi, kebutuhan pasien atau kekurangan staf
 - Keinginan staf untuk ditempatkan Kembali karena alasan nilai – nilai, kepercayaan dan agama.
 - Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Kepala Bidang mengadakan rapat dengan kepala ruang/ kepala unit untuk menentukan penugasan/ penempatan staf
3. Kepala bidang memberitahukan kepada staf yang bersangkutan terkait penugasan/ penempatan staf

4. Kepala bidang memberikan hasil persetujuan penugasan/ penempatan staf kepada SDM untuk selanjutnya diajukan kepada Direktur
 5. Direktur memberikan Surat Keputusan penempatan staf berdasarkan ketentuan yang disepakati.
- c. Proses Penugasan/ Penempatan Staf dalam satu Holding Company PT Disa Prima Medika
1. Direktur PT Disa Prima Medika merekomendasikan staf untuk ditempatkan di unit usaha lain dalam satu holding company kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada.
 2. Direktur Rumah Sakit Prima Husada melakukan rapat dengan kepala bidan dan kepala unit terkait.
 3. Kepala bidang memberitahukan kepada staf yang bersangkutan terkait rotasi staf.
 4. Direktur memberikan SK penempatan.

2.2.2 Proses Pengembangan Karir Staf

1. Bagian SDM mengidentifikasi kebutuhan peningkatan karir setiap tahunnya.
2. Merangkum staf yang akan mengalami kenaikan karir.
3. Melakukan penilaian kinerja sesuai dengan peningkatan karir melalui kepala unit.
4. Membuat berita acara terkait dengan status perubahan karir.

2.2.3 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tabel 2.2.3.1 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Staf

No	Jabatan	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
1	Direktur Rumah Sakit	1. Uraian Tugas a. Menjalankan dan mematuhi semua perundang – undangan terkait dengan rumah sakit. b. Menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dan standar akreditasi Rumha Sakit. c. Menetapkan regulasi rumah sakit d. Memberikan arahan kebijakan rumah sakit e. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya. f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien selama dilayani di rumah sakit. g. Membuat dan menjalankan program kerja yang disusun dalam rencana strategis tahunan, rapat koordinasi, maupun forum lain. h. Membuat laporan penyelenggaraan operasional rumah sakit secara berkala. i. Menyampaikan laporan secara berkala ke pemilik RS 2. Tanggung Jawab a. Menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap perundang – undangan. b. Menetapkan proses untuk mengelola serta

		mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. c. Menilai dan menyetujui rencana anggaran. d. Menjalankan visi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemilik. e. Menjamin dicapainya akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna. f. Menjamin dicapainya peningkatan citra, pelayanan dan kinerja keuangan rumah sakit setiap tahun. 3. Wewenang a. Menindaklanjuti terhadap semua lapran hasil pemeriksaan badan audit internal maupun eksternal. b. Menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalm implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. c. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit. d. Mengelola dan melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan rumah sakit sesuai dengan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan. e. Menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima.
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis	1. Uraian tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pelayanan medis terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan medis yang baru yang akan bekerja di rumah sakit. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan medis berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian pelayanan medis. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf penunjang medic dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf pelayanan medik dan bekerjasama

		dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan medis kolaborasi dengan kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf pelayanan medis untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di pelayanan medis 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan medis yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala pelayanan medis yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf pelayanan medis terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen pelayanan medis. d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan medis yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan medik yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap
--	--	--

		pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di bagiannya. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala bidang pelayanan medis g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang diberikan dengan pelayanan h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
3	Kepala Bidang Keperawatan	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Merencanakan jumlah dan kategori staf keperawatan sesuai kebutuhan. 2) Merencanakan jumlah dan jenis peralatan keperawatan yang dibutuhkan di unit perawatan sesuai kebutuhan. 3) Merencanakan dan menentukan jenis kegiatan/ asuhan keperawatan yang akan diselenggarakan. b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan. 2) Melaksanakan program orientasi kepada staf perawat baru yang akan bekerja. 3) Memberi pengarahan dan motivasi kepada staf keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai ketentuan/ standar. 4) Mengadakan pertemuan berkala dengan pelaksana perawatan. 5) Mengenal jenis dan kegunaan barang/ peralatan serta mengusahakan pengadaannya sesuai kebutuhan pasien agar tercapai pelayanan optimal. 6) Menyusun permintaan rutin meliputi kebutuhan alat, obat dan bahan lain yang diperlukan. 7) Mengatur dan mengkoordinasi pemeliharaan peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai. 8) Memelihara dan mengembangkan system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kegiatan lain yang dilakukan secara tetap dan benar. 9) Mengadakan kerjasama yang baik dengan kepala unit lain, kepala bidang dan kepala bagian lain.

		10) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antar petugas, pasien dan keluarganya. 11) Membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan serta kegiatan lain. c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian. 1) Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan. 2) Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan, pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan 2. Tanggung Jawab a. Pemenuhan kebutuhan staf perawat di unit perawatan. b. Kelengkapan dan kebenaran asuhan keperawatan. c. Bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan penunjang medik. 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan membimbing pelaksanaan staf keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan. c. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang kepala bidang keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pelayanan medis terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan medis yang baru yang akan bekerja di rumah sakit. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan medis berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian pelayanan medis. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf penunjang medik dan menyeleksi serta membantu

		mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf pelayanan medik dan bekerjasama dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan medis kolaborasi dengan kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf pelayanan medis untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di pelayanan medis 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan medis yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala pelayanan medis yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf pelayanan medis terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen pelayanan medis. d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan medis yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam
--	--	--

		pelaksanaan tugas pelayanan medis. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan medik yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di bagiannya. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala bidang pelayanan medis g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang diberikan dengan pelayanan h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur.
5	Kepala Bidang Umum dan Keuangan	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bagian operasional terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf baru yang akan bekerja di rumah sakit. 4) Menyusun standar, protap, SOP berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian operasional. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf pelayanan medik dan bekerjasama dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan operasional kolaborasi dengan kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di bagian operasional. 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan

		penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan bagian operasional yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf bagian operasional terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen bagian operasional. d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana dibagian operasional. e. Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dibagian operasional, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu bagian operasional e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di bagiannya. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala bagian operasional g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan
--	--	---

		operasional. h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
6	Kepala Instalasi Rawat Inap	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Instalasi Rawat Inap terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan yang bekerja di Instalasi Rawat Inap. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian pelayanan medis. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf di Instalasi Rawat Inap dan bekerjasama dengan SDM. b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf di Instalasi Rawat Inap untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di Instalasi Rawat Inap. 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan medis yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala ruang yang berada dibawah tanggung jawabnya.

		3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Rawat Inap terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab - Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. - Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. - Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen di Instalasi Rawat Inap. - Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis - Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang - Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. - Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. - Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. - Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis - Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di Instalasi Rawat Inap. - Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi Rawat Inap. - Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan - Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
7	Kepala Instalasi rawat Jalan	1. Uraian Tugas - Melaksanakan fungsi perencanaan - Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Instalasi Rawat Jalan terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu,

		keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan yang bekerja di Instalasi Rawat Jalan. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf bagian pelayanan medis. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf di Instalasi Rawat Jalan dan bekerjasama dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf di Instalasi Rawat Jalan untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan. 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan medis yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala ruang yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Rawat Jalan terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya.
--	--	---

		c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen di Instalasi Rawat Jalan. d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di Instalasi Rawat Inap. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi Rawat Jalan. g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
8	Kepala Instalasi Gawat Darurat	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Instalasi Gawat Darurat terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf di Instalasi Gawat Darurat. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara

		berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf di Instalasi Gawat Darurat dan bekerjasama dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf di Instalasi Gawat Darurat untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat. 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala ruang yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Gawat Darurat terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen di Instalasi Gawat Darurat. d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.
--	--	--

		3. Wewenang - Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. - Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. - Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. - Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis - Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di Instalasi Gawat Darurat. - Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi Gawat Darurat. - Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan - Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
9	Kepala Intensive Care Unit	1. Uraian Tugas - Melaksanakan fungsi perencanaan - Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Intensive Care Unit terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. - Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan - Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan yang bekerja di Intensive Care Unit. - Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf di Intensive Care Unit. - Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala - Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf di Intensive Care Unit dan bekerjasama dengan SDM - Melaksanakan fungsi pergerakan - Mengatur dan mengkondisikan seluruh

		kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf di Intensive Care Unit untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di Intensive Care Unit. 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan di Intensive Care Unit yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala ruang dan pelaksana yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Intensive Care Unit terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen di Intensive Care Unit d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan
--	--	--

		kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di Intensive Care Unit. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Intensive Care Unit g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
10	Kepala Instalasi Kamar Operasi	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Instalasi Kamar Operasi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan yang bekerja di Instalasi Kamar Operasi 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf di Instalasi Kamar Operasi. 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf di Instalasi Kamar Operasi dan bekerjasama dengan SDM b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidang lain dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf di Instalasi Kamar Operasi untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di Instalasi Kamar Operasi 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai,

		kepercayaan dan agama staf. 5) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan di Instalasi Kamar Operasi yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu kepala ruang dan pelaksana yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Kamar Operasi terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan semua system administrasi manajemen di Instalasi Kamar Operasi d. Menjamin kelancaran pelayanan mulai dari SDM, sarana dan prasarana baik medis ataupun nonmedis e. Tercapainya pelayanan yang professional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan medis e. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di Instalasi Kamar Operasi. f. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi Kamar Operasi
--	--	--

		g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan h. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur
11	Kepala Instalasi Farmasi	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran di Instalasi Farmasi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf pelayanan medis yang baru yang akan bekerja di rumah sakit. 4) Menyusun standar, protap, SOP pelayanan berkolaborasi dengan seluruh tim/staf di Instalasi Farmasi 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf dan bekerjasama dengan SDM 7) Menyusun jadwal dinas sesuai dnegan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien/unit b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf untuk melaksanakan pelayanan dan asuhan farmasi sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan pasien. 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya. 7) Memecahkan masalah yang timbul di Instalasi Farmasi yang berada di wilayah tanggung jawabnya

		8) Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit 9) Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku 10)Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. 11)Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang berlaku 12)Memusnahkan dan menarik sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan farmasi yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf perawat terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 5) Memecahkan masalah yang timbul di ruang rawat inap yang berada di wilayah tanggung jawabnya 6) Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. d. Kelancaran kegiatan pelayanan dan asuhan farmasi e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan di Instalasi Farmasi f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya. 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan farmasi d. Menandatangani surat dan dokumen yang
--	--	---

		menjadi wewenang kepala ruangan. e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
12	Kepala Instalasi Rekam Medis	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Rekam Medik terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Rekam Medik 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Rekam Medik b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan Instalasi Rekam Medik kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf di Instalasi Rekam Medik untuk melaksanakan pelayanan pasien sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan rekam medik. 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya 7) Mengatur penyimpanan dokumen Rekam Medis c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan di Instalasi Rekam Medik yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Rekam Medik yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Rekam Medik terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab

		a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Krapihan dan Kelengkapan dokumen Rekam Medik. d. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. e. Kelancaran kegiatan pelayanan di Instalasi Rekam Medik f. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan g. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan di Instalasi Rekam Medik. d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan. e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
13	Kepala Instalasi Laboratorium	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Laboratorium terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Laboratorium. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Laboratorium b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan Laboratorium kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf di Instalasi Laboratorium untuk melaksanakan asuhan pelayanan pasien sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan asuhan pasien di Instalasi Laboratorium.

		5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan pasien yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Laboratorium yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Laboratorium terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya c. Kebenaran dan ketepatan pelaporan nilai kritis pasien kepada DPJP. d. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. e. Kelancaran kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium. f. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan g. Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di Instalasinya c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan di Instalasi Laboratorium. d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan. e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
14	Kepala Instalasi Radiologi	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Radiologi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu,

		keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Radiologi. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di Instalasi Radiologi b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan radiologi kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf radiografer untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang pelayanan pasien. 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi radiologi yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Radiologi terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di Instalasinya d. Kelancaran kegiatan pelayanan radiologi e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan radiologi f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya
--	--	---

		3. Wewenang - Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. - Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. - Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan radiolohi - Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi - Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
15	Kepala Instalasi CSSD dan Laundry	1. Uraian Tugas - Melaksanakan fungsi perencanaan - Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi CSSD dan Laundry terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi CSSD dan Laundry. - Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan - Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. - Menyusun program orientasi staf di Instalasi CSSD dan Laundry - Melaksanakan fungsi pergerakan - Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan laundry kolaborasi dengan kepala bidang, kepala bagian dan kepala unit lain. - Melaksanakan orientasi kepada staf baru. - Membimbing staf di unit laundry untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar. - Memberikan laporan berkala tentang pelayanan laundry, termasuk inventarisasi linen di Rumah Sakit - Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. - Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya - Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian - Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan yang telah ditentukan. - Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Unit Laundry yang berada dibawah tanggung jawabnya.

		3) Melakukan supervisi staf di Unit Laundry terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab - Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. - Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. - Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. - Kelancaran kegiatan pelayanan di Unit Laundry - Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan Laundry - Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya 3. Wewenang - Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. - Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. - Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu pelayanan laundry - Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi. - Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
16	Kepala Instalasi Gizi	1. Uraian Tugas - Melaksanakan fungsi perencanaan - Menyusun rencana kerja, program dan anggaran Instalasi Gizi terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Instalasi Gizi. - Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan - Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. - Menyusun program orientasi staf di Instalasi Gizi - Melaksanakan fungsi pergerakan - Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan gizi kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. - Melaksanakan orientasi kepada staf baru. - Membimbing staf gizi untuk melaksanakan asuhan gizi sesuai standar. - Memberikan laporan berkala tentang pelayanan asuhan pasien.

		5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan gizi yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf di Instalasi Gizi yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Instalasi Gizi terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Instalasinya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Instalasinya. c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di Instalasinya. d. Kelancaran kegiatan pelayanan dan asuhan gizi e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan gizi f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di Instalasinya. g. Menjaga proses kontrol mutu gizi pasien 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di Instalasinya. c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu asuhan gizi pasien. d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Instalasi. e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
17	Kepala Unit Ketatausahaan dan Humas	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di Unit Ketatausahaan dan Humas. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf

		berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di Unitnya. b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Membimbing staf untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar. 4) Memberikan laporan berkala tentang tugasnya. 5) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 6) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf di Unit Ketatausahaan dan Humas terkait dengan kewenangan klinisnya. 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di Unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di Unitnya c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di Unitnya d. Kelancaran kegiatan pelayanan. e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di Unitnya 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di Unitnya c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu kegiatan.
--	--	--

		d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala unit e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
18	Kepala Unit SDM dan Diklat	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja staf. 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun program orientasi bagi staf baru yang akan bekerja di rumah sakit. 4) Melakukan pengembangan pegawai melalui pembinaan karakter 5) Melakukan rapat dan pertemuan secara berkala 6) Melaksanakan rekrutmen staf dan menyeleksi serta membantu mengadakan pengadaan perjanjian dengan staf b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan berhubungan dengan SDM kolaborasi dengan kepala bidang, kepala bagian dan kepala unit lain. 2) Membimbing staf untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai standar. 3) Memberikan laporan dan evaluasi yang dilakukan di 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Melakukan proses orientasi staf sesuai dengan peran dan jadwal yang telah ada. 6) Memantau pelaksanaan jadwal dinas, jam efektif dan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7) Berperan dalam proses pendisiplinan staf, pembuatan surat teguran dan peringatan. 8) Ikut serta dalam pengembangan dan pemasaran rumah sakit c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 2) Bekerjasama dengan kepala instalasi/ unit dan manajerial terkait untuk melakukan

		supervisi staf terkait dengan kewenangan klinisnya. 3) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 4) Mecetak surat peraturan yang diperlukan untuk status kepegawaian yang telah ditetapkan. 5) Menetapkan status kepegawaian dengan berkonsultasi dengan direktur 6) Mendistribusikan SK yang dibuat kepada staf yang bersangkutan 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf seluruh unit. b. Kebenaran dan ketepatan penghitungan laporan kehadiran staf dengan tepat c. Kebenaran penilaian kinerja tepat sesuai dengan jadwal 3. Wewenang a. Mengakses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. b. Memberikan pengarahan, teguran, nasehat/pendapat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayana, menganalisa dan mengevaluasi pelayanan yang ditetapkan di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. d. Mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kelancaran operasional di bagiannya. e. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala SDM f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berhubungan dengan SDM g. Menerima tanggung jawab yang didelegasikan oleh Direktur	
19	Kepala Keuangan Akuntansi	Unit dan	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran bagian keuangan terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja di bagian keuangan 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan

		3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kebutuhan unit 4) Menyusun program orientasi staf di bagian keuangan b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan di bagian keuangan kolaborasi dengan kepala bagian/bidang dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Memberikan laporan rutin tentang keuangan 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya. 6) Memecahkan masalah yang timbul di bagian keuangan yang berada di wilayah tanggung jawabnya 7) Mengitung payroll staf 8) Mengikuti rapat dan pertemuan secara berkala c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengevaluasi kinerja dan anggaran bagian keuangan. 2) Melakukan penilaian kinerja dan mutu bagian keuangan yang berada dibawah tanggung jawabnya. 3) Melakukan supervisi staf terkait dengan kinerjanya 4) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 5) Memecahkan masalah yang timbul di bagian keuangan yang berada di wilayah tanggung jawabnya 2. Tanggung Jawab a. Bekerjasama dengan kepala bidang/bagian lainnya atas perencanaan umum perusahaan b. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. c. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. d. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. e. Kebenaran penggajian staf f. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya 3. Wewenang
--	--	---

		a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di ruang perawatan. d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala unit. e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
20	Kepala Unit SIMRS dan IT	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran unit terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan pasien. 4) Menyusun program orientasi staf di unitnya 5) Menyusun rencana kegiatan terkait SIMRS dan IT b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala bagian dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Memberikan laporan berkala 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya. 6) Menginventarisasikan, tenaga, alat dan bahan untuk unitnya 7) Melakukan pemeriksaan jumlah dan kesiapan alat. 8) Mengupayakan efisiensi penggunaan alat 9) Melakukan pemeriksaan jaringan dan SIMRS c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya.

		2) Melakukan supervisi staf terkait dengan uraian tugasnya 3) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 4) Menyimpan dokumen kegiatan, termasuk file kepegawaian staf yang berada di wilayah tanggung jawabnya 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. d. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. c. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Unit SIMRS dan IT d. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
21	Kepala Unit Umum dan Rumah Tangga	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran unit terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan unit. 4) Menyusun program orientasi staf di unitnya 5) Menyusun rencana kegiatan terkait unitnya b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala bagian dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Memberikan laporan berkala 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Mendelegasikan tugas kepada setiap

		stafnya. 6) Menginventarisasikan, tenaga, alat dan bahan untuk unitnya 7) Melakukan pemeriksaan jumlah dan kesiapan alat. 8) Mengupayakan efisiensi penggunaan alat 9) Melakukan pemeriksaan kebersihan, keamanan dan semua kegiatan terkait unitnya. c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 2) Melakukan supervisi staf terkait dengan uraian tugasnya 3) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 4) Menyimpan dokumen kegiatan, termasuk file kepegawaian staf yang berada di wilayah tanggung jawabnya. 2. Tanggung Jawab a. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan di unitnya. c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. d. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya. 3. Wewenang a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. c. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Unit Umum dan Rumah Tangga d. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
22	Kepala Unit Ausransi Centre	1. Uraian Tugas a. Melaksanakan fungsi perencanaan 1) Menyusun rencana kerja, program dan anggaran unit terkait SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, Pendidikan dan Pelatihan Staf, Mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja 2) Menyusun perencanaan kebutuhan staf berdasarkan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan 3) Menyusun jadwal dinas staf sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebutuhan unit.

		4) Menyusun program orientasi staf di unitnya 5) Menyusun rencana kegiatan terkait unitnya b. Melaksanakan fungsi pergerakan 1) Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan kolaborasi dengan kepala bagian dan kepala unit lain. 2) Melaksanakan orientasi kepada staf baru. 3) Memberikan laporan 3 bulanan kepada Direktur 4) Melaksanakan pengaturan penempatan dan penempatan kembali staf berdasarkan kompetensi, kebutuhan atau kekurangan staf dan pertimbangan nilai – nilai, kepercayaan dan agama staf. 5) Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya. 6) Menginventarisasikan, tenaga, alat dan bahan untuk unitnya 7) Melakukan pemeriksaan jumlah dan kesiapan alat. 8) Mengupayakan efisiensi penggunaan alat 9) Melakukan sosialisasi kepada unit terkait yang berhubungan dengan kebijakan dan pelayanan pasien JKN. c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian 1) Mengawasi ketetapan penerapan pedoman INACBGS 2) Menyampaikan dan menjelaskan hasil rapat yang di sampaikan oleh BPJS 3) Melakukan penilaian kinerja dan mutu staf yang berada dibawah tanggung jawabnya. 4) Melakukan supervisi staf terkait dengan uraian tugasnya 5) Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan staf berdasarkan kebutuhan. 6) Menyimpan dokumen kegiatan, termasuk file kepegawaian staf yang berada di wilayah tanggung jawabnya 2. Tanggung Jawab a. Membuat rekomendasi sebuah usulan berkas yang telah diverifikasi layak atau tidak layaknya berkas BPJS. b. Kebenaran atau validitas data hasil setiap verifikasi. c. Kebenaran dan membantu bidang pengelola keuangan jika ada kelompok peminjam yang kurang lancar dan macet. d. Kebenaran dan ketepatan perencanaan kebutuhan staf di unitnya. e. Kebenaran dan ketepatan pengembangan
--	--	--

		elayanan di unitnya. f. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja staf di unitnya. g. Pemeliharaan sarana dan prasarana di unitnya 3. Wewenang a. Berkoordinasi dengan verifikasi serta kepala unit pelayanan BPJS Kesehatan. b. Menentukan sebuah usulan kelompok peminjam layak atau tidak layak. c. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan. d. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas staf di unitnya. e. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala Unit Asuransi Centre. f. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
--	--	---

2.3 REKRUITMEN, EVALUASI DAN PENGANGKATAN STAF

2.3.1 Ketentuan Umum Rekrutmen dan Pengangkatan Staf

1. Rekrutmen dilaksanakan secara terpusat, efisien dan terkoordinasi antara PT Disa Prima dan Rumah Sakit dengan tujuan agar terlaksananya proses rekrutmen yang seragam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kebutuhan rekrutmen berdasarkan atas rekomendasi jumlah dan kualifikasi staf yang dibutuhkan yang mengacuu pada data pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf.
3. Proses rekrutmen dimulai dari pengajuan penambahan staf Rumah Sakit kepada PT Disa Prima Medika.
4. PT Disa Prima Medika menetapkan Tim Rekrutmen untuk melakukan proses rekrutmen.

2.3.2 Proses Seleksi Staf

1. Seleksi dilakukan oleh PT dan Rumah Sakit meliputi:
 - a. Seleksi administratif
 - 1) Surat lamaran
 - 2) Curriculum Vitae
 - 3) Foto copy ijazah legalisir
 - 4) Foto copy STR legalisir
 - 5) Foto copy Transkrip Nilai Akademik
 - 6) Foto copy Naskah Sumpah
 - 7) Foto copy Sertifikat uji kompetensi
 - 8) Foto copy KTP
 - 9) Surat pengalaman kerja, bila ada
 - b. Seleksi kompetensi
 - 1) Tes pengetahuan umum
 - 2) Tes pengetahuan khusus sesuai profesi
 - c. Seleksi psikologi
 - 1) Kraepelin
 - 2) MBTI

- d. Seleksi wawancara
 - 1) Profesi
 - 2) Manajemen
- e. Seleksi Kesehatan
 - 1) Pemeriksaan fisik oleh dokter
 - 2) Tes buta warna
 - 3) HBSAg
 - 4) HIV-Aids
 - 5) Thorax Rontgen
- 2. Biaya seleksi kesehatan ditanggung oleh calon staf
- 3. Penentuan hasil seleksi ditentukan bersama tim seleksi staf dan disetujui oleh Direktur Utama PT.
- 4. Penerimaan staf klinis (dokter, perawat dan staf klinis lainnya) harus melalui proses kredensial sebelum mendapat surat penugasan klinis dari Direktur.

2.3.3 Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen

1. Bagian SDM PT. Disa Prima Medika menerima permintaan dari rumah sakit maupun dari internal organisasi PT. Disa Prima Medika. Pengajuan kebutuhan staf melalui proses berikut :
 - a. Menentukan kebutuhan berdasarkan pola ketenagaan yang diajukan oleh masing – masing Rumah Sakit dan organisasi Perseroan Terbatas
 - b. Pimpinan rumah sakit, kepala bidang maupun bagian mengajukan form kebutuhan staf kepada PT Disa Prima Medika
 - c. Bagian SDM mengelola pengajuan kebutuhan staf untuk selanjutnya diajukan kepada Direktur Utama Perusahaan
 - d. Pengajuan kebutuhan staf disetujui bila telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama Perusahaan
2. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, bagian SDM Rumah Sakit dan SDM PT Disa Prima Medika melakukan publikasi kebutuhan tenaga kerja melalui berbagai channel.
 - a. Website resmi perusahaan dan atau rumah sakit
 - b. Portal lowongan kerja
 - c. Laman social media milik perusahaan dan atau rumah sakit
3. SDM rumah sakit melakukan seleksi berkas lamaran online.
 - a. Berkas dikelompokkan sesuai pekerjaan yang dilamar dan diurutkan berdasarkan kualifikasi dan abjad
 - b. Tim melakukan evaluasi kompetensi kandidat calon staf
 - c. Berkas tidak sesuai standar yang ditentukan diberi tanda
 - d. Seleksi dinyatakan memenuhi syarat dan lanjut ke tahap selanjutnya apabila jumlah pelamar dua kali lipat dari jumlah kebutuhan tenaga
4. SDM rumah sakit menetapkan pelamar yang sesuai dengan kriteria.
5. SDM rumah sakit melakukan verifikasi berkas-berkas untuk kredensial bagi kandidat staf klinis.
6. Bagian SDM melakukan pemanggilan kandidat untuk proses seleksi.
 - a. Pemanggilan dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum hari dilakukan seleksi
 - b. Surat pemanggilan pelamar didistribusikan melalui whatsapp, email dan atau channel teknologi informasi HRIS dengan format yang sudah ditetapkan
 - c. Pelamar diwajibkan membalas surat panggilan sebagai konfirmasi atas diterimanya surat panggilan seleksi

7. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi meliputi wawancara, psikotes, test kompetensi keprofesian/bidang.
 - a. Profiling dilakukan melalui wawancara oleh bagian SDM
 - b. Psikotes diberikan meliputi tes kepribadian, DISC, tes IQ dan tes psikologi lainnya sesuai kebutuhan unit kerja
 - c. Tes kompetensi keprofesian akan dilakukan berupa tes tulis dan wawancara dengan kepala unit kerja
8. Seleksi staf medis melibatkan komite medis di setiap rumah sakit berkoordinasi dengan PT Disa Prima Medika.
9. Seluruh hasil tes diolah oleh bagian SDM untuk kemudian dibuatkan rincian hasil tes.
10. Setelah mendapatkan hasil seleksi, tim seleksi memutuskan kandidat yang lulus seleksi dan dibuat dalam bentuk berita acara.
11. Bagian SDM memanggil kandidat untuk tes kesehatan. Kandidat pegawai diberitahu tentang biaya tes kesehatan yang akan dilakukan.
12. Bila tidak diterima maka diberi surat penolakan untuk kandidat yang tidak lulus seleksi dan untuk kandidat yang lulus dihubungi untuk proses orientasi.

2.3.4 Proses Pengangkatan Staf

- a. Staf Baru
 - 1) Calon staf pegawai yang lolos seleksi dilakukan penetapan penerimaannya oleh Direktur PT
 - 2) Direktur PT memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit berupa SK Penerimaan Staf
 - 3) SK Penempatan staf berisi Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Staf sesuai dengan unit kerja yang ditempatinya.
- b. Staf Lama
 - 1) Penetapan staf/ pengangkatan pegawai tetap dilakukan oleh PT setiap tahun bulan Agustus.
 - 2) Proses penetapan staf lama berdasarkan beberapa kriteria

Tabel 2.3.4.1 Kriteria Penetapan Staf

No	Jenis Pegawai	Kriteria
1	Dokter	- Memiliki - Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
2	Staf Klinis	- Masa kerja minimal 2 tahun - Usia maksimal 35 tahun - Evaluasi kinerja minimal baik - Record IKP / tidak ada SP - Mengisi form persetujuan
3	Staf Non Klinis	- Masa kerja minimal 2 tahun - Usia maksimal 35 tahun - Evaluasi kinerja minimal baik - Tidak ada SP - Mengisi form persetujuan

- 3) Hasil pengolahan data staf diajukan kepada Direktur Rumah Sakit.
- 4) Setelah pengajuan disetujui oleh direktur, selanjutnya diajukan kepada PT.

- 5) Bagian SDM PT membentuk Tim, jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi.
- 6) Seleksi penetapan staf berupa:
 - Seleksi psikologi
 - Seleksi wawancara
- 7) Penetapan dilakukan melalui kesepakatan bersama Tim Seleksi dan disetujui oleh Direktur Utama PT Disa Prima Medika.

2.4 ORIENTASI STAF

2.4.1 Ketentuan Umum

1. Setiap pegawai baru yang dinyatakan lulus seleksi pegawai di lingkungan PT. Disa Prima Medika wajib mengikuti program orientasi pegawai baru
2. Program orientasi pegawai baru diberikan melalui pembekalan secara umum oleh bagian SDM
3. Program orientasi di unit kerja dikoordinir oleh kepala unit kerja masing-masing dengan pengawasan dari bagian SDM
4. Pembekalan orientasi umum dilaksanakan maksimal 1 (satu) minggu
5. Setelah menempuh orientasi umum, pegawai diwajibkan mengikuti orientasi khusus diunit kerja masing-masing selama 12 (dua belas) pekan
6. Selama program orientasi :
 - a. Wajib mengikuti program orientasi secara penuh dan akan dilakukan penilaian
 - b. Mendapatkan jatah libur bulanan sebanyak jumlah hari minggu di bulan berjalan
 - c. Khusus tenaga kesehatan diberikan tambahan 2 (dua) hari izin untuk mengurus surat izin praktik paling lambat pada akhir masa orientasi
 - d. Tenaga kesehatan wajib menyelesaikan pengurusan surat ijin praktik paling lambat akhir masa orientasi
 - e. Belum mendapatkan tunjangan kesehatan dan program jaminan ketenagakerjaan
7. Seluruh peserta orientasi wajib membuat laporan orientasi untuk kemudian disampaikan kepada kepala unit kerja masing-masing
8. Bagian SDM dan kepala unit kerja membuat laporan hasil evaluasi dan penilaian selama masa orientasi pegawai baru
9. Dinyatakan lulus orientasi apabila mendapatkan minimal score sebanyak 80 (delapan puluh) atau predikat baik
10. Hasil orientasi di dokumentasikan dalam file kepegawaian

2.4.2 Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2.4.2.1 Orientasi Umum dan Orientasi Khusus

No	Kegiatan	Orientasi Umum	Orientasi Khusus
1	Materi Orientasi	• Perumah sakitan ➤ Visi, Misi dan Nilai Perusahaan ➤ Struktur organisasi Perusahaan dan Rumah Sakit ➤ Peraturan Perusahaan ➤ Etika dalam bekerja ➤ Tata Tertib Rumah Sakit	• Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. • Panduan dan kebijakan unit • Standar operasional prosedur masing – masing kompetensi • Penilaian dan evaluasi individu.

No	Kegiatan	Orientasi Umum	Orientasi Khusus
		➤ Pengenalan Ruang dan Gedung Rumah Sakit ➤ Pengenalan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ➤ Pelayanan Prima • Program pencegahan dan pengendalian infeksi • Program mutu dan keselamatan pasien • Bantuan Hidup Dasar • Penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran (APAR) • Program keselamatan pasien (khusus rumah sakit dan klinik) • Sasaran Keselamatan Pasien • Komunikasi Efektif • Kompetensi spiritual	
2	Perlengkapan orientasi	• TOR UMANDOK orientasi • Ruang pertemuan dan kelengkapannya	• TOR UMANDOK orientasi • Logbook orientasi • Panduan dan pelayanan unit • SOP unit
3	Pelaksanaan orientasi	• Orientasi umum dilakukan selama 3 hari • Waktu pelaksanaan: jam 08.00 – 16.00	• Orientasi khusus dilakukan selama 12 minggu • Waktu pelaksanaan: mengikuti jam kerja unit masing - masing.
4	Pemakaian seragam		
	• Staf Medis	Bebas rapi, atasan berkerah dan menggunakan jas dokter	Bebas rapi, atasan berkerah dan menggunakan jas dokter
	• Staf Keperawatan	Atasan putih, bawahan hitam	Atasan putih, bawahan putih, hijab putih untuk staf wanita.
	• Staf Klinis Lain	Atasan putih, bawahan hitam, hijab hitam (untuk staf wanita berhijab)	Atasan putih, bawahan hitam, hijab hitam (untuk staf wanita berhijab)
	• Staf Non Klinis	Atasan putih, bawahan hitam, hijab hitam (untuk staf wanita berhijab)	Atasan putih, bawahan hitam, hijab hitam (untuk staf wanita berhijab)
5	Kewajiban staf	• Membuat rangkuman materi	• Mengisi logbook orientasi

No	Kegiatan	Orientasi Umum	Orientasi Khusus
		Menggunakan atribut identitas	Menggunakan atribut identitas

2.5 PENGELOLAAN STAF

2.5.1 Sistem Kepegawaian

a. Ketentuan Umum

- Seluruh pegawai Rumah Sakit Prima Husad ditetapkan system kepegawaiannya melalui system kepegawaian Rumah Sakit Prima Husada.
- Sistem kepegawaian Rumah Sakit Prima Husada berdasarkan atas tingkat pendidikan, masa kerja dan tingkat kompetensi.
- Penetapan status kepegawaian melalui proses – proses kepegawaian : pegawai kontrak, pegawai tetap, kenaikan golongan/ grade, perubahan tingkat golongan, mutasi, rotasi, promosi, demosi.
- Rotasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain tetapi tetap dengan pekerjaan (job family) yang sama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan; status kepegawaian meliputi grade, golongan, maupun tingkat kompetensi tidak berubah.
- Sedangkan mutasi adalah perpindahan pegawai ke unit kerja lain dengan pekerjaan (job family) yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan perusahaan; status kepegawaian meliputi grade, golongan, maupun tingkat kompetensi dapat berubah atau tetap.

b. Status Ketenagaan

Status ketenagaan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja penuh waktu dan diangkat sebagai pegawai dengan surat keputusan pengangkatan oleh Direktur yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur berdasarkan kontrak atau perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban seperti dalam surat kontrak/ perjanjian.
- Pegawai kontrak khusus adalah pegawai yang diangkat secara khussu oleh Direktur karena pertimbangan tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan rumah sakit berdasarkan kontrak atau perjanjian kerjasama jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban seperti tercantum dalam surat kontrak/ perjanjian.
- Pegawai paruh waktu (part time) adalah pegawai yang bekerja secara tidak paruh waktu, mempunyai hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu, dan diangkat dengan surat keputusan pengangkatan resmi yang dikeluarkan oleh Direktur.

c. Sistem Penggajian

Tabel 2.5.1.1 Sistem Penggajian

No	Status Pegawai	Keterangan
1	Pegawai tetap	Sesuai dengan system struktur skala upah dari PT Disa Prima Medika
2	Pegawai kontrak	Sesuai dengan system struktur skala

		upah dari PT Disa Prima Medika
3	Pegawai kontrak khusus	Sesuai dengan system struktur skala upah dari PT Disa Prima Medika
4	Pegawai paruh waktu	Sesuai dengan system struktur skala upah dari PT Disa Prima Medika

1. Penggolongan ruang pegawai tetap
 - a) Pegawai tetap diangkat dengan golongan/ ruang tertentu.
 - b) Golongan/ ruang awal diberikan pada saat pegawai diangkat sebagai pegawai tetap dengan Surat Keputusan Direktur.
 - c) Golongan/ ruang akhir adalah golongan/ ruang setinggi – tingginya yang dapat diapai pegwai tetap selama menjadi pegawai rumah sakit.
 - d) Penetapan golongan/ ruang awal dan akhir pegawai ditentukan atas dasar formasi ketenagaan dan ijazah pegawai yang diakui oleh rumah sakit.
 - e) Golongan/ ruang akhir pegawai dapat berubah apabila menurut pola ketenagaan ini memenuhi syarat untuk dilakukan hal tersebut.
 - f) Ijazah, golongan/ ruang awal dan akhir pegawai tetap ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.5.1.2 Golongan Pendidikan

Ijazah	Golongan/ Ruang	
	Awal	Akhir
SD/ Sederajat	I / A	II / A
SMP/ Sederajat	I / B	II / C
SMU/ Sederajat	II / A	III / A
DIPLOMA III/ Sederajat	II / B	III / C
STRATA – 1/ Sederajat	III / A	IV / A
STRATA – 2/ Sderajat	III / B	IV / C
Dokter umum/ gigi/ Apoteker/ Psikolog/ Akuntan	III / B	IV / B
Dokter Spesialis- 1	III / B	IV / C

2. Masa Kenaikan Golongan/ Ruang
 - a) Masa kenaikan golongan/ ruang/ berkala regular pegawai dilaksanakan pada:
 - 1) Bulan April, untuk pegawai yang mulai bekerja di Rumah Sakit Prima Husada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni.
 - 2) Bulan Oktober, untuk pegawai yang mulai bekerja di Rumah Sakit Prima Husada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember
 - b) Kenaikan gaji berkala pegawai didasarkan atas lama kerja dan kondite kerjanya rata – rata baik, setiap 2 (dua) tahun.
3. Kenaikan golongan/ ruang pegawai didasarkan atas lama kerja dan kondite kerjanya rata – rata baik, dengan ketentuan kenaikan golongan/ ruang regular diberikan kepada pegawai setiap 4 (empat) tahun.

4. Masa Kerja

- a) Masa kerja dipergunakan sebagai salah satu dasar penetapan kenaikan golongan/ ruang dan gaji berkala, yang menurut peraturan Pegawai ini berhak memperoleh kenaikan gaji. Masa kerja dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - 1) Masa kerja efektif, adalah masa kerja riil Pegawai bekerja di rumah sakit
 - 2) Masa kerja golongan, adalah masa kerja sebagai dasar penentuan gaji pokok
- b) Masa dimana Pegawai mengambil izin meninggalkan pekerjaan tanpa gaji (cuti diluar tanggungan) tidak dihitung sebagai masa kerja
- c) Masa yang dipergunakan Pegawai untuk menjalankan tugas belajar dari rumah sakit tetap dihitung sebagai masa kerja
- d) Masa kerja sebagai pegawai kontrak akan diperhitungkan sebagai masa kerja jika pegawai yang bersangkutan tersebut diangkat menjadi pegawai tetap RSPH

d. Mekanisme Perubahan Status Administrasi

Jenis status administrasi :

1. Pegawai Orientasi
Masa pegawai diterima bekerja dengan bimbingan selama kurang lebih 1 sampai dengan 3 bulan.
2. Pegawai Kontrak
Masa setelah orientasi selesai sampai dengan 2 tahun dengan penandatanganan PKWT.
3. Pegawai Tetap
Masa setelah pegawai melalui tahapan 2 kali kontrak dengan penerbitan SK Direktur Pegawai tetap kecuali atas rekomendasi dari pihak yang berwenang

2.5.2 Kontrak Kerja

a. Ketentuan Umum

- 1) Pada umumnya status staf baru di Rumah Sakit Prima Husada adalah kontrak kerja kecuali untuk staf medis dapat diikat dengan perjanjian kerja paruh waktu.
- 2) Staf kontrak wajib menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
- 3) Masa kontrak kerja pertama adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan akumulasi maksimal 5 tahun masa kerja kontrak
- 4) Sebagai komitmen melakukan kontrak kerja, staf kontrak wajib menyerahkan ijazah asli kepada PT Disa Prima Medika yang akan diberikan kembali setelah kontrak kerja selesai atau staf dihentikan karena tidak memenuhi standar penilaian maupun sebab lain yang menyebabkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan dengan catatan staf telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap perusahaan. Hal ini tidak berlaku untuk staf kontrak dokter maupun dokter gigi.
- 5) Pada tiga bulan pertama disebut sebagai masa percobaan kontrak kerja, dan dilakukan penilaian. Bila dalam penilaian didapatkan kurang memenuhi standar maka staf dapat dihentikan kontrak kerjanya secara sepihak tanpa tuntutan apapun kepada PT Disa Prima Medika.

- 6) Masa kerja satu tahun pertama tidak diperkenankan hamil/cuti melahirkan.
- 7) PT Disa Prima Medika selalu melakukan evaluasi terhadap staf kontrak sebelum selesainya masa kontrak berakhir dan dituliskan dalam berita acara evaluasi kontrak kerja oleh tim evaluasi kontrak kerja
- 8) PT Disa Prima Medika dan staf kontrak dapat melakukan pengajuan tidak memperpanjang masa kontrak maksimal pada 3 (tiga) bulan sebelum kontrak berakhir
- 9) Pengajuan tidak memperpanjang kontrak yang diajukan kurang dari 3 bulan sebelum berakhir masa kontrak tidak akan diproses
- 10) Gaji staf kontrak terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- 11) Dokter paruh waktu hanya diberikan jasa pelayanan sesuai dengan jasa yang telah ditentukan di perjanjian kerja
- 12) Gaji pokok staf kontrak tidak lebih besar dari staf tetap untuk kualifikasi yang sama.
- 13) Staf kontrak didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- 14) Khusus program BPJS Kesehatan wajib didaftarkan/mutasi menjadi BPJS Kesehatan Badan Usaha karena telah masuk ke dalam kategori pekerja penerima upah. Tidak berlaku untuk dokter yang BPJS Kesehatannya telah terdaftar sebagai pekerja penerima upah di instansi lainnya.
- 15) Besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibebankan kepada karyawan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- 16) Sesuai peraturan yang berlaku, maka upah yang dilaporkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan minimal adalah sejumlah Upah Minimum Kabupaten / Kota setempat.
- 17) Staf kontrak yang tidak memperpanjang kontraknya, maka PT Disa Prima Medika tidak berkewajiban memberikan pesangon dalam bentuk apapun.
- 18) Staf kontrak dengan masa kerja minimal 2 tahun dapat diusulkan untuk diangkat sebagai staf tetap sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku

b. Ketentuan Khusus

- 1) Staf wajib menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- 2) PKWT berlaku selama 1 tahun, dan bisa diperpanjang 2 (dua) kali kecuali dengan rekomendasi dari PT atau Direksi.
- 3) Gaji dokter kontrak diatur tersendiri dalam peraturan tentang gaji dokter.
- 4) Semua staf diikutkan BPJS Kesehatan.
- 5) Bila staf selesai kontrak dan tidak diperpanjang lagi atau PHK, maka Rumah Sakit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon dalam bentuk apapun.
- 6) Staf kontrak yang telah dinilai tetapi tidak memenuhi standar penilaian kinerja, maka tidak dapat diperpanjang kontraknya.
- 7) Staf dalam masa kontrak yang mengundurkan diri maka berkewajiban membayar penalty sebesar kekurangan masa

kontrak dikali total gaji. Contoh pegawai keluar pada 7 bulan masa kontrak maka nilai penalty adalah 5 kali total gaji.

2.5.3 Jabatan Struktural dan Non Struktural

a. Ketentuan Umum

- 1) Setiap pegawai akan menduduki jabatan baik struktural maupun non structural selama bekerja.
- 2) Jabatan structural adalah jabatan tertentu yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan structural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi
- 3) Jabatan non structural yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi. Tetapi memiliki fungsi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi
- 4) Jabatan structural hanya diberikan kepada pegawai tetap
- 5) Setiap posisi jabatan memiliki uraian jabatan yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, kualifikasi, hasil kerja yang diharapkan dan aspek lainnya yang berkaitan dengan jabatan
- 6) Pejabat sementara atau pelaksana tugas baik jabatan structural maupun non structural dapat diberikan kepada pegawai sebagai berikut :
 - a) Pegawai kontrak
 - b) Pegawai tetap yang belum diuji kemampuannya dalam mengemban tugas jabatan namun memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang baik
 - c) Masa jabatan pegawai sementara adalah 1 (satu) tahun atau lebih bila pegawai tersebut belum diangkat sebagai tetap
- 7) Setiap pegawai akan mendapatkan tunjangan jabatan yang masuk dalam komponen tunjangan tetap. Tunjangan jabatan melekat pada jabatan yang diemban, bukan pada personilnya.
- 8) Besar nominal tunjangan jabatan ditentukan dalam keputusan direktur mengenai struktur dan skala upah yang dievaluasi dari waktu ke waktu
- 9) Kebutuhan akan jabatan structural harus sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Disa Prima Medika
- 10) Jabatan Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama PT Disa Prima Medika
- 11) Pegawai yang menduduki jabatan structural di kantor pusat PT Disa Prima Medika diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama PT Disa Prima Medika
- 12) Pegawai yang menduduki jabatan structural di Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit
- 13) Pemilihan sumber daya manusia yang akan menduduki jabatan structural maupun non structural melalui mekanisme rapat di tingkat direksi dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, kemampuan, kompetensi, prestasi pegawai yang akan dipilih
- 14) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan structural dan non structural dibuat dalam bentuk Keputusan Direktur

- 15) Selama 3 (tiga) bulan pertama, pejabat baru baik structural maupun non struktural diberikan tunjangan jabatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dari nilai tunjangan jabatan yang seharusnya diterima
- 16) Untuk jabatan dengan skema promosi, nilai 80% (delapan puluh persen) tunjangan jabatan pejabat baru tidak boleh lebih rendah dari tunjangan jabatan sebelumnya. Jika lebih rendah, maka diterimakan tunjangan jabatan sebelumnya.
- 17) Apabila pegawai memiliki jabatan rangkap, maka tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan jabatan tertinggi. Sedangkan jabatan yang dirangkap akan diberikan berupa jasa pelayanan dengan nominal yang ditentukan oleh direktur utama PT Disa Prima Medika
- 18) Setiap tahun akan diadakan evaluasi dengan konsekuensi akan dilanjutkan untuk menjabat atau diberhentikan.

b. Jabatan Struktural

Tabel 2.5.3.1 Masa Jabatan Struktural

No	Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur rumah sakit	5 tahun
2	Kepal Bidang Pelayanan/ Penunjang Medis	3 tahun
3	Kepala Bidang Keuangan dan Umum	3 tahun
4	Kepala Instalasi	3 tahun
5	Kepala Ruang / Unit Kerja	3 tahun
6	Pejabat sementara	1 tahun (maksimal)

c. Jabatan Non Struktural

- 1) Masa jabatan untuk jabatan non structural ditetapkan sesuai kebutuhan
- 2) Bila diperlukan penyesuaian jabatan karena perubahan struktur organisasi sehingga pejabat structural maupun non structural mendapatkan tugas jabatan tambahan sesuai dengan struktur organisasi yang baru maka masa jabatan yang digunakan adalah masa jabatan sebelumnya. Sebaliknya bila jabatan yang diberikan merupakan jabatan baru yang tidak ada kaitannya dengan jabatan sebelumnya, maka lama masa jabatan dimulai pada saat surat keputusan pengangkatan jabatan ditetapkan.

Tabel 2.5.3.2 Masa Jabatan Non Struktural

No	Jabatan	Masa Kerja
1	Ketua Komite Medik	3 tahun
2	Ketua Komite Keperawatan	3 tahun
3	Ketua Komite PPI	3 tahun
4	Ketua Komite PMKP	3 tahun
5	Ketua Komite Etik	3 tahun
6	Ketua Komite Farmasi dan Terapi	3 tahun
7	Ketua P2K3RS	3 tahun
8	Ketua Tim TB Dots	3 tahun
9	Ketua Tim Ponek	3 tahun
10	Ketua Tim Geriatri	3 tahun
11	Ketua Tim HIV	3 tahun

12	Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya	3 tahun
13	Ketua Tim Anti Fraud	3 tahun

2.5.4 Tata Tertib

a. Libur dan Cuti

1. Libur

- a) Yang dimaksud hari libur adalah :
- 1) Hari minggu atau hari ke 7 (tujuh) dalam enam hari kerja terus menerus

2) Libur berdasarkan pola shift yang ditetapkan

3) Hari libur nasional dan hari lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pada setiap tahun
- b) Hari libur nasional dan hari lainnya yang ditetapkan pemerintah yang jatuh bertepatan dengan gari minggu, tidak mendapatkan penggantian libur di hari lain
- c) Pegawai yang menjalankan shift malam (kode C2) selama 2 (dua) hari berturut- turut dalam seminggu mendapat 1 (satu) kali off luaran selain hari libur mingguan
- d) Tenaga kerja dengan status orientasi hanya mendapatkan jatah libur sesuai jumlah hari minggu pada bulan berjalan.

2. Cuti

Tabel 2.5.4.1 Jenis Cuti

No	Jenis Cuti	Keterangan
1	Cuti Tahunan	1. Pegawai mendapatkan hak cuti tahunan apabila telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut 2. Cuti tahunan diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun 3. Hari libur resmi yang beririsan dengan waktu cuti tidak dihitung sebagai hari cuti 4. Cuti dapat diambil maksimal 2 (dua) hari berturut-turut 5. Cuti yang digabungkan dengan hari libur lebaran dapat diambil selama maksimal 3 (tiga) hari untuk pegawai domisili jawa timur dan 4 (empat) hari untuk pegawai dengan domisili di luar jawa timur 6. Batas waktu penggunaan cuti adalah tanggal 31 Desember setiap tahunnya 7. Cuti yang tidak digunakan sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan hangus dan tidak ada penggantian dalam bentuk apapun 8. Penggunaan cuti tidak boleh sampai mengganggu pelayanan 9. Pegawai yang mengambil hak cuti tahunan tetap diperhitungkan sebagai hadir dan tidak ada pemotongan kehadiran dalam gaji
2	Cuti Masa Bakti	1. Pegawai dengan masa bakti / masa kerja tertentu diberikan cuti tambahan diluar cuti

		tahunan 2. Cuti masa bakti hanya diberikan di tahun ketika masa kerja tercapai 3. Pegawai dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun mendapat cuti 6 (enam) hari kerja 4. Pegawai dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun mendapat cuti 12 (dua belas) hari kerja 5. Pegawai dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun mendapat cuti 12 (dua belas) hari kerja 6. Pegawai dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun mendapat cuti 12 (dua belas) hari kerja 7. Batas penggunaan cuti masa bakti adalah mulai masa kerja yang ditentukan tercapai dan dapat digunakan selama satu tahun (dihitung dari masa kerja bukan berakhirnya tahun kalender)																				
3	Cuti Penting	1. Yang dimaksud dengan cuti penting adalah cuti yang diambil yang disebabkan oleh adanya keperluan-keperluan penting yang diperbolehkan oleh perusahaan. Cuti penting diatur oleh perusahaan sebagai berikut : 2. Jenis cuti penting<table><tr><th>Keterangan</th><th>Lama Cuti</th></tr><tr><td>Menikah</td><td>3 hari</td></tr><tr><td>Istri melahirkan atau keguguran</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>Suami, istri atau anak meninggal</td><td>3 hari</td></tr><tr><td>Orang tua kandung meninggal</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>Saudara kandung meninggal</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>Mertua atau saudara dalam satu rumah meninggal dunia</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>Perkawinan atau khitanan anak</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>Perkawinan saudara kandung</td><td>1 hari</td></tr><tr><td>Pembaptisan anak</td><td>1 hari</td></tr></table> 3. Penggunaan cuti penting harus dibuktikan dengan dokumen atau bukti pendukung yang sah.	Keterangan	Lama Cuti	Menikah	3 hari	Istri melahirkan atau keguguran	2 hari	Suami, istri atau anak meninggal	3 hari	Orang tua kandung meninggal	2 hari	Saudara kandung meninggal	2 hari	Mertua atau saudara dalam satu rumah meninggal dunia	2 hari	Perkawinan atau khitanan anak	2 hari	Perkawinan saudara kandung	1 hari	Pembaptisan anak	1 hari
Keterangan	Lama Cuti																					
Menikah	3 hari																					
Istri melahirkan atau keguguran	2 hari																					
Suami, istri atau anak meninggal	3 hari																					
Orang tua kandung meninggal	2 hari																					
Saudara kandung meninggal	2 hari																					
Mertua atau saudara dalam satu rumah meninggal dunia	2 hari																					
Perkawinan atau khitanan anak	2 hari																					
Perkawinan saudara kandung	1 hari																					
Pembaptisan anak	1 hari																					
3	Cuti Sakit	1. Penggunaan cuti/istirahat sakit harus melampirkan bukti berupa surat keterangan sakit yang diberikan oleh dokter 2. Staf yang merasakan nyeri haid pada hari pertama dan kedua dapat diberikan cuti																				

		sakit selama dibuktikan dengan surat keterangan dokter - Cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun, selama cuti sakit staf tetap diberikan upah dengan ketentuan sebagai berikut : - Empat bulan pertama mendapatkan gaji penuh - Empat bulan berikutnya tanpa jeda dari cuti sebelumnya mendapat 75% dari gaji - Empat bulan berikutnya tanpa jeda dari cuti sebelumnya mendapat 50% dari gaji - Untuk bulan selanjutnya mendapat 25% gaji sampai sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan - Upah yang diperhitungkan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. - Cuti sakit dalam waktu yang lama diberikan berdasar surat keterangan dari dokter di lingkungan PT Disa Prima Medika - Staf yang cuti sakit dalam waktu lama dan telah bekerja selama kurang dari 4 (empat) minggu lalu mendapat cuti sakit kembali, maka cuti tersebut dianggap bersambung dan akumulasi kedua cuti sakit tidak dapat diberikan untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun - Staf yang menjalani cuti sakit dalam waktu lama namun terdapat jeda antara cuti sakit, maka diberikan upah penuh - Staf dan perusahaan wajib menghormati cuti sakit berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh dokter yang berwenang
4	Cuti Terkait Kehamilan	- Cuti melahirkan diberikan 3 bulan dengan pembagian 1,5 bulan sebelum hari perkiraan lahir dan 1,5 bulan setelah melahirkan - Cuti melahirkan diajukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum hari cuti yang akan diajukan dengan melampirkan surat keterangan perkiraan melahirkan dan hasil USG yang sudah disetujui oleh Kepala Bidang terkait - Cuti keguguran diberikan setelah keguguran dibuktikan dengan surat keterangan dokter - Kehamilan trimester 1 : edasarkan surat dokter - Khamilan trimester 2 dan 3 : 1,5 bulan - Selama menjalani cuti terkait kehamilan, pegawai tetap mendapatkan upah - Upah yang diperhitungkan adalah gaji

		pokok dan tunjangan tetap
5	Cuti Ibadah Keagamaan	1. Yang termasuk dalam cuti ibadah keagamaan yang diakui oleh PT Disa Prima Medika adalah haji, umroh dan ziarah paket holyland. 2. Perjalanan ibadah umroh atau paket Holyland tidak mengurangi jatah cuti tahunan dan hanya diperkenankan bagi karyawan dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun. 3. Perjalanan umroh dan ziarah Holyland diberikan dengan masa cuti paling lama 12 (dua belas) hari. 4. Cuti umroh dan atau haji hanya diberikan sekali selama bekerja. Perjalanan ibadah kedua dan seterusnya mengurangi jatah cuti tahunan dan dikenakan cuti diluar tanggungan untuk ketidakhadiran yang melebihi jatah cuti tahunan. 5. Cuti ziarah holyland diberikan maksimal 2 (dua) kali selama bekerja. Perjalanan ibadah pertama dan kedua dengan jeda minimal 5 (lima) tahun. Perjalanan ibadah ketiga dan seterusnya atau apabila perjalanan kedua belum berjarak 5 tahun dari perjalanan pertama maka mengurangi jatah cuti tahunan dan dikenakan cuti diluar tanggungan untuk ketidakhadiran yang melebihi jatah cuti tahunan. 6. Cuti Ibadah haji, diberikan untuk staf dengan masa kerja minimal 10 tahun dan hanya diberikan sekali selama bekerja. Apabila belum mencapai 10 tahun masa kerja atau untuk keberangkatan kedua dan seterusnya, maka diberlakukan cuti diluar tanggungan selama 40 hari. Pengajuan cuti haji dilakukan maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya.
6	Cuti Diluar Tanggungan	1. Staf dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun atau pegawai yang jatah cuti tahunannya telah habis dapat mengambil cuti diluar tanggungan untuk keperluan-keperluan yang tidak diakomodir oleh cuti penting 2. Cuti diluar tanggungan diberikan dengan dibuktikan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Cuti diluar tanggungan dihitung sebagai komponen pengurang upah yang besarnya ditentukan dalam struktur dan skala upah 4. Karena beberapa kondisi tertentu staf dapat mengambil cuti diluar tanggungan dalam waktu lama dan tidak mendapatkan

		upah selama mejalani cuti diluar tanggungan 5. Cuti diluar tanggungan dalam waktu lebih dari satu bulan yang disetujui direktur perusahaan tidak mendapatkan upah bulanan. Misal izin belajar, izin berobat/sakit yang melebihi 1 (satu) tahun.
--	--	---

b. Penampilan Profesional

1. Seragam Kerja

- a) Perusahaan memberikan seragam kerja maksimal 2 (dua) pasang setiap tiga tahun.
- b) Biaya seragam ditanggung bersama oleh perusahaan dan pegawai dengan pembagian beban masing-masing 50%
- c) Selain seragam yang dibagikan, pegawai dapat membeli seragam melalui koperasi karyawan dengan biaya 100% ditanggung pegawai
- d) Warna, model dan bentuk seragam ditentukan oleh perusahaan
- e) Selama hari dan jam kerja pegawai wajib menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan
- f) Pegawai dilarang mengganti, mengubah bentuk, model dan warna pakaian kerja dan perlengkapannya
- g) Seragam wajib dikembalikan kepada perusahaan setiap masa pakai sudah habis atau pegawai mengundurkan diri

2. Standar Penampilan Profesi

a) Sopan Santun

- 1) Selalu menyambut pelanggan dengan bersahabat
- 2) Senyum tulus dan perkenalkan diri
- 3) Jangan biarkan pelanggan merasa diabaikan
- 4) Pertahankan kontak mata, postur menghadap pelanggan, menghentikan sementara telephone saat pelanggan memerlukan respon
- 5) Miliki humor yang positip, magic word bila sudah kenal lama.
- 6) Penuhi kebutuhan pelanggan atau dengan senang hati antarkan pelanggan kepada petugas yang dapat memenuhi kebutuhannya
- 7) Ucapkan terimakasih kepada pelanggan karena telah memilih perusahaan kita untuk memenuhi kebutuhannya

b) Penampilan

- 1) Selalu menyambut pelanggan dengan bersahabat
- 2) Senyum tulus dan perkenalkan diri
- 3) Jangan biarkan pelanggan merasa diabaikan
- 4) Pertahankan kontak mata, postur menghadap pelanggan, menghentikan sementara telephone saat pelanggan memerlukan respon
- 5) Miliki humor yang positip, magic word bila sudah kenal lama.

-
- 6) Penuhi kebutuhan pelanggan atau dengan senang hati antarkan pelanggan kepada petugas yang dapat memenuhi kebutuhannya
 - 7) Ucapkan terimakasih kepada pelanggan karena telah memilih perusahaan kita untuk memenuhi kebutuhannya
- c) Sepatu/alas kaki
- 1) Warna dasar hitam
 - 2) Bersih sesuai warna dasarnya
 - 3) Sepatu harus pas di kaki saat dipakai (tidak kekecilan atau kebesaran)
 - 4) Saat berjalan sepatu tidak diseret namun dengan langkah tegap
 - 5) Tidak berbau
 - 6) Tidak berlubang
 - 7) Tidak menimbulkan bunyi yang nyaring
 - 8) Tidak mengenakan sandal saat bekerja kecuali di ruangan khusus
- d) Kebersihan Badan
- 1) Tidak bau badan dan bau mulut
 - 2) Menggunakan parfum yang tidak menyengat
 - 3) Kuku pendek, bersih dan tidak dicat
- e) Aksesoris dan Tanda Pengenal
- 1) Staff medis dan atau yang kontak langsung dengan pasien tidak diperkenankan memakai cincin, gelang serta perhiasan lain
 - 2) Menggunakan name tag sesuai standar selama bekerja
 - 3) Bagi karyawan dengan gangguan penglihatan menggunakan kaca mata dengan pilihan frame berwarna coklat, hitam, silver, biru. Diperkenankan menggunakan softlens dengan warna bening atau coklat

3. Komunikasi

- a) Dalam percakapan, selalu ucapkan “silakan”, “terimakasih”, “Bapak”, “Ibu” “Mohon tunggu”
- b) Berusaha mendengar aktif: nonverbal yang tepat dalam kontak mata, anggukan, menggumam. Respon Verbal: jangan memutus pembicaraan, bila perlu ulangi ungkapan klien untuk memperjelas/klarifikasi.
- c) Usahakan memberi informasi, dimana Anda memandang itu diperlukan bagi pelanggan.
- d) Semua karyawan harus paham cara mengoperasikan telepon di bagian masing-masing
- e) Menghargai lawan bicara telephone, menerima telephone dengan salam, menyebutkan nama dan apa yang bisa dibantu, bicara seperlunya dalam telephone.
- f) Saat mentransfer panggilan telepon, selalu sebutkan nomer extension yang seharusnya kepada pelanggan, menjaga seandainya sambungan terputus.

-
- g) Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai ketika memberikan informasi kepada pasien mengenai kesehatan, diet khusus, prosedur, obat-obatan, dan seterusnya. Hindari istilah-istilah profesional atau teknis
 - h) Dilarang mendiskusikan informasi tentang pelanggan ataupun tentang perusahaan di area publik seperti di lift, lobby, kantin, atau ruang tunggu
4. Panggilan Pelanggan
- a) Seluruh pegawai wajib menjawab panggilan pelanggan terutama pasien dan membantu memberitahu petugas yang berkepentingan
 - b) Perawat ruangan, wajib segera mendatangi pasien yang memencet bel, menyebut nama pasien tersebut dan tanyakan, "Bisa saya bantu?"
 - c) Cek pasien 1 jam sebelum pergantian shift untuk meminimalkan panggilan pasien pada saat serah terima
5. Komitmen Terhadap Rekan Kerja
- a) Perlakukanlah Rekan Kerja sebagai profesional dengan kebaikan hati, jujur, dan respek. Sambutlah karyawan baru.
 - b) Tunjukkan kepedulian. Hindari permintaan mendadak yang akan menyebabkan ketidaknyamanan Rekan Kerja.
 - c) Dilarang mempermalukan Rekan Kerja dihadapan orang lain
6. Pasien Yang Menunggu
- a) Ciptakan suasana yang nyaman bagi pasien yang menunggu
 - b) Waktu tunggu pasien dengan perjanjian adalah 10 menit; tanpa perjanjian, 1 jam.
 - c) Sampaikan permintaan maaf bila ada penundaan, dan selalu ucapkan pada pelanggan tersebut "Terimakasih telah menunggu"
 - d) Ketika pasien sedang dilakukan tindakan, informasikan keadaannya kepada keluarga pasien secara berkala, minimal setiap 1 jam.
7. Etika di Lift
- a) Gunakan kesempatan di lift untuk membuat kesan baik. Senyum dan sapa pelanggan yang berada dalam lift
 - b) Ketika mentransport pasien dengan kursi roda, selalu hadapkan pasien ke arah pintu dan hati-hati waktu keluar lift. Ketika mentransport pasien dengan brankar atau bed, mintalah dengan sopan agar pengunjung lain dapat menggunakan lift lainnya
 - c) Pada waktu Anda mengantar seseorang, tahanlah pintu lift dan persilakan tamu tersebut masuk lebih dulu. Ketika meninggalkan lift, tahanlah pintu lift jika memungkinkan
 - d) Dilarang menggunakan lift bila tidak membawa barang / peralatan yang berat. Lift digunakan apabila perpindahan melebihi 1 lantai dan atau tidak ada akses lainnya

8. Privasi Pelanggan

- a) Komunikasi melalui telepon dengan pelanggan dilakukan dengan bijaksana
- b) Tutuplah tirai atau pintu sewaktu dilakukan pemeriksaan, tindakan atau kapanpun diperlukan
- c) Sediakan baju pasien dengan ukuran yang sesuai, dan sediakan linen tambahan sewaktu pasien di kursi roda atau berjalan
- d) Dilarang menyebarkan penyakit yang diderita pelanggan, data-data pelanggan, kondisi maupun tindakan medis yang dilakukan terhadap pelanggan.

9. Lain – Lain

- a) Segera laporkan semua kecelakaan dan insiden secara lengkap
- b) Lindungi punggung Anda sewaktu mengangkat pasien, mendorong, menarik atau membawa barang. Mintalah bantuan bila perlu
- c) Gunakan baju dan peralatan pelindung jika diperlukan, dan siap sedia selalu untuk keadaan gawat darurat
- d) Jagalah kebersihan dan keamanan area kerja dan lingkungan Anda
- e) Pandanglah melebihi tugas Anda. Jika Anda dimintai tolong untuk melayani, lakukanlah
- f) Jangan katakan, "Ini bukan tugasku." Jika Anda tidak dapat memenuhi suatu permintaan, Anda wajib mempertemukan dengan Rekan Kerja yang dapat memenuhinya.
- g) Tunaikan tugas Anda. Jika terinterupsi, segera kembali ke tugas Anda secepat mungkin. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan suatu tugas, temukan Rekan kerja yang dapat menyelesaikannya.

c. Tata Tertib Kerja

1. Tata Tertib Umum

- a) Setiap staf diwajibkan mencatatkan kehadirannya (waktu datang dan pulang) dengan menggunakan alat pencatatan yang disediakan rumah sakit. Pencatatan harus dilakukan pegawai sendiri.
- b) Setiap staf yang hendak meninggalkan pekerjaan pada jam kerja karena suatu keperluan wajib mendapatkan izin meninggalkan pekerjaan dari atasan langsung pegawai dan bagian SDM.
- c) Pegawai yang tidak masuk karena alasan sakit wajib menunjukkan surat keterangan dokter yang berwenang
- d) staf yang sakit atau mengalami kecelakaan di luar kota sehingga tidak dapat masuk kerja wajib memberitahu atasan langsung pada hari itu juga dan menunjukkan surat dokter yang menangani pada hari berikutnya
- e) Staf yang mengalami hambatan tak terduga sehingga tidak dapat masuk kerja pada hari itu wajib memberitahukan hal itu kepada atasan langsung dan ketidakhadirannya dianggap cuti atau off
- f) Staf wajib memakai tanda pengenal selama menjalankan tugas

- g) Staf wajib mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang ada di bagian masing-masing
- h) Staf yang sedang hamil diatur sendiri model dan bentuk pakaian dinas

2. Tugas Kedinasan

Staf yang melakukan tugas kedinasan selama beberapa hari yaitu tugas atas perintah dan untuk kepentingan perusahaan mendapat hak, fasilitas dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Surat tugas dari institusi
- b) Penggantian biaya akomodasi (hotel/penginapan)
- c) Penggantian biaya transportasi apabila tidak menggunakan kendaraan dari perusahaan
- d) Uang makan harian dengan ketentuan :

Tabel 2.5.4.2 Biaya Penggantian Uang Makan

Lokasi Dinas	Harga Per Porsi	Porsi Maksimal perhari
Jawa selain Jabodetabek	Rp. 35.000,-	3 porsi
Jabodetabek dan Luar Jawa	Rp. 50.000,-	3 porsi

- e) Jumlah porsi maksimal ditentukan dengan melihat fasilitas yang ditawarkan penyelenggara tujuan tugas dinas, fasilitas penginapan, dan waktu pelaksanaan tugas dinas
- f) Uang makan hanya diberikan apabila tugas dinas dilakukan diluar jam kerja
- g) Staf yang melakukan tugas kedinasan wajib membuat laporan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran maksimal 2 (dua) hari setelah kembali dari lokasi dinas

3. Fasilitas Kerja

Untuk keperluan kedinasan, staf mendapat fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Staf dapat menerima inventaris dinas yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan yang dipinjamkan kepada pegawai berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- a) Kendaraan dinas bersama berupa sepeda motor dan mobil
- b) Kendaraan dinas perorangan berupa mobi
- c) Handphone untuk unit kerja
- d) Komputer/ laptop perorangan
- e) Komputer/ laptop unit kerja

Segala fasilitas inventaris perorangan berakhir bila :

- a) Dicabut haknya
- b) Tidak menjabat lagi
- c) Pensiun
- d) Meninggal dunia

4. Merusakkan atau Menghilangkan Fasilitas / Peralatan Kerja

Pegawai wajib mengganti kerusakan atau kehilangan fasilitas, peralatan, barang yang digunakan atau dibawah

tanggungjawabnya. Apabila melibatkan tim, maka penggantian dibebankan kepada seluruh anggota tim dengan beban yang disepakati bersama oleh tim yang terlibat.

Keputusan untuk mengganti atau tidak mengganti kerusakan / kehilangan alat dilakukan oleh Kepala Bidang/Bagian dan atas persetujuan PT Disa Prima Medika setelah membaca kronologis kejadian serta berita acara yang dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan bagian IT maupun IPSRS

5. Hak dan Kewajiban

a) Hak Staf

- 1) Memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan
- 2) Memperoleh upah/gaji lembur untuk kelebihan jam kerja dari waktu kerja yang telah ditetapkan dalam PKB
- 3) Memperoleh dan melaksanakan cuti
- 4) Memperoleh jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan sosial
- 5) Mengemukakan pendapat, usul dan saran demi perbaikan kinerja pada khususnya dan kemajuan perusahaan pada umumnya
- 6) Memperoleh perlakuan yang bermartabat dan manusiawi
- 7) Memperoleh kesempatan untuk berkarya sesuai dengan ketrampilan dan kompetensi dalam perusahaan
- 8) Mengadakan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku
- 9) Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku kecuali bagi pegawai tidak tetap

b) Hak Rumah Sakit

- 1) Memberikan tugas dan pekerjaan yang layak kepada Pegawai selama waktu kerja
- 2) Menugaskan staf untuk bekerja lembur/ shift dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Menempatkan staf di unit kerja manapun yang sesuai kemampuan dan kompetensi staf
- 4) Memberikan sanksi kepada staf yang melanggar perjanjian kerja, peraturan rumah sakit dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 5) Memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan perjanjian kerja, peraturan rumah sakit dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Menetapkan anggaran dan sasaran kerja perusahaan.

c) Kewajiban Staf

- 1) Mentaati hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan rumah sakit dan Hasil Pengaturan Unit Kerja
- 2) Mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan
- 3) Memberikan keterangan yang benar mengenai data pribadi, keluarga maupun mengenai pekerjaan

- 4) Melaksanakan semua tugas dan pekerjaan yang layak yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab
- 5) Menjaga kerahasiaan perusahaan dan pelanggan kecuali untuk keperluan penyidikan pihak yang berwenang
- 6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan
- 7) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis
- 8) Saling menghormati di antara pekerja dan saling bekerja sama
- 9) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan
- 10) Memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan
- 11) Menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma pergaulan yang baik
- 12) Berpenampilan baik, sopan dan rapi demi menjaga citra perusahaan
- 13) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana milik perusahaan yang dipercayakan kepada pekerja

d) Kewajiban Rumah Sakit

- 1) Memberikan upah/gaji, upah/gaji lembur, tunjangan, bantuan, jaminan dan hak Pegawai sesuai dengan ketentuan yang diatur di Perjanjian Kerja dan atau peraturan perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Memenuhi/memberikan hak-hak Pegawai sesuai perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja Pegawai.
- 4) Mentaati dan menjalankan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 5) Menampung dan memperhatikan aspirasi Pegawai.
- 6) Mengikutsertakan Pegawai Tetap dalam program asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja.

d. Tindakan Indisipliner, Asusila dan Larangan

1. Tindakan Indisipliner

Yang termasuk tindakan indisipliner adalah :

- a) Tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan/Pimpinan, dianggap mengundurkan diri
- b) Berulang kali datang terlambat ke tempat pekerjaan walaupun telah diperingatkan berkali – kali tentang kemungkinan pemecatan.
- c) Berkali-kali mangkir tanpa alasan yang sah
- d) Menolak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
- e) Berulang-ulang mengabaikan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebersihan
- f) Menolak/tidak bersedia dimutasi, dirotasi, maupun demosi sesuai dengan kebutuhan dinas

- g) Menolak perintah atasan tanpa alasan yang jelas dan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Tindakan Asusila

Staf dilarang melakukan :

- a) Pelecehan seksual
- b) Merusak rumah tangga orang lain
- c) Menghamili / hamil diluar nikah sah
- d) Menghamili / hamil sebelum nikah sah
- e) Menikah lebih dari 1 (satu) kali dan belum pernah bercerai
- f) Menikah dengan orang yang berstatus suami / istri orang lain
- g) Menikah dengan orang dibawah umur
- h) Menjalin hubungan yang tidak wajar dan / atau menikah dengan sesame jenis
- i) Menikah tanpa surat keterangan nikah yang sah secara hukum Negara

3. Larangan – larangan

- a) Makan atau minum atau membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan/ di tempat tertentu lainnya yang akan membahayakan lingkungan kerjanya maupun diri pegawai itu sendiri kecuali pada tempat yang telah ditentukan untuk keperluan tersebut
- b) Merokok di seluruh lingkungan rumah sakit.
- c) Membawa ke dalam lingkungan rumah sakit barang-barang/alat-alat/bahan- bahan dalam bentuk apapun yang dapat membahayakan keamanan/ ketentraman dan keselamatan lingkungan kerjanya
- d) Membawa dokumen dan barang-barang/ alat-alat milik perusahaan keluar lingkungan perusahaan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari atasannya/ pejabat yang berwenang
- e) Memasuki tempat-tempat dan terlibat dengan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik, kehormatan atau martabat perusahaan dan pegawai.
- f) Melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayani sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang dilayani maupun rumah sakit dan atau perusahaan.
- g) Berlaku sebagai perantara bagi suatu rumah sakit atau golongan / pribadi untuk mendapatkan jasa / fasilitas dari rumah sakit tersebut dengan menerima komisi atau keuntungan pribadi lainnya.
- h) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- i) Melakukan/mempengaruhi pegawai lain melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- j) Melakukan kegiatan secara pribadi atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan menarik keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan rumah sakit dan atau perusahaan.
- k) Membuat dan mengedarkan surat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- l) Berjudi, minum-minuman keras dan menggunakan obat terlarang / narkotik.
- m) Secara sengaja merusak barang milik rumah sakit atau perusahaan
- n) Memberi keterangan palsu khususnya keterangan yang ada kaitannya dengan data pegawai yang bersangkutan
- o) Terbukti secara sah melanggar hukum pidana, perdata dan atau TUN (Tata Usaha Negara) yang sudah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.

4. Sanksi

Pemberian sanksi merupakan tindakan yang tidak diharapkan oleh perusahaan. Pemberian sanksi terpaksa dilakukan sebagai bentuk upaya memupuk tanggung jawab kerja, kedisiplinan dan keadilan.

- a) Sanksi diberikan kepada staf apabila :
 - 1) Melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang
 - 2) Lalai melaksanakan kewajiban
- b) Prosedur pengenaan sanksi diatur sebagai berikut :
 - 1) Adanya laporan, bukti, indikasi terjadinya pelanggaran maupun kelalaian
 - 2) Dilakukan telusur kejadian
 - 3) Pembuatan kronologi kejadian oleh staf dan atau unit yang terlibat
 - 4) Dilakukan RCA (Root Cause Analysis), mitigasi sisiko, pembinaan oleh atasan agar kejadian serupa tidak terulang lagi/ diulang di kemudian hari.
 - 5) Pengenaan sanksi oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada atau Direktur Utama PT Dis Prima Medika
 - 6) PT Disa Prima dapat meberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit untuk memberikan sanksi terhadap staf di lingkungan rumah sakit berdasarkan temuan kejadian yang diketahui oleh PT Disa Prima Medika.

Tabel 2.5.4.3 Tingkatan Sanksi

No	Tingkatan Sanksi	Konpensasi	Masa Berlaku	Pelanggaran Yang Dibuat
1	Ganti Rugi	Ganti rugi senilai harga alat atau kerusakan yang dialami berdasarkan taksiran bagian keuangan .	Satu kali pembayaran atau pemotongan upah bulanan berdasarkan ketentuan bagian keuangan	Diberikan untuk setiap ditemukannya kerusakan atau kehilangan asset, inventaris, peralatan kerja, fasilitas yang disebabkan oleh kelalaian pegawai. Ganti rugi juga dikenakan untuk setiap kerugian yang dialami rumah sakit atau perusahaan akibat kelalaian kerja.
2	Peringatan Lisan	Pebinaan kepada staf yang bersangkutan	Evaluasi selama 1 bulan masa pembinaan, hasil	1. Terlambat masuk kerja 2x dalam 1 (satu) bulan. 2. Tidak memakai seragam dan atribut sesuai ketentuan 3. Tidak menjaga kebersihan

			diberikan kepada SDM	dan kerapian area kerja 4. Melanggar ketentuan tata tertib penampilan, tidak mematuhi standar kerapian diri dan kebersihan lingkungan kerjanya 5. Menimbulkan pemborosan waktu kerja dan material rumah sakit
3	Peringatan Tertulis	Pemotongan upah 5% dari gaji pokok	3 bulan	1. Mengulangi kesalahan yang sama setelah mendapatkan teguran lisan 2. Terlambat masuk kerja 3x dalam sebulan 3. Meninggalkan rumah sakit atau pekerjaannya selama jam kerja, pulang cepat tanpa izin atasan (yang dalam hal ini kepala ruang, kepala bidang atau yang lebih tinggi) 4. Mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja 5. Istirahat sebelum waktu yang ditentukan 6. Bercanda / bergurau pada saat melakukan pekerjaan di dalam lokasi pekerjaan atau kegiatan yang menyebabkan karyawan lain terganggu atau pekerjaan menjadi terhambat 7. Kurang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, malas dan tidak bekerja semestinya 8. Tidak mencapai hasil kerja yang ditargetkan 9. Tidak dapat menunjukkan kartu ID Pekerja pada saat diminta dan/atau selama melaksanakan pekerjaan. 10. Berada di area kerja yang bukan merupakan tanggungjawabnya/tidak ada hubungan dengan pekerjaannya 11. Meninggalkan tempat, peralatan kerja dan/atau lingkungan kerja dalam keadaan kotor dan berantakan setelah

				melakukan pekerjaan
4	Surat Peringatan Pertama	Pemotongan upah 5% dari gaji pokok	6 bulan	1. Mengulangi kesalahan yang sama setelah mendapatkan teguran tertulis 2. Mangkir 1 kali dalam satu bulan 3. Terlambat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. 4. Tidak mematuhi pengarahan atasan atau perusahaan, tanpa alasan yang wajar meskipun sudah diperingatkan secara lisan; 5. Setelah ditegur atau diingatkan, staf tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak dari atasan atau rumah sakit 6. Melakukan pekerjaan atau perbuatan yang dapat merugikan nama baik perusahaan 7. Tidak melaporkan kasus atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada rumah sakit 8. Tidur saat jam kerja 9. Tukar jadwal tanpa pemberitahuan ke atasan langsung atau bagian SDM 10. Tidak patuh pada instruksi / prosedur / petunjuk kerja yang berlaku 11. Menggunakan handphone pribadi saat jam kerja 12. Melakukan pekerjaan yang tidak patut / tidak pantas menurut norma adat, agama, etik 13. Mengadakan rapat – rapat atau pertemuan dalm lingkungan rumah sakit tanpa seijin pimpinan rumah sakit 14. Mempengaruhi staf lain untuk tidak melakukan kewajiban
5	Surat Peringatan Kedua	Pemotongan upah 10% dari gaji pokok	6 bulan	1. Merupakan peningkatan dari SP-1/ mengulang pelanggaran setelah mendapatkan SP-1

				2. Mangkir kerja 2 (dua) hari dalam sebulan 3. Melalaikan tugas secara tidak bertanggung jawab 4. Bertindak diluar wewenang dan tanggung jawabnya. 5. Menempelkan poster yang tidak berhubungan dengan layanan rumah sakit atau K3 6. Membawa masuk barang atau orang ke dalam lingkungan rumah sakit 7. Berlaku tidka sopan, bertindak kasar aau mengeluarkan kata – kata yang tidak senonoh kepada staf lain, pasien, tamu rumah sakit. 8. Meotret tanpa ijin di dlam lingkungan rumah sakit 9. Mencoret – coret dinding maupun peralatan inventaris rumah sakit 10. Melanggar keselamatan dan Kesehatan kerja 11. Menyembunyikan atau tidak dengan segera memberitahukan data atau informasi penting atau penyimpangan yang harus diketahui oleh atasan.
6	Surat Peringatan Ketiga	Pemotongan upah 15% dari gaji pokok	6 bulan	1. Merupakan peningkatan dari SP-2 / mengulang pelanggaran setelah mendapatkan SP-2 2. Merusak alat/ peralatan milik rumah sakit yang mengganggu operasional layanan dan staf wajib mengganti alat tersebut berupa barang atau uang. 3. Berulang kali tidak mentaati peraturan atasan/ menolak perintah atasan. 4. Tidak menjaga nama baik rumahs akit berikut semua pihak yang terkait dengan rumah sakit dalam menjalankan pekerjaan, termasuk tidak menajga nama baik rumah sakit di media sosial

				5. Membawa senjata api/ senjata tajam ke dalam lingkungan rumah sakit. 6. Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keonaran yang menimbulkan kerugian rumah sakit. 7. Memindahkan barang milik rumahs akit dengan niat untuk dimiliki. 8. Membocorkan informasi / keterangan yang bersifat rahasia rumah sakit. 9. Menyembunyikan penyakit yang diderita yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain 10. Menipu/ mencuri/ menggelapkan barang milik teman sendiri atau milik rumah sakit. 11. Melakukan pelanggaran berat di lingkungan kerja 12. Memanfaatkan barang / dokumen rumahs akit secara tidak sah. 13. Ceroboh/ lalai dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain dan/ayau menimbulkan kerugian bagi rumahs akit. 14. Bekerja untuk orang lain/ pihak lain yang bukankepentingan rumah sakit 15. Membuat isu isu yang dapat menimbulkan terjadinya keresahan dalam lingkungan rumah sakit dan atau merugikan rumah sakit. 16. Pemalsuan data, memberikan kesaksian palsu dan identitas (tanda tangan) dalm kehadiran kegiatan yang berhubungan dengan rumah sakit atau bertindak atas nama rumah sakit diluar kewenangannya 17. Menolak atau sengaja menghindari pemeriksaan petugas keamanan atau petugsa lain yang diberi wewenang oleh rumah sakit.
--	--	--	--	--

				18. Terbukti melakukan perselingkuhan dengan sesama staf baik bukti secara langsung maupun atas aduan dari keluarga atau pasangan sah 19. Rumah sakit dapat melakukan skorsing maupun PHK bagi staf yang mendapatkan SP-3
7	Sorsing	• Tidak mendapat upah selama masa skorsing • BPJS Kesehatan dan BPJS TK tetap aktif hingga maksimal 6 (enam) bulan • Tidak dikenakan potongan upah (15% dari total gaji diluar potongan) • Dikenakan beban pelunasan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS TK yang menjadi beban rumah sakit dan staf selama masa skorsing	Selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan tergantung pada penilaian dan kesepakatan bersama dari seluruh unsur pimpinan	Skorsing dapat dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan sanksi SP-3. Skorsing dilakukan dengan pertimbangan agar pegawai tidak mempengaruhi rekan kerja lainnya
8	Pemutusan Hubungan Kerja			1. Merokok di dalam lingkungan kerja 2. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja 3. Melakukan tindakan asusila yang dilarang dalam tata tertib 4. Melakukan perjudian di

				lingkungan kerja 5. Terbukti melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan, tamu perusahaan dan atau pasien di lingkungan kerja baik terbukti secara langsung maupun atas aduan dari keluarga / pasangan sah. 6. Menyalahgunakan barang / mengambil barang / uang milik rumah sakit tanpa hak 7. Melakukan usaha dan/atau tindakan yang bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan/atau kepentingan diri pribadi dan/atau orang lain dan/atau menimbulkan kerugian rumah sakit saat menjalankan tugas dan pekerjaan. 8. Menerima dari siapapun hadiah, pemberian, atau balas jasa dalam bentuk apapun untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan, dan/atau menambah biaya, ongkos atau pengeluaran rumah sakit 9. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/kesusilaan serta peraturan perundang yang berlaku 10. Dengan sengaja merusak / membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi rumah sakit 11. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja / pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja 12. Menyalahgunakan kartu pengenalan, cap, stempel, kertas dan amplop surat berlogo atau atribut lainnya
--	--	--	--	---

				yang mewakili rumah sakit untuk kepentingan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik rumah sakit dan/atau merugikan rumah sakit 13. Melakukan manipulasi administrasi, data dan atau informasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi rumah sakit maupun perusahaan 14. Dengan sengaja menghalangi, menghambat atau membuat tidak lancarnya kegiatan rumah sakit 15. Melakukan perbuatan yang mengarah pada pemborosan keuangan rumah sakit antara lain kemahalan harga, over volume dan manipulasi kwintansi pembelian. 16. Melakukan satu atau beberapa tindak pidana kejahatan baik di dalam maupun diluar rumah sakit 17. Menjadi anggota langsung atau tidak langsung organisasi yang dilarang pemerintah. 18. Membongkar atau membocorkan rahasia rumah sakit kecuali untuk kepentingan negara 19. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan rumahs akit yang dapt diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih 20. Berkelahi, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi baik fisik maupun mental staf lainnya di lingkungan rumah sakit atau diluar lingkungan rumah sakit namun masih terkait pekerjaan. 21. Sebab lain terjadinya pemutusan hubungan kerja yang bukan merupakan
--	--	--	--	--

				sanksi : a. Staf mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. b. Staf meninggal dunia c. Staf telah mencapai usia pensiun d. Staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak memperpanjang e. Staf ditahan oleh pihak yang berwajib atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
--	--	--	--	--

2.5.5 Tunjangan dan Kesejahteraan Staf

a. Kompensasi

1. Ketentuan Umum

- a) Rumah sakit memberikan kompensasi kepada staf atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- b) Kompensasi dapat berupa upah maupun non upah. Kompensasi juga memiliki tujuan lain yakni :
 - 1) Penghargaan atas prestasi staf
 - 2) Meningkatkan kepuasan dan loyalitas kerja
 - 3) Meningkatkan kedisiplinan
 - 4) Meningkatkan produktifitas
 - 5) Meningkatkan kualitas suhan
 - 6) Mengurangi turn over
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi

2. Upah

- a) Setiap staf berhak mendapatkan upah sebagai salah satu bentuk kompensasi yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan
- b) Upah terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
- c) Gaji pokok ditentukan dengan memperhatikan berbagai hal yang melekat pada individu staf seperti tingkat pendidikan, kompetensi khusus, kelangkaan tenaga kerja, dan lain-lain
- d) Tunjangan tetap yang diberikan dihitung berdasarkan jabatan, penempatan, tanggung jawab kerja dan faktor lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan secara langsung
- e) Tunjangan tidak tetap merupakan komponen upah yang diberikan berdasarkan hasil kerja, produktivitas, kehadiran dan lain-lain. Nilai tunjangan tidak tetap yang diterimakan dapat berbeda satu sama lain.
- f) Perhitungan dan pembayaran upah diatur dalam peraturan direktur mengenai struktur dan skala upah
- g) Staf dalam masa orientasi tidak mendapatkan upah, namun mendapatkan uang transport dan berlaku ketentuan berikut:

-
- 1) Gaji tidak akan dibayarkan apabila staf memilih mengundurkan diri di bulan pertama sebelum masa cut off periode gaji.
 - 2) Gaji bulan kedua dan atau bulan ketiga tidak akan dibayarkan apabila staf memilih mengundurkan diri di bulan kedua dan atau ketiga sebelum masa cut off periode gaji
 - h) Staf berhak mendapatkan kenaikan upah sesuai dengan system yang berlaku hingga pada posisi masa kerja yang tidak mendapat kenaikan lagi
 - i) Perusahaan secara berkala meninjau dan memperbaiki besaran upah
 - j) Atas penghasilan (upah) yang diterima, staf dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku
3. Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- a) Setiap staf yang bekerja dibawah naungan PT Disa Prima Medika wajib mengikuti program jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan perusahaan dengan kategori kepesertaan sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)
 - b) Iuran BPJS Kesehatan staf ditanggung staf dan perusahaan yang besarnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - c) Khusus untuk tenaga medis yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan kategori PPU di badan usaha lain tidak perlu mendaftar/migrasi kepesertaan ke PT Disa Prima Medika
 - d) PT Disa Prima Medika juga akan mendaftarkan setiap staf ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 2) Jaminan Kematian
 - 3) Jaminan Hari Tua
 - 4) Jaminan Pensiun
 - 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - e) Iuran BPJS ketenagakerjaan ditanggung staf dan perusahaan sesuai porsi yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku
4. Pemotongan Upah
- Perusahaan dapat melakukan pemotongan atas upah yang diterima oleh setiap staf. Pemotongan upah dilakukan karena berbagai alasan antara lain:
- a) Pajak Penghasilan
 - b) Simpanan maupun cicilan angsuran koperasi karyawan
 - c) Ganti rugi kerusakan / pelayanan
 - d) Biaya pendidikan/pelatihan
5. Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan hari raya diberikan saat hari besar keagamaan. Staf di lingkungan PT Disa Prima Medika mendapatkan THR setiap menjelang hari raya idul fitri. Ketentuan tentang THR diatur dalam struktur dan skala upah.
6. Insentif / Bonus Tahunan
- a) Bonus tahunan diberikan kepada staf apabila rumah sakit dapat memenuhi target yang ditentukan dan bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan

- b) Periode penilaian capaian target adalah setiap bulan januari sampai desember tahun berjalan
- c) Bonus dapat diberikan apabila pada bulan November tahun berjalan target telah tercapai minimal sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen)
- d) Staf akan diberikan bonus apabila memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Tidak terlambat tanpa alasan yang jelas 2 (dua) kali dalam setahun
 - 2) Tidak resign pada tahun berjalan
 - 3) Tidak resign selama 6 (enam) bulan di awal tahun selanjutnya
 - 4) Masa kerja telah melebihi 1 (satu) tahun per 31 Desember tahun berjalan
 - 5) Tidak mendapatkan Surat Peringatan ke-3 (SP-3)
- e) Staf yang mendapatkan Teguran Tertulis, Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua diberikan bonus dengan jumlah sebagai berikut:
 - 1) Teguran tertulis mendapatkan 75% (tujuh puluh lima) persen dari nilai bonus
 - 2) Surat peringatan pertama mendapatkan 50% (lima puluh) persen dari nilai bonus
 - 3) Surat peringatan kedua mendapatkan 25% (dua puluh lima) persen dari nilai bonus
- f) Pola perhitungan bonus dapat berupa remunerasi, nilai tetap, maupun metode lainnya yang ditentukan setiap tahunnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi

7. Hadiah Sukacita

Hadiah sukacita adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada staf yang disebabkan oleh adanya pencapaian prestasi, maupun kondisi bahagia yang diperoleh atau dialami oleh staf. Adapun hadiah sukacita diatur sebagai berikut:

- a) Hadiah kelahiran bayi

Tabel 2.5.5.1 Besaran Sumbangan Kelahiran

No	Ketentuan Staf	Besar Nominal	Karangan Bunga
1	Dokter Spesialis	400.000	-
2	Dokter Umum	400.000	-
3	Direktur	400.000	-
4	Manager	350.000	-
5	Supervisor	300.000	-
6	Koordinatpr	250.000	-
7	Staf	200.000	-
8	Pelaksana	150.000	-

- 1) Diberikan kepada karyawan atau istri karyawan yang melahirkan berdasarkan Akta kelahiran anak.
- 2) Bagi pasangan suami-istri yang keduanya bekerja di PT Disa Prima Medika, sumbangan hanya diberikan kepada salah satu pihak saja.
- 3) Syarat pengajuan melampirkan Akta Lahir anak.
- b) Staf terbaik
 - 1) Untuk predikat staf terbaik akan diberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2) Penilaian staf terbaik dilakukan untuk kinerja selama satu tahun per rumah sakit.

3) Kompensasi diberikan setiap akhir tahun

c) Hadiah pernikahan

- 1) Perusahaan memberikan hadiah berupa uang tunai untuk satu kali pernikahan, yakni pertama pegawai.
- 2) Hadiah diberikan sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5.5.2 Besaran Sumbangan Uang Pernikahan

No	Ketentuan Staf	Besar Nominal	Karangan Bunga
1	Dokter Spesialis	550.000	-
2	Dokter Umum	550.000	-
3	Direktur	550.000	-
4	Manager	550.000	-
5	Supervisor	500.000	-
6	Koordinatpr	450.000	-
7	Staf	400.000	-
8	Pelaksana	350.000	-

3) Hadiah diberikan kepada staf yang menikah dengan melampirkan bukti pernikahan otentik (undangan) selambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pernikahan.

8. Santunan Musibah dan Dukacita

Santunan musibah - dukacita diberikan sebagai bentuk kompensasi dan kepedulian perusahaan terhadap staf yang sedang mengalami musibah maupun dukacita. Santunan dukacita diatur sebagai berikut:

a) Santunan Rawat Inap

- 1) Staf menerima santunan apabila mengalami sakit hingga dilakukan rawat inap minimal selama 2 (dua) hari
- 2) Santunan diberikan berupa parcel buah / makanan yang sesuai dengan kondisi maupun penyakit yang diderita
- 3) Nominal parcel buah diatur sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5.5.3 Nominal Hadial Parcel

No	Kategori	Nominal Parcel
1	Staff Pelaksana	Rp. 200.000,-
2	Dokter Umum	Rp. 250.000,-
3	Dokter Spesialis	Rp. 300.000,-
4	Kepala Bidang/Bagian	Rp. 300.000,-

- 4) Parcel diberikan satu kali untuk setiap kali rawat inap
- 5) Tidak berlaku untuk rawat inap dalam rangka persalinan (melahirkan)

b) Santunan Bencana Alam

Tabel 2.5.5.4 Besaran Sumbangan Bencana Alam

No	Ketentuan Staf	Besar Nominal	Karangan Bunga
1	Dokter Spesialis	1.500.000	-
2	Dokter Umum	1.500.000	-
3	Direktur	1.500.000	-
4	Manager	1.500.000	-
5	Supervisor	1.200.000	-

6	Koordinatpr	1.000.000	-
7	Staf	900.000	-
8	Pelaksana	700.000	-

- 1) Perusahaan memberikan santunan untuk setiap staf yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat bencana alam.
- 2) Santunan diberikan apabila bencana alam menyebabkan hilangnya fungsi rumah atau kerusakan minimal sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Yang dikategorikan sebagai rumah adalah alamat tempat tinggal yang dilaporkan kepada bagian SDM bukan indekos.
- 4) Merupakan rumah sendiri atau rumah orang tua yang ditempati staf bersama keluarga.
- 5) Rumah kontrakan yang diakui adalah kontrakan yang dihuni oleh staf dan keluarganya. Kontrakan bersama teman sejawat/kolega tidak mendapatkan santunan.

c) Santunan Kedukaan / Meninggal Dunia
Tabel 2.5.5.5 Besaran Sumbangan Uang Duka Cita

No	Ketentuan Staf	Besar Nominal	Karangan Bunga
1	Dokter Spesialis	550.000	-
2	Dokter Umum	550.000	-
3	Direktur	550.000	-
4	Manager	550.000	-
5	Supervisor	500.000	-
6	Koordinatpr	450.000	-
7	Staf	400.000	-
8	Pelaksana	350.000	-

- 1) Santunan diberikan untuk pegawai yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- 2) Kategori anggota keluarga yang meninggalnya diberikan santunan:
 - Orang tua kandung
 - Saudara kandung (adik / kakak)
 - Pasangan yang sah (suami / istri)
 - Anak dari pasangan yang sah
 - Anak yang diadopsi secara sah dan diakui hukum
 - Orang tua angkat yang merawat sejak kecil
- 3) Santunan diberikan dengan syarat melampirkan surat kematian dari RT/RW/Kelurahan atau Rumah Sakit. Untuk saudara kandung dapat melampirkan bahwa almarhum adalah saudara kandung karyawan.
- 4) Apabila staf yang meninggal dunia, maka diberikan ucapan duka berupa karangan bunga dan santunan dukacita sebagai berikut:

Tabel 2.5.5.6 Nominal Santunan Kematian

No	Masa Kerja	Nominal
1	0 – 3 tahun	1 bulan upah
2	Lebih dari 3 tahun namun kurang dari 6 tahun	2 bulan upah

3	Lebih dari 6 tahun namun kurang dari 9 tahun	3 bulan upah
4	Lebih dari 9 tahun namun kurang dari 12 tahun	4 bulan upah
5	Lebih dari 12 tahun namun kurang dari 15 tahun	5 bulan upah
6	Lebih dari 15 tahun namun kurang dari 18 tahun	6 bulan upah
7	Lebih dari 18 tahun	7 bulan upah

- 5) Upah yang diperhitungkan dalam santunan dukacita adalah jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap
- 6) Untuk pegawai dengan status PKWT mendapatkan santunan sebesar 80% (delapan puluh persen). Baik untuk meninggalnya anggota keluarga maupun meninggalnya staf yang bersangkutan

9. Pengembangan Diri

Perusahaan memberikan kesempatan pengembangan diri pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan yang dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai diatur dalam bab tentang pendidikan dan pelatihan.

10. Kendaraan Dinas Perorangan

- a) Kendaraan dinas perorangan dipinjamkan kepada staf dengan jabatan tertentu
- b) Diberikan untuk menunjang pekerjaan dan untuk membantu mobilitas kerja
- c) Jabatan yang diberikan kendaraan dinas perorangan
 - 1) Komisaris Utama PT Disa Prima Medika
 - 2) Komisaris PT Disa Prima Medika
 - 3) Direktur Utama PT Disa Prima Medika
 - 4) Direktur PT Disa Prima Medika
 - 5) Direktur Rumah Sakit Prima Husada
- d) Apabila staf yang bersangkutan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dan tidak memanfaatkan fasilitas kendaraan dinas perorangan maka atas staf tersebut diberikan kompensasi berupa uang transportasi sebesar Rp. 180.000,- per
- e) kehadiran untuk staf tetap dan Rp. 144.000,- per kehadiran untuk staf kontrak
- f) Operasional kendaraan menjadi tanggungjawab staf yang bersangkutan
- g) Biaya pajak kendaraan, asuransi dan perawatan berlaka menjadi tanggungan perusahaan
- h) Kendaraan dinas perorangan dipergunakan secara pribadi, tidak dapat dipindahgunakan kepada staf dan orang lain.
- i) Kendaraan dinas perorangan diberikan oleh perusahaan dengan status pinjam pakai selama menduduki jabatan yang telah ditentukan

11. Pemenuhan Gizi / Makanan

- a) Pemenuhan gizi diberikan dalam bentuk makan dan minum
- b) Pemenuhan gizi diberikan untuk staf dengan jabatan tertentu
- c) Makanan diberikan sebanyak satu kali per hari atau per kehadiran
- d) Jabatan yang mendapatkan tambahan gizi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.5.7 Jenis Konsumsi Staf

No	Jabatan	Jenis Konsumsi
1	Direktur Rumah Sakit	Makan siang dan snack
2	Kepala Bidang/Bagian (dokter)	Makan siang dan snack
3	Dokter tetap	Makan siang dan snack
4	Dokter kontrak	Makan siang dan snack
5	Dokter tamu / konsulan	Snack
6	Dokter IGD	Makan dan snack
7	Dokter Instalasi Kamar Operasi	Makan dan snack
8	Satuan Pengamanan/Security	Snack
9	Pengemudi ambulance	Snack

e) Kompensasi pemenuhan gizi tidak dapat digantikan berupa uang

b. Retensi

1. Ketentuan Umum

Retensi pegawai dilakukan juga bermaksud untuk meningkatkan kepuasan pegawai bekerja di perusahaan ditandai dengan tidak terjadinya pengunduran diri seseorang pegawai dari statusnya sebagai pegawai rumah sakit.

2. Tata Laksana

a) Tahap seleksi calon staf

Pada saat seleksi calon staf, kepada setiap kandidat ditanyakan mengenai motivasi melamar kerja dan digali lebih lanjut tentang keseriusan untuk bekerja secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu bagi yang sudah berpengalaman bekerja dilihat pula bagaimana mereka bekerja di tempat lama, apakah sering berpindah-pindah dalam waktu yang relative cepat. Hanya mereka yang punya harapan bekerja lebih lama saja yang akan diterima sebagai staf.

b) Tahap orientasi

Kepada para calon staf yang sedang mengikuti masa orientasi selain diberikan bimbingan juga dimotivasi oleh para atasannya agar mereka mempunyai keyakinan bahwa kerja di Rumah Sakit Prima Husada akan memberikan harapan terbaik dalam menjalani kehidupannya.

Pada masa orientasi juga diperhatikan tentang kepatuhan terhadap disiplin kerja, keseriusan dalam melaksanakan tugas. Mereka yang kurang disiplin dan kurang serius bekerja tidak dilanjutkan hubungan kerjanya.

c) Pemberian Hak

1) Penetapan status staf

Setiap orang yang diterima sebagai staf rumah sakit ditetapkan secara tertulis baik dalam bentuk surat pengangkatan staf atau dalam bentuk kontrak kerja.

- 2) Pembayaran gaji, tunjangan dan upah lembur
Perusahaan akan berupaya semampu mungkin untuk membayar gaji, tunjangan dan upah lembur pada waktu yang telah ditetapkan dan selalu berusaha tidak ada penundaan pembayaran gaji. Pembayaran gaji menjadi prioritas utama dalam kondisi keuangan perusahaan seperti apapun
- 3) Penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan
Perusahaan akan mendaftarkan seluruh staf ke dalam jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan setelah melewati masa orientasi. Kebersertaan program jaminan social mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku, mencakup jenis program yang diikuti, hak-hak peserta, serta beban biaya yang menjadi tanggung jawab peserta dan tanggung jawab perusahaan.

Staf yang sakit dan perlu perawatan rawat inap mendapatkan fasilitas sebagai berikut :

Tabel 2.5.5.8 Fasilitas Kamar Rawat Staf

No	Jabatan	Fasilitas
1	Direksi hingga Kepala Instalasi	Gratis upgrade kelas ke VIP atau VVIP
2	Kepala Ruang dan Koordinator	Gratis upgrade kelas ke kelas I atau kelas VIP
	Staf Pelaksana	Gratis upgrade kelas maksimal kelas I
3	Upgrade kelas dilakukan apabila kamar tersedia	
4	Upgrade hanya mencakup kamar tidak termasuk biaya tindakan, asuhan keperawatan, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan	
5	Fasilitas hanya diberikan untuk perawatan yang dilakukan di rumah sakit prima husada	

Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan meliputi :

- Jaminan Kecelakaan kerja
- Jaminan Kematian
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pensiun
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Premi untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menajdi tanggungan peserta dibayarkan dengan cara pemotongan upah setiap bulannya.

- 4) Pemberian cuti tahunan
Rumah Sakit menjamin sepenuhnya kepada staf yang sudah bekerja secara berturut – turut 12 (dua belas) bulan lamanya mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja. Pengambilan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-
- 5) Pemberian cuti penting dan cuti terkait kehamilan
Setiap staf berhak mengambil cuti penting dan atau cuti terkait kehamilan sebagaimana diatur dalam peraturan rumah sakit. Staf diberikan kesempatan untuk tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan gaji
 - 6) Melaksanakan ibadah
Rumah Sakit memberikan kesempatan kepada para staf untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
 - 7) Kesehatan dan keselamatan kerja
Rumah Sakit menyelenggarakan system keselamatan kerja dan setiap staf harus mematuhi, keselamatan kerja termasuk prioritas budaya kerja.
 - 8) Jenjang karir
Rumah sakit menyusun dan menetapkan jenjang karir bagi para stafnya. Jika ada kekosongan jabatan maka selama ada staf yang memenuhi persyaratan jabatan tersebut maka yang bersangkutan mendapatkan prioritas utama dengan melalui proses seleksi dan prosedur yang berlaku.
 - 9) Pemberian penghargaan (Reward)
Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja kepada seluruh staf. Kepada staf yang memiliki nilai sangat baik ditambah dengan persyaratan yang ditentukan sebagai staf teladan kepadanya diberikan penghargaan, berupa:
 - Surat penghargaan
 - Hadiah berupa uang atau barangStaf dengan masa kerja selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut tanpa berhenti, kepadanya diberikan surat penghargaan dan cinderamata. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada pegawai dengan masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun dengan kelipatan setiap 5 (lima) tahun/
 - 10) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Staf akan diberikan tunjangan hari raya keagamaan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 11) Pemberian bonus tahunan
Pemberian bonus dapat dilakukan dengan dua sasaran yakni :
 - Bonus untuk unit kerja
 - Bonus untuk seluruh pegawai rumah sakit atau perusahaanBonus diberikan apabila unit kerja atau rumah sakit memenuhi target yang telah ditentukan
 - 12) Pertemuan rutin seluruh staf
Dalam upaya meningkatkan komunikasi langsung antara staf dengan jajaran Manajemen Rumah Sakit dan Komisaris Perusahaan, setiap 1 (satu) bulan sekali diadakan pertemuan

seluruh staf yang sedang tidak melaksanakan tugas pelayanan kepada pasien.

13) Perayaan ulang tahun rumah sakit

Untuk meningkatkan hubungan kerja dan hubungan kekeluargaan yang lebih harmonis pada saat perayaan hari jadi Rumah Sakit Prima Husada diadakan acara khusus yang melibatkan staf dan keluarganya.

14) Perayaan hari besar keagamaan

Rumah sakit bekerja sama dengan pengurus paguyuban keagamaan dan melibatkan tokoh masyarakat sekitar untuk mengadakan peringatan hari besar keagamaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rohani

15) Pendidikan dan pelatihan

- Seiring dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pengembangan pelayanan dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna menjaga kompetensi atau kemampuan setiap staf.
- Rumah sakit juga dapat memfasilitasi staf dengan status staf tetap untuk diberikan kesempatan pengembangan diri berupa melanjutkan pendidikan maupun mengikuti pelatihan tertentu.
- Pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan dan atau rumah sakit dilaksanakan dengan pembiayaan yang ditanggung oleh perusahaan dengan jumlah tertentu dan dilakukan perjanjian ikatan dinas untuk waktu tertentu.

16) Hadiah sukacita dan santunan dukacita

Rumah sakit memberikan tunjangan atau kompensasi kepada staf yang mengalami sukacita maupun dukacita. Jenis sukacita maupun dukacita yang diberikan hadiah maupun santunan diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh direktur.

17) Dukungan pimpinan

Rumah sakit memberikan dukungan kepada staf atas ide yang positif demi demi perkembangan perusahaan dengan memberi kesempatan untuk mewujudkan ide ke dalam kegiatan maupun program kerja rumah sakit. Dukungan rumah sakit juga diberikan apabila terjadi insiden terkait keselamatan pasien yang berkaitan dengan proses hukum.

18) Survey kepuasan staf

Rumah sakit menyelenggarakan survey kepuasan staf untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan staf bekerja. Tingkat kepuasan staf ini dipandang erat kaitannya dengan retensi staf itu sendiri. Dengan melakukan survey diharapkan didapatkan data factor apa saja yang dapat menyebabkan tingkat retensi staf berkurang, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan upaya perbaikan.

BAB III

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF

3.1 KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF KLINIS

3.1.1 KOMPETENSI STAF KLINIS

- a. Staf yang direkrut oleh Rumah Sakit Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikannya dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi
- b. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada yang bersangkutan setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.
- c. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- d. Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR.
- e. Ruang lingkup praktik asuhan sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh masing – masing komite.
- f. Masing – masing staf dilakukan proses untuk menyesuaikan dengan persyaratan posisi, proses tersebut meliputi :
 1. Penilaian kompetensi awal, untuk memastikan apakah PPA dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai uraian tugasnya.
 2. Keabsahan pendidikan yang didapat dari Institusi Pendidikan yang staf bersangkutan miliki
 3. Legalitas (STR dan SIP) yang masih aktif.
- g. Penilaian dilakukan sebelum atau saat mulai bertugas
- h. Rumah sakit menetapkan kontrak kerja sebagai masa percobaan untuk mengawasi dan mengevaluasi PPA tersebut.
- i. Rumah sakit menentukan proses untuk memastikan bahwa PPA yang memberikan pelayanan beresiko tinggi atau perawatan bagi pasien beresiko tinggi dievaluasi pada saat mereka mulai memberikan perawatn, sebelum masa percobaan atau orientasi selesai.
- j. Penilaian kompetensi awal dilakukan oleh unit dimana PPA tersebut ditugaskan

3.1.2 KEWENANGAN STAF KLINIS

- a. Penetapan kewenangan klinis
 1. Penetapan kewenangan klinis PPA didasarkan pada hasil kredensial yang mereview dan mengevaluasi kelayakan seorang PPA untuk diberi kewenangan tertentu.
 2. Tolak ukur kelayakan tersebut adalah kompetensi yang dimiliki.
- b. Tujuan pemberian kewenangan klinis
 1. Menjamin kemampuan staf di Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan lingkup praktik
 2. Sebagai wujud komitmen staf dalam memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat

3.2 KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF NON KLINIS

1. Staf non klinis yang direkrut oleh rumah sakit wajib memiliki ijazah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan unit.

-
2. Masing – masing staf dilakukan proses untuk menyesuaikan dengan persyaratan posisi, proses tersebut meliputi :
 - a. Penilaian kompetensi awal sesuai dengan bidang staf yang bersangkutan
 - b. Keabsahan pendidikan yang didapat dari Institusi Pendidikan yang staf bersangkutan miliki
 3. Penilaian dilakukan sebelum atau saat mulai bertugas
 4. Rumah sakit menetapkan kontrak kerja sebagai masa percobaan untuk mengawasi dan mengevaluasi PPA tersebut

BAB IV

FILE KEPEGAWAIAN

4.1. KETENTUAN UMUM

- a. File Kepegawaian yang terkini berisikan dokumentasi setiap staf rumah sakit yang mengandung informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiannya.
- b. File kepegawaian memuat :
 - 1. Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, kompetensi staf
 - 2. Bukti orientasi
 - 3. Uraian tugas staf
 - 4. Riwayat pekerjaan staf
 - 5. Penilaian kinerja staf
 - 6. Salinan sertifikat pelatihan didalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti
 - 7. Informasi Kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksin/ imunisasi, hasil medical check up
- c. File kepegawaian distandarisasi dan terus diperbaharui setiap tahun.

4.2. PENEMPATAN FILE KEPEGAWAIAN

- a. File kepegawaian dikelompokkan berdasarkan
 - 1. Unit kerja masing – masing staf, dengan tujuan memudahkan pencarian.
 - 2. Profesi masing - masing
- b. File kepegawaian di tempatkan di dalam lemari yang terkunci dan tidak bisa diakses semua orang, hanya staf SDM saja.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.1.1 Ketentuan Umum

- a. Setiap staf memperoleh pendidikan dan pelatihan baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) rumah sakit untuk menjaga dan atau meningkatkan ketrampilan dan pengetahuannya.
- b. Setiap staf wajib menguasai teknik bantuan hidup dasar (basic life support) mendapatkan sertifikasi pelatihan dengan masa berlaku 2 tahun untuk pelatihan internal, serta sesuai sertifikat untuk pelatihan eksternal yang diakui (penyelenggara minimal dari rumah sakit tipe B).
- c. Setiap staf wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 (dua puluh) jam per tahun
- d. Khusus staf yang termasuk tenaga kesehatan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bobot minimal 5 (lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) per tahun
- e. Setiap staf wajib mengikuti diklat yang diadakan oleh rumah sakit dan atau perusahaan.
- f. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kompetensi staf.
- g. Rumah sakit menentukan staf mana yang diharuskan untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan untuk menjaga kemampuan mereka dan bagaimana pendidikan staf tersebut akan dipantau dan didokumentasikan.
- h. Rumah sakit meningkatkan dan mempertahankan kinerja staf dengan mendukung program pendidikan dan pelatihan termasuk menyediakan sarana prasarana termasuk peralatan, ruangan, tenaga pengajar, dan waktu.
- i. Program pendidikan dan pelatihan dibuat setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan staf di masing-masing Rumah sakit dan/atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan misalnya tenaga kesehatan diberikan pelatihan PPI, perkembangan praktik medis, penggunaan peralatan medis baru dan atau adanya peraturan perundangan terbaru
- j. PT Disa Prima Medika memberikan bantuan beasiswa dana pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan operasional pelayanan pelanggan
- k. Pendidikan dan pelatihan pegawai dapat dilakukan apabila anggaran belanja untuk program tersebut masih tersedia
- l. Setelah mengikuti pelatihan pegawai diwajibkan untuk membuat rangkuman materi dan kemudian dipresentasikan kepada unit terkait maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pegawai yang bersangkutan mulai aktif kembali bekerja
- m. Selain membuat rangkuman materi, peserta pelatihan juga membuat laporan dan materi berupa makalah dan atau buku terkait pelatihan yang diikuti
- n. Hasil pendidikan dan pelatihan staf didokumentasikan dalam file kepegawaian
- o. Pelatihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan pasien

5.1.2 Ketentuan Khusus

- a. Rumah sakit mengumpulkan data dari sumber dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan/atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan.
- b. Sumber informasi untuk memenuhi pendidikan staf mencakup :
 - 1) Hasil kegiatan pengukuran data dan mutu keselamatan pasien
 - 2) Hasil analisa laporan insiden keselamatan pasien
 - 3) Hasil survei budaya keselamatan pasien
 - 4) Hasil pemantauan program manajemen fasilitas dan keselamatan.
 - 5) Pengenalan teknologi termasuk penambahan peralatan medis baru, keterampilan dan pengetahuan baru yang diperoleh dari penialain kinerja.
 - 6) Prosedur klinis baru
 - 7) Rencana untuk menyediakan layanan baru di masa yang akan datang
 - 8) Rencana untuk menyediakan layanan baru di masa yang akan datang.
 - 9) Kebutuhan dan usulan dari setiap unit.
- c. Perencanaan pendidikan dan pelatihan di dokumentasikan dalam *Training Need Analysis* (TNA).

5.1.3 Prosedur Pengajuan Pendidikan

- a. Setiap unit/ tim dan komite membuat Analisa Kebutuhan Pelatihan/ *Training Need Analysis* (TNA).
- b. Pengajuan pelatihan internal harus membuat perencanaan (TOR) pelatihan yang meliputi latar belakang, rencana pelaksanaan, sasaran peserta, narasumber dan biaya. Diajukan dan harus mendapatkan persetujuan Direktur Rumah Sakit.
- c. Rencana pelaksanaan dan pengajuan pelatihan dibuat maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
- d. Pengajuan pelatihan eksternal (keluar) harus dengan persetujuan direktur Rumah Sakit
- e. Pengajuan pendidikan yang sudah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit selanjutnya diajukan kepada Direktur PT Disa Prima Medika
- f. Setiap pelatihan eksternal wajib mengaplikasikan pengetahuan yang didapat ke dalam kegiatan pelayanan sehingga pengetahuan itu dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta meningkatkan kinerja perusahaan secara umum.

5.1.4 Pendidikan Formal Staf

- a. Untuk meningkatkan jenjang pendidikan, staf dapat mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan kepada direktur.
- b. Pemberian izin melanjutkan pendidikan bagi staf didasarkan pada kebutuhan pelayanan, kemampuan rumah sakit dan perusahaan.
- c. Staf yang diizinkan belajar oleh Rumah Sakit dan PT Disa Prima Medika dapat memiliki status izin belajar atau tugas belajar, bilamana setelah masa pendidikan selesai tingkat pendidikan yang baru dapat diperhitungkan dalam kenaikan status kepegawaian.
- d. Staf yang izin belajar maupun tugas belajar mendapatkan surat keputusan direktur tentang status belajarnya.
- e. Staf yang melanjutkan pendidikan namun tidak memiliki izin dari direktur, pada saat selesai masa pendidikan tidak dapat diperhitungkan dalam kenaikan status kepegawaiannya.

- f. Perusahaan juga memberi kesempatan kepada anak Staf untuk mendapatkan beasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan, sehingga setelah masa pendidikan selesai anak pegawai tersebut dapat menjalani ikatan dinas dan diproses menjadi pegawai sesuai dengan prosedur penerimaan pegawai baru di PT Disa Prima Medika.

5.1.5 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibuat berupa perencanaan yang disusun oleh bagian SDM Rumah Sakit dan disetujui oleh direktur utama PT Disa Prima Medika.
- b. Untuk pendidikan dan pelatihan yang merupakan program kerja pengembangan kompetensi pegawai, rencana jadwal pelaksanaan sudah ditentukan dalam target realisasi/pelaksanaan program kerja.
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dapat berupa pelatihan internal maupun eksternal
 - 1) Internal
 - Dilakukan di dalam lingkungan rumah sakit / perusahaan dan tidak melibatkan peserta dari institusi lainnya.
 - Narasumber dan panitia pelaksana merupakan staf internal rumah sakit
 - Narasumber dari pihak eksternal dapat didatangkan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang tidak dapat diakomodir oleh narasumber eksternal
 - Pelaksanaan dapat berupa online maupun offline
 - 2) Eksternal
 - Pelatihan eksternal diikuti staf rumah sakit yang penyelenggaranya adalah pihak eksternal
 - Pelatihan eksternal yang dibiayai oleh perusahaan, hasil pelatihan berupa sertifikat dan materi pelatihan wajib diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia

5.1.6 Identifikasi Pendidikan dan Pelatihan Staf

- a. Pendidikan dan Pelatihan Internal

Tabel 5.1.6.1 Pendidikan dan Pelatihan Internal

No	Diklat	Sasaran	Kebutuhan
1	PPI Dasar • Etika batuk dan audit bundle • Hand hygiene • Alat pelindung diri • Limbah/ sampah • Penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh (spilkit)	Semua staf RS	PPI
2	CSSD	Kepala Unit Staf CSSD	PPI
3	Triage	Perawat Bidan	AKP IGD
4	Trasfer dan rujukan	Perawat Bidan	AKP Unit Rawat
5	Hak pasien dan keluarga	Perawat	HPK

		Bidan Admisi	
6	Komunikasi efektif	Perawat Bidan	KE Unit rawat
		Staf lain	Unit penunjang Pendaftaran
7	Manajemen nyeri	Perawat Bidan	PAP Unit rawat
8	Manajemen pasien terminal	Perawat Bidan	PAP Unit rawat
9	Pengelolaan darah dan pemberian tranfusi darah	Perawat Bidan Analis lab	PAP Unit rawat Lab
10	BHD	Semua staf RS	PAP
11	BHD Lanjutan	Tim Code Blue	RS AKP PAP
12	EWS	Perawat Bidan	PAP
13	Manajemen Resiko Jatuh	Perawat Bidan	SKP Unit Pelayanan
14	Manajemen Restrain	Perawat Bidan	SKP
15	Kompetensi Dasar Perekam Medis	Perekam Medis	MIRM
16	Manajemen Pasien Terminal	Perawat Bidan	PAP Unit Rawat ICU
17	PMKP	Semua Staf	PMKP
18	PMKP untuk Pulta	Pulta	PMKP
19	Pemasangan dan Pelepasan Infus	Perawat Bidan	IRNA ICU IGD IKO Komkep
20	Pemasangan dan pelepasan Kateter	Perawat Bidan	IRNA ICU IGD IKO Komkep
21	Manajemen Bencana • Penggunaan APAR • B3 • Penanggulangan bencana kebakaran	Semua Staf	MFK
22	PPK, CP, Rencana Asuhan	PPA	PAP IRNA IGD

			ICU
23	Kompetensi Dasar Perkam Medis	Perekam Medis	Instalasi Rekam Medik MIRM
24	Medication Error	Perawat Bidan Apoteker TTK	IRNA IRJA ICU IGD IKO Farmasi PKPO
25	Penyiapan Obat & Teknik Aseptik	Perawat Bidan Apoteker TTK	IRNA IRJA ICU IGD IKO Farmasi PKPO

b. Pendidikan dan Pelatihan Eksternal

Tabel 5.1.6.2 Pendidikan dan Pelatihan Eksternal

No	Diklat	Sasaran	Kebutuhan
1	IPCLN	Perawat	PPI
2	PPGD	Perawat	IGD
3	PPGDON	Bidan	IGD
4	ACLS	Dokter	IGD AKP
5	ESQ	Semua Staf	RS
6	HACCP	Ahli Gizi	Unit Gizi
7	Plebotomi	Analisis Lab	Unit Lab
8	ICU Dasar	Perawat	ICU
9	Manajemen Bangsal	Kepala Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan	IRNA IRJA
10	Resertifikasi Asesor Kompetensi Perawat	Dokter Perawat/ Bidan	Rumah Sakit
11	Assesor Internal RS	Dokter Perawat/ Bidan	Rumah Sakit
12	PMKP	Direktur Ketua PMKP	Rumah Sakit

5.1.7 Ikatan Dinas Pendidikan

Ikatan dinas diterapkan untuk setiap pegawai yang mengikuti pendidikan maupun pelatihan dengan pembiayaan bersumber dari anggaran perusahaan. Ikatan dinas adalah bentuk perjanjian yang menguntungkan perusahaan dan pegawai. Perusahaan terjamin mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi maupun kualifikasi yang diharapkan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan dari sisi pegawai mendapatkan peningkatan kompetensi dan terjamin mendapatkan pekerjaan selama jangka waktu tertentu.

Ikatan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Hanya berlaku untuk pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai perusahaan
- b. Ikatan dinas dimulai setelah pendidikan/pelatihan selesai dilakukan
- c. Sertifikat maupun ijazah asli hasil pendidikan/pelatihan diserahkan dan disimpan oleh perusahaan dan akan dikembalikan setelah masa ikatan dinas selesai
- d. Salinan sertifikat dalam bentuk file dalam email pribadi pegawai harus dihapus
- e. Salinan ijazah yang sudah dilegalisir disimpan perusahaan bersama ijazah asli
- f. Ikatan dinas tidak dapat dilakukan lebih dari satu jenis ikatan dinas dalam satu waktu yang bersamaan
- g. Apabila pegawai mengikuti pendidikan/pelatihan saat masih menjalani ikatan dinas, maka periode ikatan dinas untuk pendidikan/pelatihan terbaru akan dimulai saat periode ikatan dinas sebelumnya telah selesai.

5.1.8 Evaluasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam setiap penyelenggaraan diklat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Pemateri / penyelenggara internal
- b. Materi yang diberikan
- c. Proses pelaksanaan diklat
- d. Dilakukan pembaruan data pemateri maupun penyelenggara eksternal yang dapat memberikan diklat dengan materi, pemateri maupun hasil yang baik

5.2 PELATIHAN RESUSITASI JANTUNG

5.2.1 Sasaran

Semua staf yang merawat pasien, termasuk dokter dan staf lain yang ditentukan rumah sakit telah diberikan pelatihan teknik resusitasi dasar. Rumah sakit menentukan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) atau bantuan hidup tingkat lanjut untuk setiap staf, sesuai dengan tugas dan perannya di rumah sakit. Misalnya rumah sakit menentukan semua staf yang merawat pasien di unit gawat darurat, di unit perawatan intensif, semua staf yang akan melaksanakan dan memantau prosedur sedasi prosedural serta tim kode biru (code blue) harus mendapatkan pelatihan sampai bantuan hidup tingkat lanjut. Rumah sakit juga menentukan bahwa staf lain yang tidak merawat pasien, seperti pekarya atau staf registrasi, harus mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar.

Tingkat pelatihan bagi staf tersebut harus diulang berdasarkan persyaratan dan/atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tiap anggota staf yang menghadiri pelatihan benar-benar memenuhi tingkat kompetensi yang diinginkan.

5.2.2 Tim Code Blue

a. Ketentuan Umum

1. Tim Code blue adalah tim reaksi cepat yang sudah memiliki sertifikasi ATLS/ACLS untuk dokter dan PPGD untuk perawat. Jadwal jaga tim code blue harus diatur sehingga selalu ada di setiap shift dalam 24 jam pelayanan RS.

2. Jika ada panggilan code blue, segera ambil code blue kit dan langsung menuju ruangan tertuju. Maksimal waktu tim code blue datang di samping pasien adalah 5 menit
3. Pada saat tim code blue datang, mulai dilakukantahapan resusitasi.

b. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tabel 5.2.2.1 Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Code Blue

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Ketua Tim	1. Memimpin pelaksanaan Resusitasi Jaltung Paru (RJP). 2. Menentukan tindak lanjut pasca resusitasi. 3. Melakukan koordinasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). 4. Sebagai pengambil keputusan dalam kondisi emergensi atau kondisi jika DPJP tidak ada _ di tempat atau sulit dihubungi. 5. Melakukan edukasi dengan keluarga pasien. 6. Melakukan koordinasi dengan bagian pelayanan medis dan keperawatan terikait jadwal jaga tim Code Blue. 7. Melakukan koordinasi dengan bagian/ unit yang lain untuk pelaksanaan Code Blue, misalnya dengan bagian farmasi untuk pengadaan obat dan alat kesehatan (alkes) emergensi. 8. Bekerja sama dengan diklat Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas tim Code Blue
2	Sekretaris	1. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kegiatan Tim Code Blue. 2. Menyiapkan ketersediaan obat dan peralatan habis pakai. 3. Mencatat pelaporan setiap kejadian yang berhubungan dengan kegiatan Code Blue
3	Anggota Tim Kompresi	1. Anggota tim Code Blue segera mengambil alih tindakan resusitasi yang sedang berjalan dan melanjutkan tahapan resusitasi jantung paru. 2. Bertanggung jawab membawa "resusitasi kit". 3. Bertanggung jawab dalam persiapan pemasangan defibrillator. 4. Bertanggung jawab dalam penggunaan obat-obatan emergensi. 5. Bertanggung jawab terhadap penggunaan peralatan emergensi termasuk defibrilator. 6. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Tanggung Jawab

4	Anggota Ventilasi	Tim	1. Memberikan bantuan melalui Bag -Value – Mask 2. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan pasien. 3. Tekan dahi angkat dagu (head tilt – chin lift) bila tidak ada trauma 4. Mendorong rahang bawah (jaut thrust) bila ada trauma. 5. Pemasangan Oropharingeal airway. 6. Persiapan pemasangan LMA
5	Anggota Resusitasi	Tim	1. Aktivasi Code Blue kegawatan medis 2. Melakukan resusitasi bersama dokter jaga Code Blue

- c. Alur Code Blue
1. Penolong yang mengetahui pertama kali harus segera melakukan penilaian dini kesadaran korban.
 2. Amankan pasien di tempat datar dan keras, posisikan pasien dalam posisi terlentang.
 3. Lakukan cek kesadaran dengan memanggil nama dan menepuk bahu “Pak.. Pak.. /Buu.. Buu..”
 4. Jika tidak ada respon, cek pernafasan dengan mendekatkan telinga di hidung pasien sambil melihat pergerakan dada.
 5. Jika tidak ada nafas, aktifkan code blue dengan menghubungi 103.
 6. Sambil menunggu, lakukan kompresi 30x. Dengan cara menarik garis linear di antara kedua pusung susu dan di bagian tengah.
 7. Cek nadi carotis, jika tidak ada, lakukan resusitasi dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kompresi menggunakan tangan terkuat di center of the chest diantara dua papilla dengan kecepatan 100-120x/menit dan kedalaman 4-5cm dengan recoil sempurna.
 8. Jika tim code blue sudah datang, selesaikan 1 siklus yang sedang berjalan, kemudian resusitasi dilanjutkan oleh tim code blue. Segera laporkan jumlah siklus yang sudah dilakukan.

5.3 BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 5.3.1 Diklat Eksternal Talangan Perusahaan
- Merupakan pembiayaan biaya pendidikan dan pelatihan yang pada awalnya ditanggung oleh perusahaan dan kemudian pegawai melakukukan pembayaran dengan cara menyicil melalui skema pemotongan upah bulanan. Perusahaan memberikan kesempatan pengembangan diri atas inisiatif pekerja dan atau untuk memenuhi pendidikan maupun pelatihan yang merupakan persyaratan mutlak untuk bekerja.

Tabel 5.3.1.1 Ketentuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

No	Ketentuan	Keterangan
1	Pembiayaan	Biaya ditanggung perusahaan dan staf yang bersangkutan menyicil/ menabung setiap bulan dengan mengurangi gaji yang diterima.
2	Lama Ikatan Dinas	Selama masa cicilan berlangsung ditambah 1 (satu) tahun pengabdian.

3	Periode mulai	Saat skema pembiayaan disetujui	
4	Pengabdian	Masa pengabdian selama 1 (satu) tahun dimulai setelah cicilan lunas dan hanya berlaku untuk pendidikan maupun pelatihan dengan biaya diatas Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).	
5	Penalty	a. 1,5x (satu koma lima kali) biaya pendidikan/pelatihan yang telah dibayarkan dikurangi biaya yang telah dicicil. b. Bila mengundurkan diri selama masa pengabdian maka diberikan penalty sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya pendidikan dan pelatihan	
6	Jadwal Kerja	Jadwal kerja tidak boleh sampai terganggu. Apabila pegawai harus meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari, maka uang kehadiran pegawai dipotong sesuai periode ketidakhadiran	
7	Pengunduran DIri	Selama masa ikatan dinas pegawai tidak diperkenankan mengundurkan diri, apabila mengundurkan diri maka dikenakan aturan pengembalian biaya sesuai ketentuan penalty.	
8	Upah	Diberikan sesuai perhitungan kehadiran	
9	Cakupan Biaya	Hanya biaya pendidikan/pelatihan. Tidak mencakup biaya akomodasi, transportasi, konsumsi	
10	Besaran Cicilan	<500.000	1 x cicil (mutlak)
		500.000 - 1.000.000	2 x cicil (mutlak)
		1.000.000 – 5.000.000	200.000 atau 5% (mana yang lebih besar)
		5.000.000 – 15.000.000	350.000 atau 4% (mana yang lebih besar)
		15.000.000 – 25.000.000	500.000 atau 3% (mana yang lebih besar)
		>25.000.000	750.000 atau 2,5% (mana yang lebih besar)

5.3.2 Diklat Eksternal Beasiswa Perusahaan

Biaya pelatihan dan pendidikan sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Staf tidak berkewajiban mengganti biaya apapun namun diikat dengan ikatan dinas dimana staf diharuskan untuk melakukan pengabdian selama waktu tertentu. Program beasiswa pendidikan dan pelatihan dilakukan berdasar atas kebutuhan perusahaan untuk memenuhi regulasi dan atau meningkatkan daya saing.

Tabel 5.3.2.1 Ketentuan Biaya Diklat Eksternal Beasiswa

No	Ketentuan	Keterangan	
1	Pembiayaan	100% (seratus persen) ditanggung perusahaan	
2	Lama Ikatan Dinas	a. 2N + 1. Dimana N merupakan masa studi. Dalam satuan tahun b. Berdasarkan biaya pendidikan/ pelatihan	
		Rentang Biaya (000)	Masa Ikatan Dinas
		0 - 500	6 bulan
		500 – 1000	1 tahun
		1000 – 5000	2 tahun
		5000 – 10.000	4 tahun

			10.000 – 15.000	5 tahun
			15.000 – Keatas	8 tahun
3	Periode mulai	Saat peltihan atau pendidikan selesai		
4	Pengabdian	Tergabung dalm ikatan dinas		
5	Penalty	a. Mengundurkan diri saat ikatan dinas berlangsung: 2x (dua kali) biaya pendidikan/pelatihan x persentase pengabdian yang belum dilakukan (satuan bulan). b. Tidak menyelesaikan pendidikan/pelatihan (mangkir): 2,5x (dua koma lima kali) biaya pendidikan/pelatihan c. pendidikan/pelatihan		
6	Jadwal Kerja	Jadwal kerja tidak boleh sampai terganggu. Apabila staf harus meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari, maka uang kehadiran staf dipotong sesuai periode ketidakhadiran.		
7	Pengunduran Diri	Selama masa pendidikan/pelatihan dan selama ikatan dinas berlangsung, staf tidak diperkenankan mengundurkan diri. Apabila mengundurkan diri maka dikenakan aturan pengembalian biaya sesuai ketentuan penalty.		
8	Upah	a. Diberikan penuh apabila masih dapat menjalankan tugas / pekerjaan harian b. Apabila pendidikan/pelatihan menuntut staf tidak dapat menjalankan tugas/pekerjaannya sehari-hari maka upah yang diberikan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap selama menjalani tugas belajar. Apabila meninggalkan pekerjaan lebih dari satu bulan, tunjangan jabatan tidak diberikan (jika ada) atau didemosi sementara ke jabatan pelaksana		
9	Cakupan biaya	Mencakup biaya pendidikan/pelatihan dan biaya akomodasi, transportasi, konsumsi apabila perlu		

5.3.3 Diklat Internal

Untuk biaya pendidikan dan pelatihan yang diadakan internal perusahaan dan atau rumah sakit, sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan kecuali diklat ESQ Training.

Setiap narasumber dan panitia yang merupakan pegawai internal akan diberikan jasa yang diatur sebagai berikut :

a. Honorarium

No	Kategori	Jasa (dalam 000)		
		Pemateri	Moderator	Pembawa Acara
1	Dokter Spesialis	Rp 250	Rp 50	Rp 50
2	Dokter Umum	Rp 200	Rp 50	Rp 50
3	Kepala Bidang (Dokter)	Rp 100	Rp 50	Rp 50
4	Kepala Bidang (Non Dokter)	Rp 75	Rp 40	Rp 30
5	Kepala Instalasi Farmasi	Rp 60	Rp 30	Rp 20
6	Kepala Ruang	Rp 50	Rp 20	Rp 15
7	Staff Ahli Dibidangnya	Rp 50	Rp 20	Rp 15

b. Jasa Tidak berlaku untuk staf rumah sakit dengan jabatan berikut

1. Direktur Rumah Sakit Prima Husada

- c. Jasa diberikan sesuai table berikut:

Tabel 5.3.3.1 Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Durasi Diklat (jam belajar)	Besaran Jasa
1 sampai 3 jam	1 (satu) kali
Lebih dari 3 jam dan kurang dari 6 jam	1 (satu) kali
6 jam atau lebih dan kurang dari 9 jam	2 (dua) kali

- d. Durasi pelaksanaan diklat ditentukan berdasarkan susunan acara yang dibuat.

5.4 EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam setiap penyelenggaraan diklat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- pemateri / penyelenggara internal
- materi yang diberikan
- proses pelaksanaan diklat
- peserta : tingkat kepatuhan mengikuti diklat
- mutu kinerja unit pasca diklat
- Dilakukan pembaruan data pemateri maupun penyelenggara eksternal yang dapat memberikan diklat dengan materi, pemateri maupun hasil yang baik

BAB VI

KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

6.1. KETENTUAN UMUM

Program kesehatan dan keselamatan staf rumah sakit tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Skrining kesehatan awal.
- b. Tindakan-tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya, seperti pajanan terhadap obat - obatan beracun dan tingkat kebisingan yang berbahaya.
- c. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman.
- d. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja.
- e. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian sentinel.
- f. Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.
- g. Vaksinasi/Imunisasi pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- h. Pengelolaan kesehatan mental staf, seperti pada saat kondisi kedaruratan penyakit infeksi/pandemik

6.2. SKRINNING KESEHATAN AWAL

- a. Skrinning Kesehatan staf baru
 1. Skrinning dilakukan pada saat rekrutmen staf baru
 2. Pemeriksaan staf baru meliputi :
 - a) Pemeriksaan dokter
 - b) Pemeriksaan buta warna
 - c) Pemeriksaan Laboratorium : HBSAg, anti HIV
 - d) Pemeriksaan EKG
 - e) Pemeriksaan Thorax Rontgen
- b. Skrinning Kesehatan staf berkala
 1. Skrinning staf dilakukan setiap satu tahun sekali
 2. Identifikasi dan pemetaan populasi beresiko potensi bahaya yang ada
 3. Menentukan jenis pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan potensi bahaya tempat kerjanya
 4. Pemeriksaan tahap 1 (pertama)
 - a) Pengkajian keluhan
 - b) Pemeriksaan fisik
 5. Pemeriksaan tahap 2 (kedua)
 - a) Dilakukan untuk unit yang beresiko tinggi dan staf yang terindikasi
 - b) Unit yang beresiko tinggi :
 - Petugas yang bekerja di keperawatan (Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Gawat Darurat, Ruang Bersalin, Ruang Isolasi)
 - Staf yang bekerja di radiologi
 - Staf yang bekerja pada bagian Laboratorium
 - Staf yang bekerja di pengelolaan limbah B3
 6. Pemeriksaan tahap 3 (ketiga)
 - a) Hasil lab diberikan kepada dokter pemeriksa
 - b) Konseling terkait hasil pemeriksaan

- c) Rujukan ke poli psesialis, bila perlu
- 7. Melakukan analisis hasil pemeriksaan Kesehatan staf secara populasi untuk memberikan rekomendasi program Kesehatan Kerja dan perbaikan lingkungan kerja

6.3. PENGENDALIAN PAJANAN

Hirarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilahan dan pelaksanaan pengendalian berhubungan dengan bahaya K3

- a. Eliminasi
Memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya dengan menempatkan obat – obat beracun sesuai dengan kriterianya
- b. Substitusi
Pengganti bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem
- c. Kontrol teknik/ perancangan
 - 1. Menginstal sistem ventilasi
- d. Kontrol administrative
 - 1. Menentukan area beresiko
 - 2. Memasang CCTV di unit yang beresiko
- e. Limbah B3
Penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar. Apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang bai dan benar, termasuk memasukkan limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai serta dilekati symbol dan label limbah B3.
Untuk penyimpanan limbah B3 maka rumahs akit memenuhi persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagai berikut:
 - 1. Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi.
 - 2. Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan yang dilengkapi dengan sabun cair
 - 3. Mudah diakses untuk penyimpanan limbah
 - 4. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan
 - 5. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah
 - 6. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir dan factor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.
 - 7. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga dan burung
 - 8. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik serta memadai
 - 9. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan
 - 10. Peralatan pembersihan, alat pelindung diri/APD (masker, sarung tangan, penutup kepala, google, sepatu boot serta pakaian pelindung) dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat – dekatnya dengan lokasi fasilitas penyimpanan.
 - 11. Dinding, lantai dan juga langit – langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih termasuk pembersihan lantai setiap hari

6.4. TATA LAKSANA KEJADIAN STAF CEDERA

- a. Alur pelaporan kejadian bila staf mengalami cedera akibat kerja
 1. Setiap staf yang mengalami kejadian (kecelakaan kerja/ akibat kerja) segera ditangani untuk mengatasi kejadian tersebut sesuai prosedur.
 2. Setelah staf tertangani, setiap staf yang mengalami kejadian (kecelakaan kerja/akibat kerja) membuat laporan kejadian/ kronologis secara tertulis pada format yang telah disediakan
 3. Setiap kejadian kecelakaan kerja dan penyalit akibat kerja dilaporkan oleh penanggung jawab K3RS satuan kerja ke panitia K3RS
 4. Pelaporan pertama dibuat melalui billing SIMRS dengan menu kecelakaan kerja K3RS
 5. Pelaporan kedua menggunakan form kecelakaan kerja ditujukan ke ketua Panitia K3RS
 6. Pelaporan kejadian dikirim paling lambat 2x24 jam setelah kejadian
 7. Panitia K3RS menganalisa setiap laporan yang masuk untuk menentukan jenis kejadian, mencari akar penyebab masalah dan solusi pemecahannya
 8. Panitia K3RS melaporkan kejadian tersebut ke Direktur Rumah Sakit
 9. Apabila pajanan non infeksius maka dilakukan intervensi oleh panitia K3RS
 10. Apabila pajanan infeksius, maka berkoordinasi dengan tim PPI kemudian melakukan intervensi.
- b. Alur pelaporan kejadian bila staf mengalami pajanan PPI
 1. Melakukan penanganan pertama terhadap pajanan, berdasarkan jenisnya:
 - a) Luka tusuk
 - Membilas dengan air mengalir dan sabun antiseptic selama 1-3 menit
 - Tidak diperbolehkan menghisap dengan mulut
 - Mendisinfeksi luka dan daerah sekitar kulit dengan salah satu Betadine (povidone iodine 2,5%) selama 5 menit/ dengan alcohol 70% selama 3 menit
 - b) Pajanan mukosa mata
 - Mengirigasi dengan air/ garam fisiologis selama 15 menit
 - c) Pajanan mukosa hidung
 - Menghembuskan keluar dan membersihkan dengan air bersih selama 1-3 menit
 - d) Pajanan mukosa mulut
 - Meludahkan dan berkumur dengan air bersih selama 1-3 menit
 2. Melaporkan kejadian kepada kepala ruang atau kepala jaga
 3. Menentukan perlu atau tidaknya profilaksis pasca pajanan dan tindak lanjutnya
 - a) Staf yang terpajan melakukan pemeriksaan ke IGD menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan
 - b) Staf yang bersangkutan membawa formulir laporan pajanan (formular B) untuk diisi dokter IGD
 - c) Tahap tersebut diselesaikan dalam waktu <4 jam

6.5. PELAYANAN KESEHATAN KERJA

- a. Promotif
1. Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi (extra fooding) bagi pekerja yang bekerja di area berisiko tinggi dan pekerja yang dinas bergilir.
 2. Pelaksanaan program kebugaran jasmani terprogram (pengukuran kebugaran jasmani danlatihan fisik terprogram), senam kesehatan dan rekreasi.
 3. Pemenuhan gizi kerja
 - a) Pemeriksaan Kesehatan bagi staf dapur
 - b) Pemantauan status gizi dan konseling gizi
 - c) Pemberian makanan setiap hari jumat bagi semua staf
 4. Pemenuhan gizi kerja
 - a) Pemeriksaan Kesehatan bagi staf dapur
 - b) Pemantauan status gizi dan konseling gizi
 - c) Pemberian makanan setiap hari jumat bagi semua staf
 - d) Pemberian makanan untuk pejabat struktural maupun fungsional yang diatur sebagai berikut :

Tabel 6.5.1 Pemberian makanan untuk pejabat struktural maupun fungsional

No.	Jabatan	Jenis Makanan
1	Direktur Utama PT Disa Prima Medika	Makan siang disertai buah, minuman dan snack
2	Kepala Bidang/Bagian di PT Disa Prima Medika	
3	Direktur Rumah Sakit Prima Husada	
4	Kepala Bidang/Bagian di Rumah Sakit	
5	Dokter Spesialis Tetap dan Kontrak	
6	Dokter jaga IGD, Ruangan, MCU dan Dokter Verifikator	Snack dan minuman sesuai jadwal praktik
7	Dokter Spesialis Tamu / Konsulan	
8	Tim Dokter Bedah di Instalasi Kamar Operasi	Makan disertai buah, snack dan minuman untuk operasi pagi dan siang hari Makan dan minum untuk operasi di malam hari. Hanya diberikan 3 kali dalam sehari dengan jumlah maksimal sesuai kebutuhan

- b. Preventif
1. Pemberian imunisasi pada staf Rumah Sakit yang bekerja pada area/tempat kerja yang berisiko dan berbahaya.
 2. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus sesuai dengan risiko pekerjaan
 3. Pelaksanaan program kebugaran jasmani
 4. Pemantauan status dan konseling gizi pegawai setiap 6 (enam) bulan
 5. Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai meliputi pemeriksaan sebelum bekerja, berkala dan insidentil sesuai dengan risiko pekerjaan
 6. Program pemeriksaan kesehatan pegawai mengikuti pedoman yang dilaksanakan oleh komite K3RS
 7. Pelaporan pajanan dan insiden kecelakaan pegawai

8. Biaya pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala ditanggung oleh perusahaan dan merupakan anggaran untuk penyelenggaraan program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai kecuali pemeriksaan kesehatan calon staf
 9. Memberikan sarana dan prasarana aman dan terbebas dari risiko kekerasan di lingkungan kerja untuk karyawan
- c. Kuratif
1. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi staf rumah sakit yang menderita sakit.
 2. Melakukan diagnosa dan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui, selain risiko penyakit umum yang ada di masyarakat.
 3. Penanganan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yaitu suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur – unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan kematian disamping itu menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan property.
 4. Penanganan pasca pemajanan
- d. Rehabilitatif
1. Rehabilitasi medik
 2. Pelaksanaan program pendampingan Kembali bekerja (return to work) bagi staf Rumah Sakit yang mengalami keterbatasan setelah mengalami sakit lebih dari 2 minggu yang mana memerlukan rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi okupasi/kerja
 3. Pengelolaan kesehatan mental staf dengan metode konseling.

6.6. PENGELOLAAN KESEHATAN MENTAL STAF

- a. Setiap staf yang bekerja di Rumah Sakit Prima Husada diberikan pelatihan ESQ untuk membentuk building character
- b. Rumah sakit melakukan skrinning Kesehatan staf secara berkala setiap satu tahun sekali
- c. Konseling dan bimbingan Kesehatan jiwa diberikan kepada staf yang mengalami gangguan

6.7. KESEHATAN DAN KEAMANAN KERJA

- a. Pencegahan terjadinya kecelakaan dan cidera serta mempertahankan kondisi yang aman bagi perusahaan, pegawai dan pengunjung
- b. Pemetaan area berisiko terjadinya gangguan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja
- c. Identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif menyangkut keselamatan dan keamanan
- d. Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan lain pada kejadian tidak aman yang meliputi :
 1. Pencegahan gangguan keamanan berupa tindakan pencurian, kekerasan dan sejenisnya
 2. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 3. Pencegahan dan pengendalian kebakaran
 4. Pengelolaan prasarana perusahaan
 5. Pengelolaan peralatan medis

-
6. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana
 7. Perlindungan dan pengelolaan kekerasan dilingkungan rumah sakit
 8. Tata laksana kejadian tidak diharapkan

6.8. PELAYANAN DAN PENGENDALIAN K3 STAF

- a. Dalam hal terdapat pegawai yang terpapar risiko kesehatan maupun keselamatan kerja maka pendampingan, penanganan dan pengendalian dilakukan oleh komite K3RS bekerjasama dengan bagian SDM Rumah Sakit atau Perusahaan
- b. Pegawai yang sakit dipastikan mendapatkan penanganan kesehatan sesuai layanan yang dibutuhkan dan tetap mengikuti regulasi dari BPJS Kesehatan
- c. Pegawai yang sakit dimonitor status kesehatannya minimal setiap 3 (tiga) hari
- d. Apabila penyakit yang diderita merupakan penyakit menular dan berpotensi menjadi sumber penularan penyakit bagi pegawai lainnya, maka bagian SDM akan melakukan tindakan berikut :
- e. Dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada pegawai yang merupakan kontak erat penderita penyakit menular
- f. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka tracing penyakit menular dibebankan kepada program kementerian kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. Biaya dapat pula dibebankan kepada PT Disa Prima Medika apabila tidak tercover oleh program pemerintah
- g. Apabila diperlukan rumah sakit dan perusahaan diperkenankan melakukan penataan ulang ketenagaan agar pelayanan operasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya.

BAB VII

TENAGA MEDIS

7.1 KREDENSIAL STAF MEDIS

Rumah sakit menyelenggarakan pengumpulan dokumen kredensial dari anggota staf medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri. Rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini terhadap pendidikan, registrasi, izin, pengalaman dan lainnya dalam kredensialing staf medis.

7.1.1 Ketentuan Umum

- a. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan perusahaan harus dilakukan proses kredensial dan rekredensial secara berkala
- b. Kredensial adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi suatu keahlian atau kompetensi berdasarkan pengalaman dan profesionalisme seseorang dalam memberikan pelayanan yang spesifik dengan mengedepankan keselamatan pasien dan pelayanan yang bermutu tinggi
- c. Kredensial dapat dilakukan dengan metode verifikasi dokumen, wawancara, tes akademik kemampuan keprofesian yang dilakukan sebelum tenaga kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan klinis
- d. Rekredensial adalah proses kredensial ulang untuk tenaga kesehatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun untuk rekredensial selanjutnya atau setelah mendapatkan kompetensi tambahan
- e. Proses kredensial dan rekredensial dilakukan oleh tim kredensial yang dibentuk oleh direktur rumah sakit
- f. Rumah sakit menetapkan peraturan internal staf medis yang disahkan oleh PT Disa Prima Medika yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja dan rekredensial tenaga kesehatan
- g. Tim kredensial harus berisi tenaga yang sudah diakui kemampuannya untuk melakukan kredensial terhadap tenaga kesehatan
- h. Apabila rumah sakit belum memiliki tenaga yang kompeten untuk melakukan kredensial dan rekredensial, maka dapat mengajukan untuk menggunakan jasa mitra bestari yang direkomendasikan oleh rumah sakit
- i. Hasil kredensial dan rekredensial digunakan untuk menentukan cakupan kewenangan klinis yang akan diberikan kepada setiap tenaga kesehatan
- j. Hasil kredensial dan rekredensial digunakan untuk mengukur batas aman tingkat kemampuan tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang dikerjakan sesuai dengan prosedur yang aman
- k. Hasil kredensial dan rekredensial juga digunakan untuk mengidentifikasi gap kompetensi terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tenaga kesehatan
- l. Hasil kredensial dan rekredensial berupa surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disahkan oleh Direktur Rumah Sakit dan disimpan dalam file kepegawaian serta salinannya didistribusikan di setiap unit maupun area kerja pegawai yang bersangkutan

7.1.2 Ketentuan Khusus

Setelah melalui proses kredensial dan atau rekredensial, setiap tenaga kesehatan mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang diberikan. Kewenangan klinis diatur sebagai berikut :

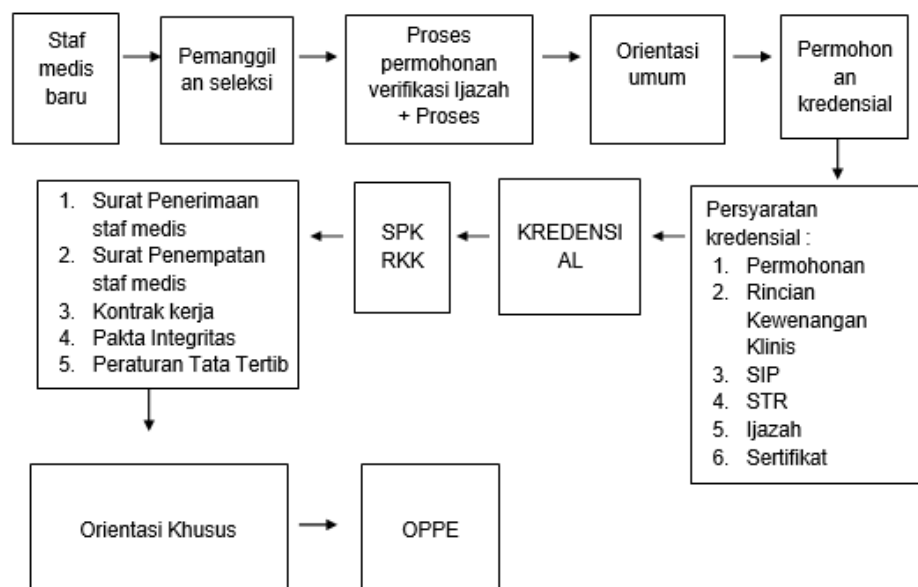
- a. Kewenangan klinis diberikan oleh pimpinan rumah sakit
- b. Kewenangan klinis yang diberikan disertai keterangan apakah kewenangan tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau harus dibawah supervisi

- c. Kewenangan klinis yang diajukan namun tidak disetujui oleh pimpinan rumah sakit disampaikan dalam bentuk surat penolakan permohonan kewenangan klinis
- d. Kewenangan klinis dapat dicabut setelah mendapatkan rekomendasi dari tim terkait
- e. Kewenangan klinis yang dicabut diberitahukan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam bentuk surat pemberitahuan yang kemudian disampaikan kepada unit-unit terkait
- f. Kewenangan klinis yang diberikan berbatas waktu tertentu yang dituangkan dalam surat penugasan klinis
- g. Masa berlaku SPK dan RKK adalah 3 (tiga) tahun
- h. Kewenangan yang diberikan dapat bertambah setelah mendapatkan rekomendasi dari tim kredensial
- i. Setiap tenaga kesehatan dengan spesialisasi atau profesi yang sama dimungkinkan memiliki kewenangan klinis yang berbeda disebabkan oleh pendidikan dan pelatihan tambahan, pengalaman atau hasil kerja yang bersangkutan selama bekerja serta kemampuan motoriknya
- j. Kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak memiliki peralatan khusus atau staf khusus untuk mendukung pelaksanaan kewenangan klinis
- k. Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis terbaru dan masih berlaku disimpan dalam file kepegawaian, salinannya didistribusikan kepada unit atau area kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan.

7.1.3 Dokumen kredensial dan rekredensial

- a. STR, izin praktik yang masih berlaku
- b. File pelanggaran etik atau disiplin termasuk informasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI
- c. Kewenangan yang diberikan berdasarkan OPPE
- d. Rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervise dari profesi dokter yang ditentukan.
- e. Bila staf medis mengalami gangguan Kesehatan, kecacatan tertentu, atau proses penuaaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang.
- f. Jika seorang anggota staf medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau sub spesialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Keanggotaan staf medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai tekhnologi medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu

Alur Penerimaan dan Kredensial Staf Medis



7.2 PENGANGKATAN STAF MEDIS

Pengangkatan/ penugasan Kembali merupakan proses peninjauan dokumen anggota tenaga medis untuk verifikasi :

- a. Perpanjangan ijin
- b. Bahwa anggota tenaga medis tidak dikenai sanksi disipliner oleh badan perizinan dan sertifikasi
- c. Bahwa berkas berisi dokumentasi yang cukup untuk pencarian kewenangan atau tugas baru/ perluasan di rumahsakit
- d. Anggota tenaga medis mampu secara fisik danmental untuk memberikan perawatan dan tata laksana terhadap pasien tanpa supervisi.

7.3 KEWENANGAN KLINIS STAF MEDIS

7.3.1 Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis saat penetapan ulang mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. Anggota staf medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan atas pendidikan dan pelatihan lanjutan. Pendidikan dan pelatihan diverifikasikan dari sumber aslinya (Lembaga pemerintah atau kolegium). Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervise sebelum kewenangan klinis diberikan.
- b. Kewenangan klinis anggota staf medis dapat dilanjutkan, dibatasi atau dihentikan berdasar atas :
 - a) Hasil dari proses pengajuan praktik professional berkelanjutan.
 - b) Pembatasan keenangan klinis adari organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI atau badan resmi lainnya.
 - c) Temuan rumahsakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain
 - d) Kesehatan staf medis
 - e) Permintaan staf medis.

7.3.2 Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Pertimbangan pemberian kewenangan klinis pada penugasan (appointment) pertama adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang staf medis didasarkan terutama atas informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah sakit.
- b. Sumber luar rumah sakit dapat berasal dari :
 - Program pendidikan spesialis
 - Surat rekomendasi dari penempatan sebagai staf medis yang lalu.
 - Organisasi profesi.
- c. Program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara umum tentang kompetensinya di area diagnosis dan tindakan profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia yang mengeluarkan standar kompetensi atau kewenangan klinis. Perhimpunan profesi lain membuat dasar secara detail jenis/ tindakan medis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis.
- d. Keputusan kewenangan klinis dirinci dan akan direkomendasikan kepada pimpinan rumah sakit dalam sebuah area spesialisasi terkait dengan proses lain.
- e. Penilaian kinerja staf medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit

- f. Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan (OPPE) dan terfokus (FPPE).
- g. Hasil pendidikan dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan, kolegium, perhimpunan profesi dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat.
- h. Untuk kewenangan tambahan pada pelayanan resiko tinggi, yaitu:
 - Obat anestesi
 - Penggantian sendi lutut dan panggul
- i. Kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai peralatan khusus atau staf khusus untuk mendukung pelaksanaan.

7.3.3 Proses pemberian rincian kewenangan klinis

Pemberian rincian kewenangan klinis memperhatikan kriteria :

- a. Terstandar, objektif, berdasar atas bukti (evidence based)
- b. Terdokumentasi di regulasi rumah sakit
- c. Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial staf medis
- d. Diikuti semua lapisan keanggotaan staf medis
- e. Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif

7.4 OPPE STAF MEDIS

7.4.1 Ketentuan Umum

- a. Proses penilaian kinerja harus dapat mengenali hasil pencapaian , pengembangan potensial terkait kewenangan klinis dari anggota staf dan layanan yang diberikan.
- b. Evaluasi perilaku dilaksanakan secara kolaboratif antara sub komite etik dan disiplin, Kepala SDM, Kepala Bidang dan Kepala Unit.
- c. Pengembangan profesional staf berkembang dengan menrapkan teknologi baru dan pengetahuan klinis baru.
- d. Penilaian kinerja staf dilakukan setiap 6 bulan sekali (semester)
- e. Data penilaian kinerja didapatkan dari unit kerja masing masing staf.

7.4.2 Ketentuan Khusus

Penilaian kinerja staf medis meliputi :

1. Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan/ *Ongoing Professional Practice Evaluation* (OPPE).
2. Evaluasi Praktik Profesional Terfokus/ *Focused Professional Practice Evaluation* (FPPE).

FPPE dan OPPE membutuhkan kolaborasi dari :

- a. Komite Medis
 1. Sub komite etik dan disiplin
 2. Sub komite mutu profesi
 3. Sub komite kredensial
- b. Mitra Bestari
- c. Ketua Kelompok Staf Medis
- d. Staf Medis/ staf klinis terkait
- e. Staf IT

Penilaian kinerja staf medis memuat 3 (tiga) area

1. Perilaku

Anggota staf medis ialah model atau mentor dalam menumbuhkan budaya aman (safety culture) di rumah sakit. Budaya aman

ditandai dengan partisipasi penuh semua staf untuk melaporkan bila ada insiden keselamatan pasien tanpa ada rasa takut untuk melaporkan dan disalahkan (no blame culture).

a) Evaluasi perilaku memuat :

- 1) Evaluasi apakah seorang staf medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplin profesi dan rumah sakit serta dilakukan identifikasi perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima maupun perilaku yang mengganggu.
- 2) Tidak ada laporan dari anggota staf medis tentang perilaku yang dianggap tidak dapat diterima atau mengganggu.
- 3) Mengumpulkan, analisa serta menggunakan data dan informasi berasal dari survei lainnya tentang budaya aman di rumah sakit.

b) Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan.

- 1) Perilaku yang tidak layak (inappropriate) seperti kata – kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki.
- 2) Perilaku yang mengganggu (disruptive) antara lain perilaku yang tidak layak yang dilakukans secara berulang. Bentuk tindakan verbal atau non verbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain. Dan “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain.
Contoh, mengomentari negative hasil tindakan atau pengobatan staf lain didepan pasien, melarang perawat untuk membuat laporan KTD, memarahi staf klinis lainnya didepan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis rawat.
- 3) Perilaku melecehkan (harassment) terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender.
- 4) Pelecehan seksual.

2. Pengembangan Profesional

Setia anggota staf medis dari segala tingkatan akan merefleksikan perkembangan dan perbaikan pelayanan Kesehatan dan praktik profesional sebagai berikut :

- a) Asuhan pasien, penyediaan asuhan penuh kasih, tepat dan efisien dalam promosi Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan asuhan di akhir hidup.
Alat ukurnya adalah layanan preventif dan laporan dari pasien serta keluarga.
- b) Pengetahuan medik/ klinik termasuk pengetahuan biomedik, klinis, epidemiologi, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan pendidikan kepada pasien.
Alat ukurnya adalah penerapan panduan praktik klinis (*Clinical Practice Guidelines*) termasuk revisi pedoman hasil pertemuan profesional dan publikasi.
- c) Praktik belajar berdasar bukti (*practice – bases learning*) dan pengembangan, penggunaan bukti ilmiah dan metode

- pemeriksaan, evaluasi serta perbaikan asuhan pasien berkelanjutan berdasar atas evaluasi dan belajar terus menerus (contoh, alat ukur survei klinis, memperoleh kewenangan berdasar atas studi dan keterampilan klinis baru dan partisipasi penuh pada pertemuan ilmiah).
- d) Kepandaian berkomunikasi antar personal termasuk menjaga dan meningkatkan pertukaran informasi dengan pasien, keluarga pasien dan anggota tim layanan Kesehatan yang lain.
Partisipasi aktif di ronde ilmiah, konsultasi tim dan kepemimpinan tim.
 - e) Profesionalisme, janji mengembangkan profesionalitas terus menerus, praktik etik, pengertian terhadap perbedaan, serta perilaku bertanggung jawab terhadap pasien, profesi dan masyarakat.
 - f) Alat ukur : pendapat pimpinan di staf medis terkait isu profesi, aktif membantu diskusi panel tentang etik, ketepatan waktu pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap, dan partisipasi di masyarakat.
 - g) Praktik berbasis sistem, serta sadar dan tanggap terhadap jangkauan sistem pelayanan Kesehatan yang lebih luas.
Alat ukur : pemahaman terhadap regulasi rumah sakit yang terkait dengan tugasnya seperti sistem asuransi medis, asuransi Kesehatan (JKN), sistem kendali mutu dan biaya, peduli pada masalah resistensi antimikroba.
 - h) Mengelola sumber daya, memahami pentingnya sumber daya dan berpartisipasi melakukan asuhan yang efisien, serta menghindari penyalahgunaan pemeriksaan untuk diagnostic dan terapi yang tidak ada manfaatnya bagi pasien serta meningkatkan biaya pelayanan Kesehatan.
Alat ukur : berpartisipasi dalam kendali mutu dan biaya, kepedulian terhadap biaya yang ditanggung pasien, serta berpartisipasi dalam proses seleksi pengadaan.
 - i) Sebagai bagian dari proses penilaian, proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta harus mengetahui kinerja anggota staf medis yang relevan dengan potensi pengembangan kemampuan profesional staf medis.

3. Kinerja Klinis

- a) Proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari staf medis harus dapat memberi indikasi, sebagai bagian dari proses peninjauan, bahwa kinerja anggota staf medis terkait upayanya mendukung budaya aman/ keselamatan.
- b) Penilaian atas informasi bersifat umum, berlaku bagi semua anggota staf medis dan juga tentang informasi spesifik terkait kewenangan dari anggota staf medis dalam memberikan pelayanannya.
- c) Sumber data dapat menjadi rujukan (*benchmark*) didalam KSM/ unit layanan atau diluarnya untuk mengetahui pola individu dari staf medis, antara lain :
 - Lama hari rawat (*Length Of Stay*)
 - Frekuensi (jumlah pasien yang ditangani)
 - Angka kematian
 - Pemeriksaan diagnostic

- Pemakaian darah
- Pemakaian obat – obat tertentu
- Angka Infeksi Luka Operasi (ILO)

7.4.3 Pengertian Penilaian Kinerja

1. Penilaian Praktek Profesional Berkelanjutan (OPPE) adalah proses pengumpulan data dan informasi secara berkesinambungan untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku professional staf media.

7.4.4 Tujuan Penilaian Kinerja

1. Meningkatkan praktik individu terkait mutu dan asuhan pasien yang aman
2. Sebagai dasar mengurangi variasi di dalam kelompok staf medis (KSM) dengan cara membandingkan antara kolega, penyusunan panduan praktek klinis (PPK) dan Clinical Pathway
3. Sebagai dasar memperbaiki kinerja kelompok staf medis dan staf lainnya dengan cara membandingkan acuan praktik di luar rumah sakit, publikasi riset, dan indicator kinerja klinis nasional bila tersedia

7.4.5 Manfaat Penilaian Kinerja

1. Membuat penilaian kinerja lebih tepat waktu
2. Memungkinkan kesempatan untuk meningkatkan kinerja individu sebelum kredensial (bagi staf klinis) dan peningkatan karir.

7.4.6 Prosedur Penilaian Kinerja

- a. Kepala bidang mengelola data kinerja klinis yang didapatkan dari data pelayanan staf medis
- b. Komite medis memberikan rekomendasi terhadap kinerja staf medis terkait pelayanan yang diberikan.
- c. Hasil pengolahan data dituangkan dalam penilaian kinerja staf
- d. Hasil penilaian kinerja staf dikonfirmasi kepada staf medis yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala bidang dan komite medis

BAB VIII

TENAGA KEPERAWATAN

8.1 KREDENSIAL STAF KEPERAWATAN

8.1.1 Mekanisme kerja sub kredensial

Untuk melaksanakan tugas sub komite Kredensial, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut :

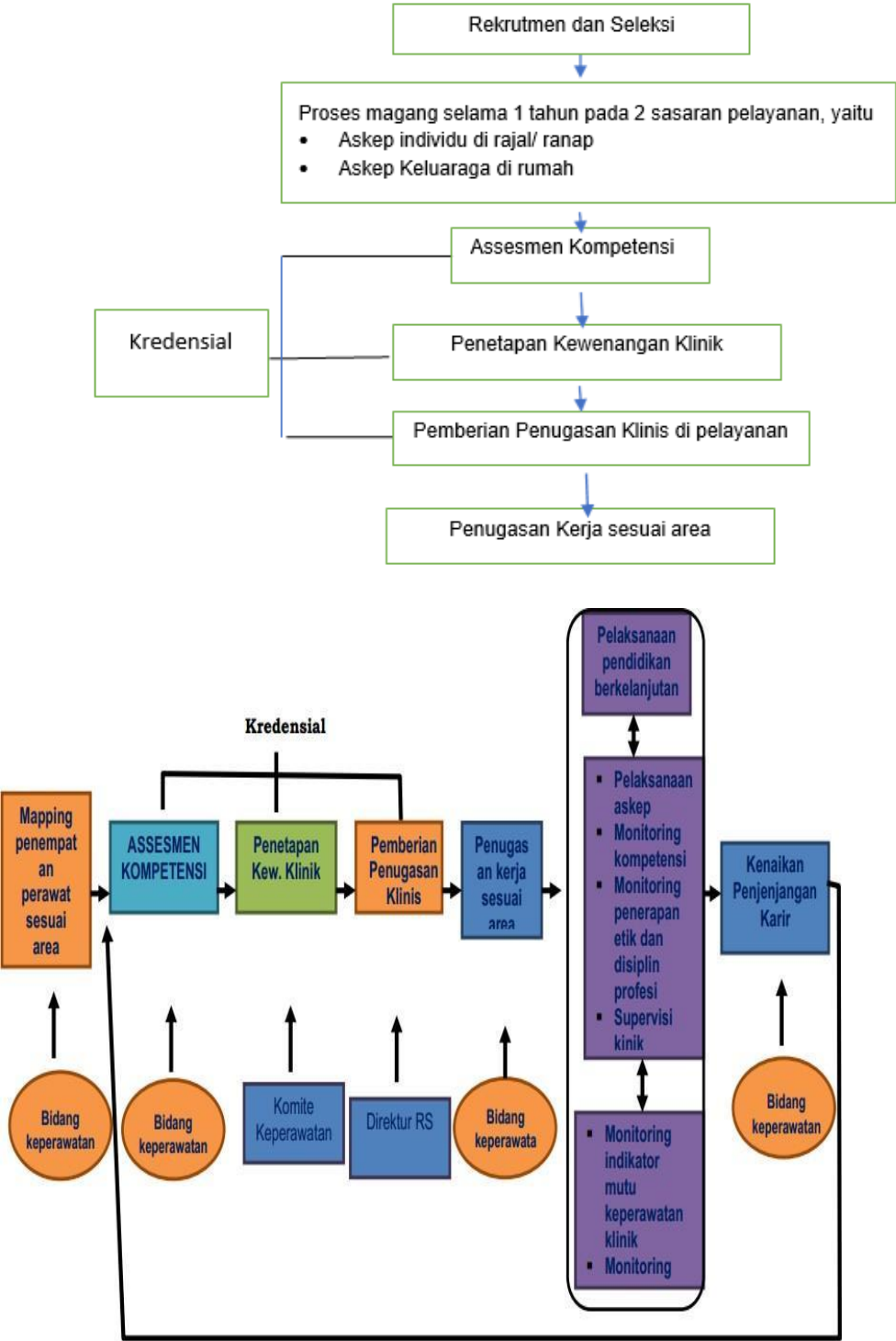
1. Mempersiapkan Kewenangan Klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh rumah sakit.
2. Menyusun Kewenangan Klinis dengan kriteria sesuai dengan persyaratan Kredensial dimaksud
3. Melakukan assesmen Kewenangan Klinis dengan berbagai metode yang disepakati
4. Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh Penugasan Klinis dari kepala/direktur Rumah Sakit, dengan cara :
 - a. Tenaga keperawatan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite Keperawatan
 - b. Ketua Komite Keperawatan menugaskan sub komite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok)
 - c. Sub komite melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode: porto folio, asesmen kompetensi
 - d. Sub komite memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga keperawatan
5. Memberikan rekomendasi Kewenangan Klinis untuk memperoleh Penugasan Klinis dari kepala/direktur Rumah Sakit
6. Melakukan pembinaan dan pemulihan Kewenangan Klinis secara berkala
7. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan

8.1.2 Tahapan proses kredensial staf baru

1. Setelah staf baru lolos dari semua tahap seleksi penerimaan staf baru, selanjutnya akan diberikan SK penerimaan
2. Staf baru akan mengikuti proses magang selama 1 tahun pada 2 sasaran pelayanan yaitu :
 - a. Askep individu di rawat jalan/ rawat inap
 - b. Askep keluarga di rumah
3. Data staf akan diverifikasi oleh Bagian SDM kepada institusi yang terkait
4. Staf dilakukan assesmen kompetensi perawat oleh assessor kompetensi perawat yang sudah ditunjuk oleh komite keperawatan.
5. Hasil dari assesmen kompetensi diberikan kepada sub kredensial komite keperawatan untuk selanjutnya diberikan kewenangan klinis
6. Komite keperawatan mengajukan hasil kepada Direktur Rumah Sakit untuk diterbitkan Surat Penugasan Klinis.
7. Selanjutnya staf diberikan penugasan kerja sesuai dengan area kerja yang ditempatinya.

8.1.3 Tahapan proses rekredensial

1. Kepala ruang melakukan skrinning terhadap perawat pelaksana yang harus melakukan rekredensial.
2. Data staf diberikan kepada komite keperawatan.
3. Staf perawat yang bersangkutan mengajukan rekredensial, dimulai dari :
 - a. Pengajuan assesmen kompetensi perawat kepada assessor kompetensi yang telah ditujuk oleh komite keperawatan
 - b. Hasil dari assesmen kompetensi perawat diberikan kepada komite keperawatan untuk diberikan rekomendasi berupa Rincian Kewenangan klinis
 - c. Komite keperawatan mengajukan hasil kepada Direktur Rumah Sakit untuk diterbitkan Surat Penugasan Klinik
4. Salinan Rincian Kewenangan Klinis dan Surat Penugasan Klinik disimpan di file kepegawaian SDM dan Unit masing – masing.



8.2 RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) DAN SURAT PENUGASAN KLINIS (SPK)

8.2.1 Rincian Kewenangan Klinis (RKK)

a. Penetapan Kewenangan Klinis

Kewenangan klinis tenaga keperawatan merupakan uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.

Penetapan kewenangan klinis seorang perawat didasarkan pada hasil kredensial yang mereview dan mengevaluasi kelayakan seorang perawat untuk diberi kewenangan tertentu. Sehingga salah satu tolak ukur kelayakan tersebut adalah kompetensi yang dimiliki.

b. Tujuan Pemberian Kewenangan Klinis

1. Menjamin kemampuan perawat dan bidan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan lingkup praktik.
2. Sebagai wujud komitmen perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat.

c. Jenis Kewenangan Klinis

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, kewenangan perawat berdasarkan pelimpahan wewenang terbagi menjadi :

1. Delegatif

Pelimpahan wewenang secara delegative dilakukan oleh staf medis kepada staf keperawatan yang berkompeten untuk melakukan tindakan medis disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

2. Mandat

Pelimpahan wewenang secara mandate dilakukan oleh staf medis kepada staf keperawatan untuk melakukan suatu tindakan medis dibawah pengawasan

8.2.2 Surat Penugasan Klinis (SPK)

Penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK)

1. Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) tenaga perawat pemohon berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Keperawatan.
2. Surat Penugasan tersebut memuat daftar sejumlah kewenangan klinis untuk melakukan asuhan dan tindakan keperawatan.

8.3 PENILAIAN KINERJA STAF KEPERAWATAN

8.3.1 Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja staf klinis memuat 3 (tiga) area

1. Perilaku
2. Pengembangan profesional, memuat :
 - Tugas dan tanggung jawab staf
3. Kinerja klinis, memuat :
 - Kompetensi dan kewenangan staf
 - Temuan mutu dalam aktivitas peningkatan mutu

8.3.2 Prosedur Penilaian Kinerja

1. Pengolahan data dilakukan oleh kepala unit masing – masing berdasarkan tindakan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing – masing staf
2. SDM memberikan rekomendasi penilaian berupa pelanggaran atau perilaku yang dilakukan oleh staf.
3. Penilaian kinerja yang sudah dibuat diajukan kepada kepala bidang terkait untuk dilakukan analisa dan ditindak lanjuti

BAB IX

TENAGA KESEHATAN LAIN

9.1 KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN

9.1.1 Proses Kredensial

1. Staf Klinis lain mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis dengan metode self assesmen. Staf klinis lain mengisi formulir yang isinya daftar tindakan atau kompetensi yang tertera dalam formulir dengan mencontreng dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
2. Setelah persyaratan lengkap, rumah sakit menyerahkan kepada Komite Staf Klinis Lain.
3. Rumah Sakit menugaskan Komite Staf Klinis lain untuk menyiapkan kredensial yang merupakan Komite yang sudah ditunjuk oleh Direktur RS Prima Husada.
4. Sub Kredensial mengkaji dan memberikan rekomendasi tindakan profesi staf klinis lain yang diajukan oleh pemohon.
 - a. Kepala Unit dilakukan kredensial oleh Mitra Bestari dari Rumah Sakit lain yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada atau dari Persatuan profesi masing – masing.
 - b. Staf pelaksana dilakukan kredensial oleh Sub Kredensial masing – masing profesi yang sudah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada,
5. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo menerbitkan Surat Penugasan Klinis kepada pemohon berdasarkan rekomendasi tersebut. Setiap staf klinis lain dapat saja memiliki kewenangan klinis yang berbeda diantara satu dengan yang lainnya.

9.1.2 Kajian Mitra Bestari

1. Komite nakes lain menugaskan subkomite kredensial untuk memproses permohonan tersebut.
2. Subkomite kredensial menyiapkan mitra bestari yang berjumlah sekitar 4 hingga 6 orang sesuai dengan bidang keahlian yang akan dinilai. Mitra bestari tersebut tidak harus anggota subkomite kredensial, bahkan dapat dari luar rumah sakit bila di perlukan. Para mitra bestari yang bertugas tersebut dapat terdiri dari beberapa tenaga kesehatan sesuai dengan tenaga kesehatan yang akan dilakukan kredensialing.
3. Mitra bestari mengkaji setiap tindakan medis yang diajukan oleh pemohon. Pengkajian setiap tindakan medis yang diajukan oleh pemohon tersebut dilakukan secara objektif didasarkan pada suatu buku putih (white paper)
4. Selain menilai kompetensi, mitra bestari juga menilai kemampuan pemohon berdasarkan kesehatan fisik dan mental untuk setiap tindakan medis yang diajukan. Rumah sakit mempersiapkan sarana dan prasarana dan panel tenaga kesehatan untuk melakukan uji kesehatan fisik dan mental tersebut.
5. Pada akhir proses kredensial, mitra bestari merekomendasikan sekelompok tindakan tertentu yang boleh dilakukan oleh pemohon di rumah sakit tersebut. Selanjutnya komite/ tim adhoc mengkaji kembali rekomendasi tersebut dan mengadakan beberapa modifikasi bila diperlukan dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rumah sakit.

9.1.3 Rekredensial

Proses Rekredensial mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan tenaga kesehatan lainnya akan bidang kesehatan lain yang ada dan berkembang serta aplikasi pengetahuan tersebut pada perawatan pasien dan menyalurkan ilmu kepada orang lain.
2. Pembelajaran dan perbaikan berbasis praktik dengan menggunakan bukti dan metode ilmiah untuk menyelidiki, mengevaluasi dan memperbaiki praktik-praktik perawatan pasien.
3. Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang memungkinkan mereka untuk membangun dan mempertahankan hubungan profesional dengan pasien, dan anggota-anggota tim perawatan kesehatan lainnya.
4. Profesionalisme tercermin dari komitmen untuk pengembangan profesional berkelanjutan, praktik etis, pemahaman dan kepekaan terhadap keragaman, sikap bertanggung jawab terhadap pasien, profesi mereka, dan masyarakat.
5. Praktik berbasis sistem melalui pemahaman konteks dan sistem dimana pelayanan kesehatan disediakan

9.2 RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK) DAN SURAT PENUGASAN KLINIS (SPK)

9.2.1 Rincian Kewenangan Klinis (RKK)

a. Tata laksana pemberian kewenangan klinis

1. Rumah Sakit mengatur seluruh pelayanan klinis yang dilakukan oleh staf klinis berlangsung aman bagi pasien dan sesuai dengan ketentuan profesi yang berlaku.
2. Rumah Sakit mengatur pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) setiap staf klinis sesuai dengan kompetensi yang nyata.
3. Pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) rumah sakit dapat melibatkan organisasi profesi yang sesuai sebagai pihak yang paling mengetahui masalah keprofesian yang bersangkutan.
4. Pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) untuk setiap tindakan klinis harus dirinci lebih lanjut (delineation of clinical privilege).
5. Rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege) setiap staf klinis di Rumah Sakit ditetapkan oleh Sub Komite Kredensial Profesi Lainnya dengan melibatkan Organisasi Profesi masing-masing profesi.
6. Kewenangan klinis seorang staf klinis diberikan tidak hanya berdasarkan pada kredensial terhadap kompetensi keilmuan dan keterampilannya saja, tetapi juga berdasarkan pada kesehatan fisik, kesehatan mental dan perilaku (behavior) staf klinis tersebut

b. Tata laksana rekomendasi penolakan kewenangan klinis

1. Penolakan rekomendasi kewenangan klinis (clinical privilege) oleh Tim Kredensial Profesi Lainnya dapat disebabkan adanya pelanggaran dari staf klinis terhadap standar profesi atau belum memenuhinya kriteria penilaian pada saat dilakukannya proses kredensial.
2. Penolakan rekomendasi atas pelanggaran dan belum memenuhinya kriteria penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta nyata yang ditemukan serta melalui mekanisme disiplin profesi.

3. Penolakan rekomendasi kewenangan klinis (clinical privilege) akan diinformasikan oleh Sub Komite Kredensial Profesi Lainnya secara tertulis kepada staf klinis yang bersangkutan.
4. Staf klinis diwajibkan memenuhi persyaratan atau tidak melakukan pelanggaran terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam kurun waktu yang ditetapkan disertai dengan tindakan disiplin profesi.
5. Penetapan tindakan disiplin profesi dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Profesi Lainnya dengan melibatkan organisasi profesi terkait setelah melalui proses sidang disiplin profesi (disciplinary tribunal).

9.2.2 Surat Penugasan Klinis (SPK)

Penerbitan Surat Penugasan Klinis (SPK)

1. Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) tenaga kesehatan lain pemohon berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain.
2. Surat Penugasan tersebut memuat daftar sejumlah kewenangan klinis untuk melakukan asuhan dan tindakan sesuai dengan bidang klinisnya.

9.3 PENILAIAN KINERJA TENAGA KESEHATAN LAIN

9.3.1 Kriteria Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja staf klinis memuat 3 (tiga) area

1. Perilaku
2. Pengembangan professional, memuat :
 - Tugas dan tanggung jawab staf
3. Kinerja klinis, memuat :
 - Kompetensi dan kewenangan staf
 - Temuan mutu dalam aktivitas peningkatan mutu

9.3.2 Prosedur Penilaian Kinerja

1. Pengolahan data dilakukan oleh kepala unit masing – masing berdasarkan tindakan, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing – masing staf
2. SDM memberikan rekomendasi penilaian berupa pelanggaran atau perilaku yang dilakukan oleh staf.
3. Penilaian kinerja yang sudah dibuat diajukan kepada kepala bidang terkait untuk dilakukan analisa dan ditindak lanjuti

BAB X

PENUTUP

Pedoman Manajemen Sumber daya Manusia (SDM) disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan perencanaan kebutuhan staf yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam panduan ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 03 November 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes